

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE FOZ DO
IGUAÇU CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE FRONTEIRA - MESTRADO**

Queila da Fonseca Pereira

**Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital
público em região de tríplice fronteira, sobre a continuidade do cuidado e a
atenção domiciliar**

**FOZ DO IGUAÇU
2026**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE FRONTEIRA - MESTRADO

Queila da Fonseca Pereira

Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital público em região de tríplice fronteira, sobre a continuidade do cuidado e a atenção domiciliar

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós- Graduação Saúde Pública em Região de Fronteira - Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito para a obtenção do título de Mestra em Saúde Pública.

Área de concentração: Saúde Pública em Região de Fronteira

Orientadora: Prof. Dra. Luciana Aparecida Fabriz

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Fonseca Pereira, Queila da
Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital público em região de triplíce fronteira, sobre a continuidade do cuidado e a atenção domiciliar / Queila da Fonseca Pereira; orientadora Luciana Aparecida Fabriz. -- Foz do Iguaçu, 2026.
119 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu)
-- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, 2026.

1. Cuidadores. 2. Continuidade de assistência ao paciente.
3. Serviço de assistência domiciliar. 4. Áreas de fronteira.
I. Fabriz, Luciana Aparecida, orient. II. Título.

PEREIRA, Q.F.P. Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital público em região de tríplice fronteira, sobre a continuidade do cuidado e a atenção domiciliar. 2026. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) - Centro de Educação, Letras e Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

Aprovado em: 25/02/2026

Banca Examinadora

Orientadora: Profª. Dra. Luciana Aparecida Fabríz

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Julgamento: Aprovado

Documento assinado digitalmente
 **LUCIANA APARECIDA FABRIZ**
Data: 07/04/2026 09:51:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Helder Ferreira

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Julgamento: Aprovado

Documento assinado digitalmente
 **HELDER FERREIRA**
Data: 13/04/2026 13:05:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª. Dra. Ione Carvalho Pinto

Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São

Julgamento: Aprovado

Documento assinado digitalmente
 **IONE CARVALHO PINTO**
Data: 15/04/2026 17:09:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida e pela oportunidade de realizar este estudo.

À minha família, pelo apoio incondicional em todas as etapas desta jornada.

À minha orientadora, Profa. Dra. Luciana Aparecida Fabríz, pela paciência e dedicação ao me direcionar com esmero no desenvolvimento desta dissertação.

Aos professores Dr. Helder Ferreira e Dra. Ione Carvalho Pinto, que participaram das bancas de qualificação e defesa, contribuindo de forma imprescindível para o desenvolvimento e desfecho desta dissertação.

Aos cuidadores que se dispuseram a participar da pesquisa, pela confiança e presteza nas entrevistas.

À enfermeira Isabela Delazari, pela colaboração e incentivo durante o percurso do mestrado.

À diretoria do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que autorizou o campo para a pesquisa, e ao serviço de Desospitalização, que gentilmente forneceu acesso aos dados pertinentes para o desenvolvimento do estudo.

A todos os professores do Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira, que contribuíram para a construção do projeto de pesquisa.

E, por fim, a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a construção e finalização desta dissertação.

PEREIRA, Q. F. P. **Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital público em região de tríplice fronteira, sobre a continuidade do cuidado e a atenção domiciliar.** 2026. 116f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) - Centro de Educação, Letras e Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMO

A desospitalização é um serviço vinculado à Atenção Domiciliar que tem desenvolvido a continuidade do cuidado no Brasil, embora regulamentada no SUS, ainda apresenta lacunas que necessitam ser estudadas. Neste estudo objetivou-se analisar a continuidade do cuidado do hospital para a atenção domiciliar, na perspectiva de cuidadores de usuários adultos que estiveram internados em unidade de clínica médica em um hospital público em região de tríplice fronteira. Possui abordagem qualitativa e exploratória, foram entrevistados 12 cuidadores no período de abril a agosto de 2025. A Análise de conteúdo, na modalidade temática proposta por Minayo foi utilizada, resultando em 5 categorias e 18 subcategorias, sendo elas respectivamente: 1-Planejamento e abordagem médica para a alta (Informação efetiva e acolhedora; Abordagem limitada e pouco segura; alta planejada e comunicada ao cuidador; Ausência e descontinuidade do planejamento no preparo da alta); 2-Comunicação entre a equipe de saúde e o cuidador (Atendimento e comunicação da equipe de saúde com o cuidador, Comunicação fragilizada e desarticulada entre a equipe de saúde e entre a equipe e o cuidador durante a internação); 3-Autonomia e segurança terapêutica (Compreensão das orientações da terapia medicamentosa, Lacuna em orientação sobre uso do medicamento); 4-Educação em saúde para o cuidado domiciliar (Preparo do cuidador durante internação, para desempenhar cuidados no domicílio; Ausência do preparo do cuidador para desempenhar os cuidados domiciliares; Habilidade para desempenhar os cuidados fortalecida pela educação em saúde e cuidador experiente, Orientação insuficiente para os cuidados domiciliares); 5-Continuidade do cuidado (Alta com relatório médico e encaminhamento ambulatorial; Falha no encaminhamento ambulatorial; Barreiras no acesso aos medicamentos e materiais médico-hospitalares para os cuidados domiciliares; Percepção do cuidador sobre a visita domiciliar; Falta de encaminhamento médico para o SAD; Dificuldades no cuidado). O estudo evidenciou falhas na continuidade do cuidado; a sobrecarga do cuidado; a judicialização do acesso a direitos e a responsabilização das famílias pelo cuidado; fragilidades do sistema de saúde; considerando que em regiões de fronteira, a demanda é ampliada pelo fluxo populacional e pelo subfinanciamento dos serviços.

Palavras-chave: Cuidadores; Continuidade da Assistência ao Paciente; Serviços de Assistência Domiciliar; Áreas de Fronteira

PEREIRA, Q. F. P. Perception of caregivers of adult patients treated at a public hospital in a tri-border region regarding continuity of care and home care. 2026. 116f. Dissertation (Master's in Public Health) – Center for Education, Literature and Health, State University of Western Paraná, Foz do Iguaçu, 2026.

ABSTRACT

Dehospitalization is a service linked to Home Care that has developed the continuity of care in Brazil, although regulated in the SUS, it still has gaps that need to be studied. The objective of this study was to analyze the continuity of care from hospital to home care, from the perspective of caregivers of adult users who were hospitalized in a medical clinic unit in a public hospital in a triple border region. It has a qualitative and exploratory approach, 12 caregivers were interviewed from April to August 2025. Content analysis, in the thematic modality proposed by Minayo, was used, resulting in 5 categories and 18 subcategories, namely, respectively: 1-Planning and medical approach to discharge (Effective and welcoming information; Limited and unsafe approach; discharge planned and communicated to the caregiver; Absence and discontinuity of planning in preparation for discharge); 2-Communication between the health team and the caregiver (Care and communication between the health team and the caregiver, Weakened and disjointed communication between the health team and between the team and the caregiver during hospitalization); 3-Autonomy and therapeutic safety (Understanding of drug therapy guidelines, Gap in guidance on medication use); 4-Health education for home care (Preparation of the caregiver during hospitalization, to perform care at home; Lack of preparation of the caregiver to perform home care; Ability to perform care strengthened by health education and experienced caregiver, Insufficient guidance for home care); 5-Continuity of care (Discharge with medical report and outpatient referral; Failure in outpatient referral; Barriers in access to medicines and medical-hospital materials for home care; Caregiver's perception of home visits; Lack of medical referral to the SAD; Difficulties in care). The study evidenced failures in the continuity of care; the burden of care; the judicialization of access to rights and the accountability of families for care; weaknesses in the health system; Considering that in border regions, the demand is amplified by the population flow and the underfunding of services.

Keywords: Caregivers; Continuity of Patient Care; Home Care Services; Border Areas.

PEREIRA, Q. F. P. Percepción de los cuidadores de usuarios adultos atendidos en un hospital público de una región de triple frontera, respecto a la continuidad del cuidado y la atención domiciliaria. 2026. 116f. Disertación (Maestría en Salud Pública) – Centro de Educación, Letras y Salud, Universidad del Estado del Oeste del Paraná, Foz do Iguazú, 2026.

RESUMEN

La deshospitalización es un servicio vinculado a la atención domiciliaria que ha desarrollado la continuidad de la atención en Brasil, aunque regulado en la SUS, aún presenta carencias que necesitan ser estudiadas. El objetivo de este estudio fue analizar la continuidad de la atención desde el hospital hasta el hogar, desde la perspectiva de cuidadores de adultos que fueron hospitalizados en una unidad de clínica médica en un hospital público de una región triple fronteriza. Tiene un enfoque cualitativo y exploratorio; se entrevistaron a 12 cuidadores entre abril y agosto de 2025. Se utilizó análisis de contenido, en la modalidad temática propuesta por Minayo, que resultó en 5 categorías y 18 subcategorías, a saber: 1-Planificación y enfoque médico del alta (información efectiva y acogedora; Aproximación limitada e insegura; la alta planificada y comunicada al cuidador; ausencia y discontinuidad de la planificación en preparación para el despido); 2-Comunicación entre el equipo de salud y el cuidador (cuidado y comunicación entre el equipo de salud y el cuidador, comunicación debilitada y fragmentada entre el equipo de salud y entre el equipo y el cuidador durante la hospitalización); 3-Autonomía y seguridad terapéutica (comprensión de las directrices de terapia farmacológica, brecha en las directrices sobre el uso de medicación); 4-Educación sanitaria para cuidados domiciliarios (preparación del cuidador durante la hospitalización, para realizar cuidados en casa; Falta de preparación del cuidador para realizar el cuidado domiciliario; Capacidad para realizar cuidados reforzada por educación sanitaria y cuidador experimentado, orientación insuficiente para el cuidado domiciliario); 5-Continuidad de la atención (alta con informe médico y derivación ambulatoria; Fallo en la derivación ambulatoria; Barreras en el acceso a medicamentos y materiales médico-hospitalarios para atención domiciliaria; la percepción del cuidador sobre las visitas domiciliarias; Falta de derivación médica al SAD; dificultades en el cuidado). El estudio evidenció fallos en la continuidad de la atención; la carga del cuidado; la judicialización del acceso a los derechos y la rendición de cuentas de las familias en cuanto al cuidado; debilidades en el sistema sanitario; Teniendo en cuenta que en las regiones fronterizas la demanda se amplifica por el flujo de población y la falta de financiación de los servicios.

Palabras clave: cuidadores; Continuidad de la atención al paciente; Servicios de Cuidado a Domicilio; Zonas fronterizas.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fronteiras Brasileiras	21
Figura 2 – Domínios da transição ideal do cuidado	25
Figura 3 – Fluxograma Adaptado Prisma.....	41
Figura 4 – Localização geográfica da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina	42

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Legislações que regulamentam a Atenção Domiciliar	27
Quadro 2 – Recomendações para a continuidade do cuidado durante a desospitalização	31
Quadro 3 – Síntese das semelhanças entre os modelos de transição do cuidado e desospitalização	32
Quadro 4 – Estratégia de Busca	38
Quadro 5 – Leitos Hospitalares do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.....	51
Quadro 6 – Objetivos específicos com os eixos da continuidade do cuidado	61
Quadro 7 – Resultados sintetizados	43
Quadro 8 – O Tipos de abordagem metodológicas	47
Quadro 9 – Categorias e Subcategorias.....	65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão dos participantes.....	41
Tabela 2 - Dados Sociodemográficos dos participantes	64

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ACL – Análises de Classes Latentes

AD – Atenção Domiciliar

APS – Atenção Primária à Saúde

BVS – Biblioteca Virtual em Saúde

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa

CGAD – Coordenação-Geral de Atenção

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CMI – Centro Materno Infantil

CNS – Conselho Nacional de Saúde

EMAD – Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar

EMAP – Equipes Multiprofissionais de Apoio

ESF – Estratégia Saúde da Família

FMS – Fundação Municipal de Saúde

GT SAÚDE – Grupo de Trabalho Itaipu Saúde da Fronteira

HMPGL – Hospital Municipal Padre Germano Lauck

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

MP – Migração Pendular

MS – Ministério da Saúde

NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família

OPAT – Terapia Antimicrobiana Parenteral Ambulatorial

OR – *Odds Ratio*

PMcC – Programa Melhor em Casa

PTS – Plano Terapêutico Singular

RAS – Redes de Atenção à Saúde

RUE – Rede de Urgência e Emergência

SAD – Serviço de Atenção Domiciliar

SBI – Sociedade Brasileira de Infectologia

SIS-FRONTEIRA – Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras

SPSS – *Statistical Package for the Social Sciences*

SUS – Sistema Único de Saúde

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UBS – Unidade Básica de Saúde

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

VA-GRACE – *Geriatric Resources for Assessment and Care of Elders*

VD-HCBS – Serviços Domiciliares e Comunitários Dirigidos por Veteranos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. OBJETIVOS	16
7.3 OBJETIVO GERAL.....	16
7.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
3. JUSTIFICATIVA	17
4. PRESSUPOSTO	19
5. QUADRO TEÓRICO	20
7.3 SAÚDE NA FRONTEIRA.....	20
7.4 TRANSIÇÃO DO CUIDADO	22
7.5 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE	27
7.5.1 Atenção Domiciliar	27
7.5.2 Desospitalização	29
7.5.3 A Desospitalização e a Continuidade do Cuidado	32
6. PERCURSO METODOLÓGICO	37
6.1 PRIMEIRA ETAPA: REVISÃO DA LITERATURA POR <i>SCOPING REVIEW</i> ...	38
6.2 SEGUNDA ETAPA ABORDAGEM QUALITATIVA	41
6.2.1 CENÁRIO DO ESTUDO	41
6.2.2 POPULAÇÃO	45
6.2.3 Coleta de dados	46
6.2.4 Processamento e Análise de dados	48
6.3 RISCOS DA PESQUISA	49
6.4 BENEFÍCIOS DA PESQUISA	50
7. RESULTADOS	51
7.1 PRIMEIRA ESTAPA	51
7.2 SEGUNDA ETAPA	63
7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES	63
7.4 ENTREVISTAS COM OS PARTICIPANTES	64
8. DISCUSSÃO	89

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	99
REFERÊNCIAS	101
APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PORTUGUÊS	107
APÊNDICE B – GUÍA DE ENTREVISTA EN ESPAÑOL	109
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)	111
APÊNDICE D – FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO	113
ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA	115

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional ocorre naturalmente no mundo, e vem se apresentando de forma acelerada no Brasil e consequentemente alterando o padrão de doenças mais prevalentes na população, acarretando maior procura por cuidados de saúde devido um aumento das doenças crônico degenerativas, incapacidades físicas e cognitivas e por causa das hospitalizações (Miranda *et al.*, 2023).

Mas esse não é o único fator que tem desencadeado essa preocupação e necessidade de remodelação nos serviços de atenção à saúde, há outras necessidades de saúde que demandam um cuidado contínuo, como os cuidados com bebês prematuros, crianças com sequelas e doenças degenerativas, adultos com múltiplas doenças crônico degenerativas, indivíduos com necessidade de cuidados paliativos, de suporte à vida e de reabilitação, fazendo emergir novos modelos de cuidado (Rajão; Martins, 2020).

Essa transição do perfil sociodemográfico e epidemiológico, no Brasil e no mundo, provoca a urgência de novas políticas em saúde, fazendo com que diversos países comecem a desenvolver programas e políticas voltadas para a Atenção Domiciliar (AD) (Rajão; Martins, 2020).

No Brasil, atualmente a AD é regulamentada pela Portaria GM/MS Nº 3.005, de 2 de janeiro de 2024. O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é composto por uma equipe multidisciplinar, que realiza visitas domiciliares ao usuário com necessidades de cuidados contínuos. Para ter acesso ao SAD o usuário é encaminhado pelo hospital em que está internado ou por solicitação da equipe de Saúde da Família/Atenção Básica ou da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (Rosseto *et al.*, 2023).

A AD é considerada um ponto estratégico para atender essas necessidades de saúde, a implementação dessa modalidade de atendimento em vários países ocorre, concomitante, ao interesse dos sistemas de saúde no processo de desospitalização, que proporciona a otimização de leitos hospitalares, diminuição dos custos e um planejamento do cuidado que priorize o usuário (Rajão; Martins, 2020).

Deste modo, pode-se elencar como alguns objetivos da AD, a diminuição da demanda pela assistência hospitalar, a redução da permanência de internações, a humanização promovendo a autonomia dos usuários e a desinstitucionalização e racionalização dos recursos das Redes de Atenção à Saúde (RAS), destacando o acompanhamento das pessoas com patologias crônicas em domicílio (Rosseto *et al.*, 2023).

A desospitalização pode ocorrer quando o usuário apresenta estabilidade clínica, mas precisa continuar o tratamento com o acompanhamento de um profissional e o uso de dispositivos médicos/hospitalares, para isso é definido um cuidador de referência que deverá receber treinamento da equipe multidisciplinar ainda no ambiente hospitalar (Borges *et al.*, 2023).

A abordagem realizada pela equipe multidisciplinar com o cuidador contempla a capacitação prática ainda no ambiente intra-hospitalar, em conjunto com o acompanhamento após a alta, com o propósito de promover a segurança no processo de adaptação desse cuidador e diminuir possíveis reinternações por falhas no cuidado domiciliar (Borges *et al.*, 2023).

Para Miranda *et al.* (2023) um dos componentes fundamentais no processo da desospitalização é a educação em saúde no âmbito domiciliar, pois esta ação promove a apropriação pelo cuidador e usuário do conhecimento para as tomadas de decisões em relação ao cuidado necessário para a reabilitação, e essa autonomia faz com que tanto o cuidador quanto o usuário desenvolvam novas habilidades possibilitando uma participação efetiva no autocuidado.

A continuidade desse cuidado no ambiente domiciliar com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional de saúde é fundamental, porém nas regiões de fronteira existem particularidades que acabam se configurando em barreiras, como por exemplo a Migração Pendular (MP).

Pereira e Carvalho (2022) definem a MP como o movimento cotidiano dos residentes fronteiriços, entre o seu local de moradia, local de trabalho ou estudo, e principalmente na procura por atendimento em saúde, impactando muitas vezes no planejamento da assistência, pois a efetividade do tratamento é prejudicada pela demora em determinar um diagnóstico e o acesso precário. Nas regiões de fronteiras internacionais, por exemplo (Brasil, Paraguai e Argentina) isto se torna um agravo ainda maior, pois quando dois países que tem fronteira entre si apresentam assimetria sociais e econômicas, ou seja, uma diferença na oferta e qualidade nos serviços de saúde, rotineiramente o número de atendimentos excede ao número da população sobre a qual é feito o cálculo para o repasse de verbas para o sistema municipal, como ocorre na cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, e isso configura-se como uma barreira para o acesso dos residentes fronteiriços aos serviços de saúde.

Os serviços de saúde do Brasil, nas regiões de fronteira, têm sido comumente utilizados por estrangeiros, porém estes atendimentos geralmente ocorrem em caráter de emergência, o

que compromete a continuidade do atendimento e dificulta a vigilância e o controle epidemiológico de doenças (Aikes; Rizzotto, 2020).

No contexto da fronteira, levando em consideração sua complexidade, o entendimento desta região precisa ir além de limites territoriais, devendo ser considerados os elementos de conflitos que impactam na determinação social do processo saúde e doença, tendo como preocupação a necessidade de políticas públicas de cooperação transfronteiriça que promovam o desenvolvimento econômico integrado (Carvalho, 2022).

Diante o exposto, o presente estudo tem como pergunta de pesquisa: Como foi a experiência de cuidadores de usuários adultos internados em unidade de clínica médica em um hospital público em região de tríplice fronteira, sobre a continuidade do cuidado e o serviço de atenção domiciliar?

Esta indagação surgiu a partir da minha formação e experiência como enfermeira assistencial em setores de clínica médica de um hospital público em região de fronteira, onde atuei por 9 anos na assistência direta ao paciente, esta vivência contribuiu para o desenvolvimento de um olhar atento às questões relacionadas a desospitalização. No ambiente hospitalar da rede pública é comum a superlotação dos setores, e a necessidade da rotatividade dos leitos é de extrema importância, porém ao longo da minha experiência emergiram inquietações acerca de como esses cuidadores recebiam a responsabilidade sobre os cuidados de seus familiares, pois era perceptível a dificuldade em alguns aspectos (organização do domicílio, treinamento com a equipe para os cuidados domiciliares, entre outros).

Assim, esta dissertação busca analisar a percepção dos cuidadores sobre a continuidade do cuidado e o serviço de atenção domiciliar, alinhando minha trajetória profissional à linha de pesquisa em Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública em Região de Fronteira.

A análise das experiências dos cuidadores referentes ao seu preparo no ambiente intrahospitalar; no atendimento domiciliar pela equipe do SAD e sobre as potencialidades e fragilidades encontrados por eles nesse processo, evidencia a realidade do usuário da rede de atenção à saúde, na atenção domiciliar, em região de fronteira. Diante do exposto, este estudo poderá fornecer informações para que os profissionais e gestores possam implementar a melhoria do cuidado e desenvolver ações para diminuir a lacuna entre o hospital e o SAD, haja visto que este modelo de atenção à saúde é inovador e a importância e os benefícios que a desospitalização apresenta para os usuários e para as instituições de saúde.

2. OBJETIVOS

7.3 OBJETIVO GERAL

Analisar a continuidade do cuidado do hospital para a atenção domiciliar, na perspectiva de cuidadores de usuários adultos que estiveram internados em unidade de clínica médica em um hospital público em região de tríplice fronteira.

7.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mapear as evidências científicas acerca da avaliação da satisfação de usuários adultos e/ ou cuidadores sobre o Serviço de Atenção Domiciliar.

Identificar como aconteceu a continuidade do cuidado no ambiente hospitalar na perspectiva do cuidador;

Descrever a experiência dos cuidadores sobre o seu preparo para desempenhar os cuidados no domicílio;

Explorar a percepção do cuidador sobre a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar na continuidade do cuidado.

Analisar as potencialidades e fragilidades relatadas pelos cuidadores na continuidade do cuidado.

3. JUSTIFICATIVA

A desospitalização é um serviço vinculado à Atenção Domiciliar que tem desenvolvido a continuidade do cuidado no Brasil, embora desde 2002 tenha sido regulamentada a Assistência Domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS), pela Lei n. 40.424, de 15 de abril de 2002; a Transição do Cuidado em si ainda está em desenvolvimento no país e apresenta lacunas que necessitam ser estudadas.

Valente *et al.* (2022) realizaram uma pesquisa qualitativa, na qual participaram 15 técnicos de enfermagem que trabalhavam diretamente na assistência a pessoas idosas hospitalizadas em uma instituição pública de médio porte, no interior do estado de São Paulo. Neste estudo apenas um dos profissionais participantes conhecia o conceito “Transição do Cuidado”, a ausência de uma sistematização das ações assistenciais e de um protocolo para a realização da continuidade do cuidado foi sinalizado como uma fragilidade no atendimento aos usuários.

Tomazela *et al.* (2023) desenvolveram um estudo observacional transversal, realizado com 156 idosos, após internação hospitalar em um hospital público, no estado de São Paulo, e identificaram fragilidades no Plano de Cuidados, evidenciando a necessidade de incluir os cuidadores como participantes no planejamento dos cuidados a fim de melhorar a qualidade da Transição do Cuidado.

A região de fronteira apresenta fatores socioculturais diversos que precisam ser ponderados no desenvolvimento das políticas públicas em geral, tendo este espaço como objeto de estudos, pois essas localidades possuem especificidades que vão além do espaço geográfico e são influenciadas pela multiculturalidade e suas relações e inter-relações únicas (Feitosa; Martins; Jaqueira, 2020).

As políticas públicas de saúde, são fundamentais para promover as mudanças que precisam ser implementadas considerando o perfil demográfico, socioeconômico, epidemiológico e dos sistemas de cuidados de saúde (Brasil, 2020).

No mês de abril de 2024 uma pesquisa preliminar foi realizada em bases de dados PubMed, Scopus e nas bases integradas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME), com restrição temporal dos últimos 5 anos, de acerca dos temas: preparo de cuidadores na desospitalização; continuidade do cuidado de adultos em região de fronteira e avaliação do serviço de atenção domiciliar em região fronteira, porém não foram encontrados estudos atuais sobre o assunto.

Desta forma, esta pesquisa poderá demonstrar a experiência dos cuidadores de usuários adultos do serviço de desospitalização de um hospital público que vivem na região de fronteira e tem potencial para embasar as decisões de profissionais e gestores sobre a melhoria ou elaboração de novas políticas públicas que possam aprimorar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde da população que reside ou transita nas regiões de fronteira.

4. PRESSUPOSTO

Pressupõe-se que os cuidadores dos usuários do serviço de desospitalização tiveram uma participação ativa no processo da continuidade do cuidado desde o primeiro dia da internação, colaboraram no planejamento da alta, receberam treinamento adequado para manusear os dispositivos médicos quando indicado e para realizarem todo e quaisquer procedimentos que o paciente necessitasse receber no domicílio, receberam as orientações da equipe multidisciplinar referente ao modo, intervalo, doses e possíveis efeitos adversos das medicações, bem como sobre as reconciliações e mudanças na medicação.

Acredita-se que os cuidadores receberam as orientações por escrito com um resumo da alta contendo todas as informações pertinentes, tais como: diagnóstico principal que ocasionou a internação; comorbidades; tratamento instituído no ocasião da internação; receita com todos os medicamentos que o paciente necessita para a continuidade do tratamento e os medicamentos de uso contínuo; encaminhamentos para os serviços de referência e especialidades que forem necessárias; com retorno agendado em um período de uma semana e visita domiciliar pela equipe do SAD.

5. QUADRO TEÓRICO

7.3 SAÚDE NA FRONTEIRA

A fronteira delimita a área de soberania de cada país por linhas imaginárias, podendo ser naturais (rios, montanhas, florestas) ou artificiais (muros, pontes ou aduanas com atuação de forças policiais de fiscalização) (Carniel; Matos, 2022). Com o decorrer do tempo, esses espaços sofrem transformações históricas e geográficas, e a compreensão de fronteira incorpora novas propriedades. Para discutir sobre fronteira é necessário apropriar-se das questões sociais, culturais, políticas e econômicas, pois o ambiente de fronteira é um lugar de interações biossociais (Mondardo; Staliano, 2020).

A saúde na fronteira tem sido discutida e incorporada às políticas públicas no território nacional, a lei 8.080 de 1990, que regulamenta o SUS, determina a saúde como um direito fundamental do ser humano, e por outro lado como o dever do Estado a formulação e execução de políticas econômicas e sociais para a redução de riscos de doenças e outros agravos, como também a garantia ao acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil, 1990).

As políticas públicas desenvolvidas no âmbito do SUS devem cumprir os princípios que o regem, sendo a equidade um deles. O princípio de equidade determina que os serviços de saúde devem ser ofertados levando em consideração as diferentes condições de vida, saúde e necessidades do indivíduo, devendo atender as diversidades socioculturais, não podendo haver nenhuma discriminação de raça, cor, crença, idade, gênero, nacionalidade, etnia, orientação sexual, estado de saúde, condições socioeconômicas, escolaridade, limitações físicas ou intelectual (Paraná, 2024).

A fronteira também é um lugar onde ocorrem incongruências transculturais e conflitos de identidade devido à preocupação com a segurança nacional e a deficiência em políticas públicas de cooperação internacional que possam proporcionar o desenvolvimento econômico de forma integrada. Os gestores no momento da formulação das políticas de saúde para as regiões de fronteira devem levar em consideração as características deste espaço, demonstrado pelos indicadores sociodemográficos e sanitários da população fronteiriça (Haum; Carvalho, 2021).

O Brasil compartilha áreas de fronteira com 10 países sul-americanos, são 588 municípios divididos em 11 estados, dentre estes 139 estão localizados no estado do Paraná

(Haum; Carvalho, 2021). Apenas no estado do Paraná a estimativa de migrantes é aproximadamente 4.500 pessoas de nacionalidades diversas como: haitianos, sírios, africanos, venezuelanos, paraguaios e argentinos. Essa população migrante frequentemente está em situações de vulnerabilidade, como desemprego ou trabalho com condições precárias, habitação inadequada, discriminação, preconceito, e outras formas de violência, conflitos culturais e comunicação insuficiente. Essas situações causam agravamento dos problemas de saúde, e nas áreas de fronteira, geram um aumento do número de pessoas que cruzam a fronteira na procura de acesso à saúde no SUS (Paraná, 2020).

Figura 1 – Fronteiras Brasileiras



Fonte: Geoblogger (2015)

A migração pendular (MP) é a mobilidade da vida cotidiana das pessoas que residem em um município, mas se deslocam para outro em virtude de trabalho ou estudo, é diferente da migração, onde ocorre a fixação da residência para outro local. Quando se discute a MP internacional que ocorre na busca dos serviços de saúde pública, encontra-se uma complexidade maior, esta é uma situação comumente encontrada nas regiões de fronteiras no Brasil, por exemplo na tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai. Isso ocorre quando os países que possuem fronteira apresentam assimetria no nível socioeconômico e na oferta e qualidade dos serviços de saúde (Pereira; Carvalho, 2022).

Em um estudo de *Scoping Review* de Hortelan *et al.* (2019) buscou conhecer a produção científica sobre o papel do gestor na gestão em saúde pública nas regiões de fronteira, e

demonstrou que gestores atuantes em região de fronteira do Brasil atendem estrangeiros nos serviços de urgência e emergência, nas unidades básicas de saúde e especializada, sendo um dos problemas dessa região os repasses financeiros e a ausência de acordos bilaterais entre os países fronteiriços.

No estudo de Hortelan *et al.* (2019), é discutido que os déficits nas contas públicas destes municípios não devem ser atribuídos apenas aos pacientes estrangeiros, pois há também problemas de gestão municipal, como déficits de funcionários nos centros para atendimento especializado e meios de locomoção para ambulatório.

Pereira e Carvalho *et al.* (2022) concordam que problemas relacionados ao subfinanciamento do SUS não ocorrem apenas em áreas de fronteira, o que leva a crer que essa defasagem não ocorre por sobrecarga devido a assistência prestada ao estrangeiro, porém essa forma de pensar leva os gestores municipais a optarem por ofertarem a esse público apenas serviços de urgência e emergência e restringirem o atendimento a serviços especializados e de alta complexidade.

Apesar desse cenário, avanços têm sido alcançados em termos de políticas públicas em prol da população fronteiriça, uma das conquistas foi a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 que institui a lei de migração, que dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Os residentes fronteiriços, definidos como: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que tem a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho, passam a ter direitos com o propósito de integração e desenvolvimento das regiões de fronteira, por meio de incentivo a articulação de políticas públicas regionais (Brasil, 2017).

No artigo terceiro na lei da política migratória brasileira, se destacam as diretrizes de universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; repúdio à xenofobia, racismo ou outra forma de discriminação, e principalmente, coloca como um direito do migrante o acesso de forma igualitária e livre aos serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social (Brasil, 2017).

7.4 TRANSIÇÃO DO CUIDADO

A transição do cuidado engloba a mudança de ambiente, forma ou condições, que exigem adaptações dos indivíduos que a vivenciam; a transição do ambiente hospitalar para o domicílio

é comumente considerada complexa, sendo necessário o planejamento de ações que tem por finalidade assegurar a continuidade dos cuidados, ações estas que precisam iniciar na admissão, continuar no período da internação até a alta e após a alta hospitalar (Santos *et al.*, 2024).

Neste capítulo será discutido os estudos desenvolvidos por dois pesquisadores que possuem relevância na pesquisa sobre a Transição do Cuidado, o primeiro Dr. Eric Coleman na Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado em 2003, pesquisou a Intervenção de Transição de Cuidado por meio de ensaios clínicos aleatórios e reduziu as taxas de readmissão em várias populações.

O segundo pesquisador, Dr. Robert Burke é Diretor de Pesquisa da Seção de Medicina Hospitalar, na Pensilvânia no Estados Unidos da América, sua pesquisa contribuiu como um guia com um vocabulário comum para a realização da Transição ideal de Cuidados com o objetivo principal de reduzir as readmissões hospitalares (Burke *et al.*, 2013).

As preocupações com o aumento dos custos de saúde em nível mundial fizeram surgir novos estudos que buscam otimizar esses gastos, na procura por soluções aplicáveis, tanto na redução dos custos quanto na melhora da qualidade do atendimento, colocando a redução de readmissões hospitalares como prioridade (Burke *et al.*, 2013).

Coleman *et al.* (2006) relata que usuários portadores de doenças crônicas geralmente não conseguem autogerenciar o cuidado, pois recebem informações conflitantes quando transitam pelos vários ambientes de saúde e são atendidos por diferentes profissionais, comprometendo assim a qualidade e a segurança durante esse período de vulnerabilidade em que o usuário se encontra.

Neste contexto é comum que o usuário receba prescrições de medicamentos de diferentes profissionais que raramente tem acesso a lista de todos os medicamentos que o usuário está usando. Esse tipo de situação contribui para aumentar a incidência de internações, levando ao aumento dos custos em saúde (Coleman *et al.*, 2006).

Frente a isso Coleman *et al.* (2006) justifica que o usuário e seu cuidador são a única ligação que se move nos vários lugares de atendimento em saúde, constituindo assim, ambos (usuário e cuidador) como o centro indicado para uma intervenção na busca de melhorar a qualidade dos cuidados de transição.

Nesta linha de raciocínio Coleman *et al.* (2006) desenvolveu em seu estudo uma intervenção no cuidado como uma forma de treinamento do usuário e seu cuidador, utilizando um sistema de coach, onde enfermeiros treinados atuaram como orientadores, com o objetivo

de fazer com que os usuários e seus cuidadores assumissem uma postura mais ativa na transição de cuidados e na coordenação e continuidade do cuidado em todos os ambientes de saúde.

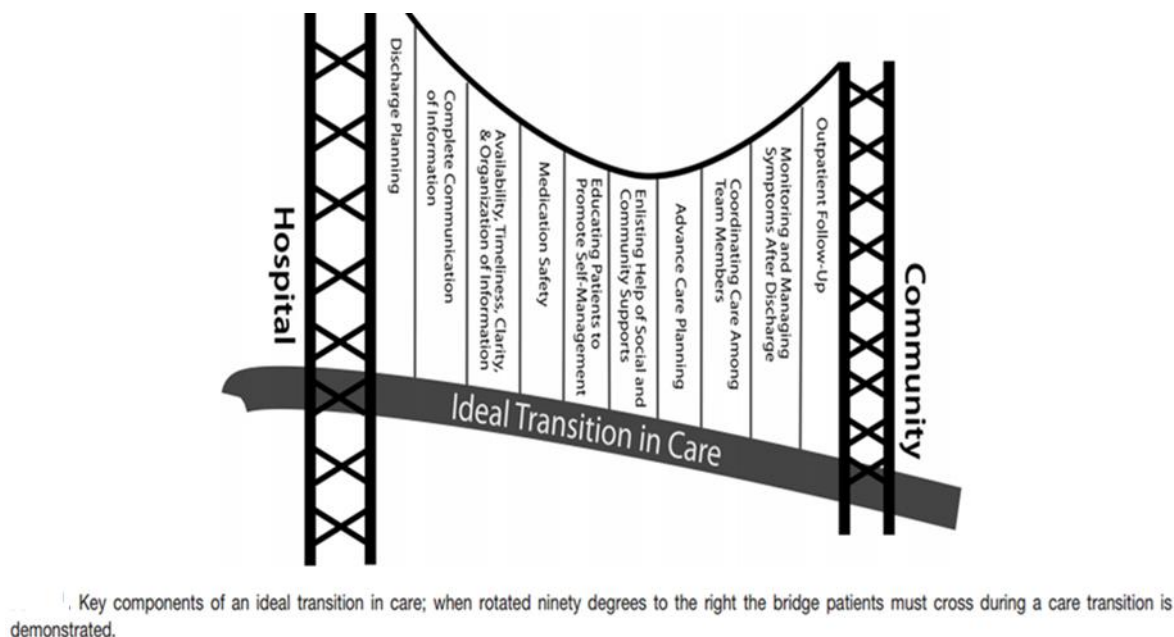
Para isso, foram definidos no estudo 4 pilares: (1) assistência no autogerenciamento de medicamentos: o enfermeiro coach realizado a revisão e reconciliação medicamentosa, orientando sobre as doses e possíveis efeitos colaterais, (2) um registro centrado no usuário, realizado e mantido pelo usuário para facilitar a transferência de informações entre locais, (3) acompanhamento oportuno com cuidados primários ou especializados e (4) uma lista de "bandeiras vermelhas" indicativas de uma condição de agravamento e instruções sobre como responder a elas. Esses 4 pilares foram trabalhados em duas etapas: 1 – Um registro pessoal de saúde; 2 – Uma série de visitas e telefonemas com o enfermeiro treinadores de transição (Coleman *et al.*, 2006).

Nas visitas domiciliares os enfermeiros *coaches* de transição revisaram os medicamentos para ter certeza que não restaram dúvidas sobre as doses e efeitos das medicações, trabalharam para desenvolver a capacidade de comunicação dos usuários e seus cuidadores para comunicar as suas necessidades aos diferentes profissionais de saúde, através de simulações, e também revisaram sobre os sinais de alerta que pudessem indicar uma piora na condição de saúde do usuário, orientando como proceder nesses casos e quando entrar em contato com o profissional de saúde. Após a visita domiciliar, realizou-se telefonemas 3 vezes no período de alta após a hospitalização (Coleman *et al.*, 2006).

Neste estudo realizado por Coleman *et al.* (2006) obteve-se um melhor conhecimento e habilidades de autogerenciamento para muitos usuários, especialmente na área de medicamentos, gerenciamento de condições de autoconfiança. Tendo o usuário como centro, com foco para garantir que as necessidades de cuidados sejam atendidas, pode-se concluir que a intervenção de transição de cuidados pode diminuir as reinternações hospitalares, sendo promissora para discutir as graves deficiências de qualidade que acontecem na transição do cuidado.

Burke *et al.* (2013) em seus estudos discutem sobre a necessidade de aprimorar a qualidade das transições do cuidado quando os usuários recebem a alta hospitalar e propõem alguns componentes para uma transição ideal no cuidado através de domínios, como demonstra a Figura 2.

Figura 2 – Domínios da transição ideal do cuidado



Fonte: Burke *et al.* (2013)

A figura acima faz um resumo do conteúdo de cada um dos domínios, formando uma “ponte” que representa a forma como deve ocorrer a transição ideal do cuidado, com os domínios que ocorrem antes da alta mais próximos do “lado do hospital” na ponte, e aqueles que ocorrem após a alta são colocados mais próximos do “lado da comunidade” na ponte, enquanto aqueles que ocorrem antes e depois da alta estão ao centro (Burke *et al.*, 2013).

A seguir demonstra-se os 10 domínios para uma transição ideal do cuidado:

Planejamento de Alta: Planejar a alta com antecedência, mesmo antes do término do tratamento hospitalar quando o usuário ainda está sendo tratado no hospital, o plano de alta deve ser criado pela equipe multidisciplinar com agendamento de consultas para o acompanhamento considerando os horários adequados para o usuário e o cuidador.

Comunicação Completa de Informações: Indica-se a realização de um resumo de alta ou outras formas de transferir as informações do hospital para o atendimento ambulatorial. Este relatório da alta deve obrigatoriamente conter as informações pertinentes de forma clara, objetiva e organizada, possibilitando que o profissional que irá assumir os cuidados do usuário no pós- alta consiga compreender rapidamente as informações.

Segurança da Medicação: Os medicamentos são responsáveis pela grande maioria dos eventos adversos no pós-alta, é indicado realizar um histórico das medicações, realizar a

reconciliação medicamentosa e comunicar as alterações ao usuário e a todos os profissionais envolvidos na transição de cuidados.

Educação do Usuário e Promoção da Autogestão: Constitui-se na prática de orientar o usuário e o cuidador sobre os principais diagnósticos e treiná-los para os cuidados, inclusive sobre as medicações e como identificar qual profissional contactar em caso de necessidade, é preciso ter certeza de que as orientações foram compreendidas e se for necessário repeti-las, fornecer ao cuidador materiais didáticos com o idioma e nível educacional compatíveis.

Obter ajuda de Apoios Sociais e Comunitários: Avaliar as necessidades de adequação aos serviços domiciliares, buscar auxílio comunitários é um importante complemento para o atendimento médico.

Planejamento de cuidados avançados: Se inicia ainda no hospital ou no ambulatório, basicamente deve ser estabelecido metas de cuidado e de assistência médica, esse domínio está indicado para pacientes em cuidados paliativos bem como o envolvimento de serviços de cuidados paliativos, se apropriado, para evitar internação particularmente em pacientes que não se beneficiam da readmissão hospitalar.

Monitoramento e Gerenciamento de Sintomas Após Alta: Esse domínio é de extrema importância para prevenir as reinternações, principalmente para usuários com condições frágeis, como insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica, distúrbios gastrointestinais, demência e doença vascular.

Coordenar o atendimento entre os membros da equipe - O compartilhamento dos registros pré - alta e pós-alta com todos os membros da equipe multidisciplinar deve ocorrer, é preciso estar em sincronia com a coordenação das informações, avaliações e planos da transição do cuidado dentro da equipe.

O monitoramento de sintomas novos ou agravados: O autogerenciamento permite a detecção de novos sintomas pelo usuário e pelo cuidador, efeitos colaterais de medicamentos, dificuldades a adesão ao tratamento podem ser precocemente resolvidas, dependendo da avaliação pelo enfermeiro domiciliar.

Acompanhamento Ambulatorial ideal com profissionais pós-alta apropriados: recomenda-se o agendamento de um rápido retorno com profissionais que possam manter o acompanhamento do usuário, pois estudos mostram que quando o profissional não se familiariza com o usuário as chances de reinternações são altas.

Estes domínios foram criados com o objetivo de auxiliar os gestores de hospitais e sistemas de saúde, pesquisadores e educadores a melhorarem a transição do cuidado e diminuir

os índices de reinternações hospitalares, embora estudos demonstrem que as intervenções focadas nas ações ambulatoriais são mais bem sucedidas; isso reforça a importância da interação entre os profissionais hospitalares e os ambulatoriais e a importância do acompanhamento no pós- alta com consultas, monitoramento de sintomas e o autogerenciamento dos cuidados, incluindo a vigilância de problemas relacionado a medicação após a alta e ao uso de apoios comunitários (Burke *et al.*, 2013).

7.5 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

7.5.1 Atenção Domiciliar

Desde a década de 1960 a AD tem sido utilizada no Brasil por diferentes processos, sendo destaque as experiências municipais na década de 1990 e 2000 que evoluíram o entendimento de que o serviço domiciliar deve funcionar articulado em rede, sendo organizado em equipes multiprofissionais que atendam uma determinada população, não se restringindo ao usuário proveniente do hospital (Brasil, 2012).

Considerando o cenário brasileiro com a transição demográfica e epidemiológica e a crise do modelo de atenção, em 2011, a AD se tornou prioridade como modelo de atenção estratégica, e através da portaria 2.527 de 27 de outubro de 2011, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o programa Melhor em Casa, criando também a Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar (CGAD) no Departamento de Atenção Básica, para coordenar a estruturação da atenção domiciliar no âmbito do SUS, em parceria com estados e municípios (Brasil, 2012).

O Quadro 1 demonstra de forma cronológica a trajetória percorrida pela Atenção Domiciliar desde 2002 até a mais recente atualização, em 2024.

Quadro 1 – Legislações que regulamentam a Atenção Domiciliar

Legislação	Título
Lei n. 40.424, de 15 de abril de 2002	Regulamentando a Assistência Domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS)
Portaria n. 249 de 16 de abril de 2002	Normas para cadastramento de centros de referências em Assistência à Saúde do Idoso (Programa de Desospitalização de idosos)
Resolução SES n. 2.930 de 17 de janeiro de 2006	Institui os Núcleos Hospitalares de Geriatria e define suas atribuições
RDC n. 11 de 26 de janeiro de 2006	Regulamentando Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar

Portaria n. 2.529 de 19 de outubro de 2006	Institui a Internação Domiciliar no âmbito do SUS
Portaria n. 2.029 de 24 de agosto de 2011	Institui a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS (revogada a portaria 2.529)
Portaria n. 2.527 (outubro) de 2011	Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (revoga a portaria 2.029) Lançamento do Programa Melhor em Casa
Portaria nº 1.533, de 16 de julho de 2012	Altera e acresce dispositivos à Portaria nº 2.527/GM/MS, de 27 de outubro de 2011, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Portaria n. 963 de 27 de maio de 2013	Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS
Portaria nº 1.208, de 18 de junho de 2013	Dispõe sobre a integração do Programa Melhor em Casa (Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) com o Programa SOS Emergências, ambos inseridos na Rede de Atenção às Urgências
RDC n. 36 de 25 de julho de 2013	Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde
Portaria n. 3.390 de 30 de dezembro de 2013	Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP)
Portaria n. 825, de 25 de abril de 2016	Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS e atualiza as equipes habilitadas
Portaria GM/MS Nº 3.005, de 2 de janeiro de 2024	Altera as Portarias de Consolidação nº 5 e 6, de 28 de setembro de 2017, para atualizar as regras do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC)

Fonte: Adaptado de Brasil (2020; 2024)

O MS define a AD como uma modalidade de atenção à saúde integrada à RAS, e desenvolve ações prestadas em domicílio para a promoção e prevenção da saúde, tratamento de doenças, reabilitação, e palição, garantindo a continuidade dos cuidados (Brasil, 2016);

A AD é indicada para pessoas com estabilidade clínica, que demandam atenção à saúde devido quadro de restrição ao leito temporariamente ou permanente, ou que apresente certo grau de vulnerabilidade sendo a AD mais oportuna para o tratamento, casos de palição, reabilitação e prevenção de agravos, proporcionando de forma ampla a autonomia do usuário, família e cuidador (Brasil, 2024).

As atribuições das equipes da AD são: Prestar assistência à saúde, conforme a necessidade dos usuários, articulação com os outros pontos da RAS, seguir os fluxos para a admissão no serviço conforme a elegibilidade, proporcionando a transição do cuidado segura, prestar assistência de qualidade as demandas de reabilitação intensiva e contribuir para a diminuição da espera de cirurgias eletivas (Brasil, 2024).

Para os critérios de elegibilidade para o atendimento na AD, os usuários são classificados em 3 modalidades: AD1, AD2 e AD3. É classificado como AD1 o usuário que

tenha indicação de atendimento domiciliar por condição crônica estabilizada e restrição ao domicílio, e necessite de atendimento da equipe com pouca frequência, podendo ser programado conforme seu Plano Terapêutico Singular (PTS), sendo de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS), o acompanhamento do usuário em domicílio (Brasil, 2024).

Na modalidade AD2 é classificado o usuário que apresente condições clínicas Agudas e necessita de tratamentos parenterais ou outros procedimentos frequentes; condições clínicas crônicas agudizada com necessidade de atendimento subsequentes, tratamentos parenterais ou reabilitação com possibilidade de ganho de funcionalidade; cuidados paliativos com visitas frequentes para manejo de sintomas; e Prematuridade que precisa de acompanhamento para ganho ponderal ou de procedimentos sequenciais" (Brasil, 2016).

Na modalidade AD3 é classificado o usuário que se encaixe em qualquer uma das situações de critérios de elegibilidade do AD2 e adicionalmente apresente a necessidade de cuidados impreterivelmente multiprofissionais e a necessidade de equipamentos ou procedimentos de maior complexidade como: Ventilação mecânica invasiva e não invasiva domiciliar; Nutrição parenteral; Transfusão sanguínea; Diálise peritoneal; Hemodiálise; Drenagens repetidas (toracocentese, paracentese e outras); Cuidados paliativos em fase final de vida; ou Condições crônico-degenerativas progressivas; e com demanda de atendimentos sistemáticos em domicílio, reabilitação intensiva, antibioticoterapia e outros (Brasil, 2016).

O Programa Melhor em Casa (PMeC) foi instituído com o objetivo de fomentar a utilização do SAD no âmbito do SUS. O SAD promove a integração entre os serviços de diferentes complexidades, vinculado à Rede de Urgência e Emergência (RUE) o SAD tem atuação entre a atenção hospitalar, Atenção especializada e a Atenção Básica, atendendo também as diretrizes da Atenção Básica (Bertagnoli *et al.*, 2021). O PMeC estabelece regras de gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e das Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP). " (Brasil, 2024).

As equipes EMAD devem ter no mínimo os profissionais: médico, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem, e a equipe EMAP deve ter no mínimo, três profissionais de nível superior escolhidos entre as ocupações a seguir: Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Terapeuta ocupacional; psicólogo; odontólogo, farmacêutico e assistente social, sendo que a equipe da EMAP deverá dar suporte complementar às ações da EMAD atuando conforme a indicação clínica e planejamento em equipe (Brasil, 2016).

7.5.2 Desospitalização

O conceito de desospitalização surge na década de 1990, no contexto da reforma sanitária e da reformulação do modelo de assistência na área de saúde mental, buscando a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos. As políticas e estratégias que contribuíram para a implementação da desospitalização no Brasil iniciaram no SUS com a Instituição da Assistência Domiciliar, por meio da Lei n. 10.424, de 15 de abril de 2002 (Brasil, 2020).

O MS define a desospitalização como a desinstitucionalização de pessoas hospitalizadas, que recebem alta para o domicílio de forma ágil; colocando a família como protagonista do cuidado, dando ênfase no serviço humanizado, prevenindo as reinternações, podendo antecipar-se a internação com medidas ainda no atendimento ambulatorial, como auxílio a equipe da atenção básica (Brasil, 2020).

De forma articulada a desospitalização em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), busca promover a continuidade do cuidado com integralidade interagindo com os diferentes pontos de atenção, entre a APS e os demais níveis do sistema (Brasil, 2020)

A desospitalização de forma eficaz é o fruto de um processo minuciosamente planejado e executado para proporcionar que o usuário hospitalizado retorne ao seu domicílio com o mínimo de cuidados possíveis, o objetivo é proporcionar que essa transição aconteça de forma agradável e tranquila, garantindo que o usuário irá receber todos os cuidados pertinentes para a sua recuperação, diminuindo assim os riscos de complicações ou reinternações (Prim *et al.*, 2023).

Dentro da perspectiva da desospitalização, ocorrem modificações que devem transpor a multidisciplinaridade, em que os profissionais sejam independentes em suas atuações, com interações nas ações de educação em saúde, valorizando também o conhecimento e o contexto social do usuário, viabilizando assim um plano de cuidados que possa abranger as reais necessidades do usuário e fazendo com que o processo da desospitalização seja efetivado com segurança e qualidade (Brasil, 2020).

Quando o usuário apresenta estabilidade clínica, e tem condições de receber alta, mas ainda tem necessidade de continuar o tratamento com o acompanhamento de um profissional ou o uso de dispositivos médicos/hospitalares que dão suporte a vida, é possível desospitalizar, e neste caso é preciso que seja definido um cuidador de referência para receber as orientações da equipe multidisciplinar ainda dentro do hospital, com o objetivo de desenvolver nesse cuidador a confiança e a capacidade necessária para realizar os cuidados ao usuário no domicílio (Borges *et al.*, 2023).

Cuidador é a pessoa que, familiar ou não do usuário acompanhado pelo SAD, é responsável pelos cuidados diariamente no domicílio, devendo haver uma interação democrática entre o cuidador e a equipe multidisciplinar da AD, de modo que o vínculo entre eles permita uma colaboração e confiança mútua com o apoio indispensável dos profissionais (Bertagnoli *et al.*, 2021).

A abordagem realizada pela equipe multidisciplinar com o cuidador por meio da capacitação prática ainda no ambiente intra-hospitalar, em conjunto com o acompanhamento após a alta, promove segurança no processo de adaptação desse cuidador e diminui possíveis reinternações por falhas no cuidado domiciliar (Borges *et al.*, 2023).

Esse processo de preparo do usuário e do cuidador para a alta assegura a continuidade do cuidado, que ocorre do ambiente hospitalar para o domicílio, e os indivíduos envolvidos são: o usuário, o Cuidador, a Equipe multidisciplinar e o SAD. No Quadro 2, estão apresentadas de forma sintetizada as recomendações do MS para a desospitalização e continuidade do cuidado.

Quadro 2 – Recomendações para a continuidade do cuidado durante a desospitalização

Eixos	Quando realizar	Descrição das ações
Planejamento da alta hospitalar	Na admissão	Coletar a informações sobre a causa da internação hospitalar, condições gerais de saúde, quadro funcional prévio à internação, idealizar o plano de cuidados com o planejamento da alta.
Identificação das questões físicas, clínicas e psicossociais do usuário	Na admissão	Nesse contexto, algumas perguntas devem ser respondidas: Qual o objetivo da internação hospitalar? Qual o principal problema a ser resolvido a fim de viabilizar o retorno do indivíduo ao domicílio? Qual o tipo de suporte que esse indivíduo e sua família necessitam para dar continuidade ao cuidado?
Reconciliação medicamentosa	Na admissão, durante o período de internação e na alta.	Relacionar quais medicamentos o paciente fazia uso antes da internação, objetivando-se avaliar a necessidade da continuidade ou da suspensão do uso deles. A reconciliação medicamentosa e orientação efetiva do usuário sobre o regime medicamentoso após a alta é um dos pontos mais críticos da desospitalização
Comunicação	Na admissão, durante o período de internação e na alta	Discussão dos casos com a equipe multidisciplinar e com o usuário e a família, conhecer as necessidades do usuário, e sistematizar um processo contínuo, organizado e estruturado, possibilitando atender a todos os elementos necessários para a implementação do plano de

		cuidados e sanar as expectativas do usuário e da família acerca do cuidar em domicílio.
Treinamento do cuidador	Na admissão, durante o período de internação e na alta	A equipe multidisciplinar deverá desenvolver junto ao cuidador o treinamento ainda durante a internação hospitalar, com metas a serem atingidas pelos cuidadores. Todos os aspectos devem ser abordados no planejamento da alta, pois embasarão as orientações necessárias ao cuidador de tal forma que se torne capaz de assumir, gerenciar e sustentar essa atividade.
Rede de apoio e articulações nas RAS	Na alta	O processo de desospitalização deve ocorrer com seguimento de cuidados e atendimento domiciliar por uma equipe de referência nesta área. Pode se estabelecer em virtude da tipologia dos casos, da disponibilidade e da possibilidade de acompanhamento pelas equipes de Estratégia e Saúde da Família (ESF), ou Programa de Atendimento Domiciliar do Idoso, ou serviços próprios vinculados às unidades hospitalares e institutos, localização de moradia e outros fatores.

Fonte: Brasil (2020)

Abaixo, é apresentado o subcapítulo relacionado à desospitalização e à continuidade do cuidado.

7.5.3 A Desospitalização e a Continuidade do Cuidado

Com o propósito de estabelecer as diretrizes comuns, entre estudos de Coleman *et al.* (2006) e os dez domínios propostos por Burke *et al.* (2013) para uma transição ideal no cuidado e as recomendações do MS para a desospitalização, sugerido por Brasil 2020, no Quadro 3, realizou-se uma síntese quanto aos pontos convergentes entre os modelos de transição e desospitalização.

Quadro 3 – Síntese das semelhanças entre os modelos de transição do cuidado e desospitalização

Eixo	Referência	Pontos convergentes
	Coleman <i>et al.</i> (2006)	Identifica a necessidade de intervenção para lidar com situações que podem ameaçar a qualidade e segurança durante as transições de cuidados, e como uma das ferramentas dessa intervenção, em seu estudo, os enfermeiros <i>coaches</i> realizaram uma visita intrahospitalar, ou seja, antes da alta, com o objetivo de discutir e tirar

Planejamento da alta		dúvidas sobre o tratamento e principalmente os sintomas e possíveis reações medicamentosa.
	Burke <i>et al.</i> (2013)	Em seu estudo destacou a importância de planejar a alta antecipadamente, enquanto o paciente ainda está em tratamento intra-hospitalar, ele destaca que esta prática tem sido bem-sucedida em outras intervenções de transição de cuidados.
	Brasil (2020)	O planejamento da alta hospitalar deve iniciar no dia da internação, e a identificação do momento ideal da alta deve ser um dos objetivos do médico assistente e da equipe multidisciplinar, uma vez que estudos comprovam que a internação prolongada pode ocasionar malefícios como: delírio, infecção hospitalar, perda da funcionalidade motora, trombose, lesões por pressão, quedas e eventos adversos de medicações.
Comunicação	Coleman <i>et al.</i> (2006)	Para melhorar a comunicação, o pesquisador incorporou como um dos pilares da intervenção de cuidados o Registro Centrado no Paciente, através do PHR (Abreviação: PHR - Personal Health Record - registro de saúde pessoal), esse registro é propriedade e mantido pelo paciente para facilitar a transferência de informações entre locais e garantir a continuidade do plano de cuidados entre profissionais, cuidadores e ambientes. Além disso, Coleman em seu estudo tinha como uma das principais funções do treinador de transição (enfermeiro coach) a orientação e auxílio ao paciente e seu cuidador em desenvolverem habilidades de comunicação efetiva, para comunicar as suas necessidades de cuidados nas consultas subsequentes com os profissionais de saúde e para isso o treinador de transição realizava simulações de situações demonstrando estratégias de comunicação eficazes a fim de que o paciente estivesse pronto para comunicar de forma clara e articulada às suas necessidades.
	Burke <i>et al.</i> (2013)	Um dos domínios da transição ideal do cuidado é a comunicação completa e escrita, como um resumo da alta ou outras formas de compartilhar as informações para o atendimento pós alta. É importante que as informações estejam de forma clara, pontual e organizada, pois o conteúdo deve transmitir as recomendações do profissional primário de forma que os profissionais pós-alta consigam compreender rapidamente as informações antes de assumir os cuidados do paciente.
	Brasil (2020)	Aponta que o planejamento do cuidado deve ser desenvolvido pela equipe multidisciplinar em conjunto com o usuário e o cuidador a fim de promover a qualidade da assistência através de um cuidado personalizado e integral. Nesse processo o profissional de saúde deve adequar o seu vocabulário respeitando as habilidades e cultura do usuário e seu cuidador para uma melhor compreensão das

		informações. A Comunicação de forma clara é essencial, pois caso contrário, a falta de compreensão das orientações pode levar o usuário e o cuidador a desenvolverem insegurança, comprometendo assim a continuidade do cuidado. Sugere-se que a comunicação entre os integrantes da equipe multidisciplinar envolvidos no planejamento da alta e pós alta seja melhorada através de reuniões de equipe diárias.
Reconciliação e autogestão de medicamentos	Coleman <i>et al.</i> (2006)	Coloca a assistência no autogerenciamento de medicamentos como o primeiro pilar da intervenção de transição de cuidados, pois problemas na compreensão e na administração de medicamentos são um dos fatores que podem aumentar os índices de reinternações e consequentemente elevar os custos em saúde.
	Burke <i>et al.</i> (2013)	O domínio de Segurança da medicação na transição ideal do cuidado, destaca a sua importância por ser os medicamentos os responsáveis por uma grande parte dos eventos adversos na período pós-alta, recomenda-se como uma forma de diminuir os erros de medicação e promover a segurança do paciente que seja realizado um histórico de medicação, com a reconciliação das mudanças de medicação ao longo do período da internação e sempre comunicar os pacientes e a todos os profissionais envolvidos na transição do cuidado sobre essas mudanças.
	Brasil (2020)	Apresenta a orientação efetiva sobre o uso e a reconciliação dos medicamentos como um dos maiores desafios da transição do cuidado e recomenda que na avaliação de admissão seja realizado uma relação de quais medicamentos o usuário fazia uso antes da internação para avaliar se os medicamentos precisam ser suspensos ou não.
Educação em saúde para o usuário e o cuidador/familiar	Coleman <i>et al.</i> (2006)	Seu estudo foi centrado na educação em saúde para os pacientes idosos e seus cuidadores, com a finalidade de melhorar a qualidade de transição, os pacientes e seus cuidadores receberam treinamento e apoio de uma enfermeira "coach de transição", e sua principal função era a revisão medicamentosa e auxiliá-los a comunicarem suas necessidades a diferentes profissionais de saúde proporcionando a autonomia do paciente e do cuidador frente ao cuidado.
	Burke <i>et al.</i> (2013)	Na transição ideal do cuidado, através do domínio Educação do Paciente e Promoção da Autogestão, discute o treinamento dos pacientes e seus cuidadores, ressaltando a importância de esclarecer sobre os diagnósticos principais e orientações para o autocuidado, considerando as mudanças dos medicamentos, atendimento ambulatorial e orientação a qual profissional procurar caso haja necessidade. É preciso ter a certeza da compreensão das orientações e caso necessário as recomendações devem ser repetidas, recomenda-se oferecer ao paciente e seu cuidador materiais

Continuidade do cuidado e o pós-alta		didáticos e educacionais apropriados ao seu nível educacional e idioma.
	Brasil (2020)	Apresenta experiências bem-sucedidas de hospitais que implantaram Programas de treinamento e capacitação de cuidadores leigos para prestarem os cuidados domiciliares: Antes de iniciar o treinamento é recomendado a seleção de dois cuidadores fixos. Nesses treinamentos a abordagem foi realizada de forma sistemática, baseado no diálogo e exemplificação de “situações problemas”, assim foi possível desenvolver as habilidades nos cuidadores para a execução dos cuidados domiciliares com autonomia e segurança. No hospital onde ocorreram esses treinamentos foram desenvolvidos uma lista de checagem do aprendizado, que foi preenchida diariamente pelos cuidadores com a supervisão da enfermagem. O treinamento foi desenvolvido com atividades práticas como: aspirações traqueais e de vias aéreas superiores, manipulação e administração de medicamentos, manuseio de estomas como traqueostomia e gastrostomia, manuseio de fontes de oxigenoterapia, observação e interpretação de monitores, manuseio de ventiladores manuais e mecânicos e outros procedimentos realizados individualmente. Também foram treinados os cuidadores para reconhecerem sinais e sintomas de piora clínica e formas de como agir nessas situações.
	Coleman <i>et al.</i> (2006)	Relata a importância de agendar visitas de acompanhamento com o profissional que está acompanhando a transição do cuidado e a necessidade de fornecer as informações recentes da hospitalização. Após a alta a enfermeira coach realiza a visita domiciliar para a reconciliação de medicação do paciente (medicamentos pré-hospitalar e pós-hospitalização), e após realiza o acompanhamento através de telefonemas 3 vezes durante um período de alta pós-hospitalização de 28 dias. O primeiro telefonema tinha o objetivo de certificar se o paciente havia recebido os novos medicamentos ou obtido os equipamentos médicos. Nos 2 telefonemas subsequentes, o objetivo era verificar o progresso do paciente em relação às metas estabelecidas na visita domiciliar.
	Burke <i>et al.</i> (2013)	Consultas devem ser agendadas para um curto período após a alta, por exemplo dentro de 7 dias, ou até antes para pacientes mais complexos, e com profissionais que possam manter um acompanhamento regular, devido estudos anteriores apontarem uma alta taxa de reinternações quando o profissional não tem familiaridade com o paciente.
	Brasil (2020)	Destaca a necessidade de uma articulação em rede de atenção com ações realizadas por equipes de saúde com o objetivo de identificar situações que desencadeariam um aumento da permanência na internação e planejar antecipadamente uma rede de apoio para a continuidade do

		cuidado, com os ambulatórios de especialidades de atenção à pessoa idosa no pós -alta para acompanhar o usuário em sua recuperação e transição e assim garantir sua reinserção na RAS. E entre as modalidades promotoras da continuidade da assistência temos a AD, que integra as ações de saúde prestadas em domicílio (prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, palição e promoção à saúde) através do SAD, articula as unidades e serviços das RAS, e proporciona a continuidade da assistência.
--	--	--

Fonte: Adaptado de Burke *et al* (2013); Coleman *et al.* (2006); Brasil (2020)

Na sequência, é apresentado o capítulo do percurso metodológico da presente pesquisa.

6. PERCURSO METODOLÓGICO

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa ocupa-se de fatos da sociedade que podem ser interpretados e explicados na dinâmica das relações sociais. A abordagem qualitativa estuda os significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, esses fatores são considerados a porção mais profunda das relações e não podem ser mensurados através de variáveis, mas propicia a criação de novas formas e conceitos relacionados ao fenômeno estudado, respeitando as diversidades da população estudada (Minayo, 2001).

Na área da saúde a pesquisa qualitativa corrobora para a compreensão de diferentes sujeitos (usuários, gestores, profissionais) acerca dos mais variados assuntos, como o vivenciar ou experimentar a saúde, a doença, a morte, o acesso aos serviços de saúde, iniquidades sociais, entre outras situações em que não é possível quantificar (Dantas; Amorim, 2022)

Neste tipo de pesquisa os dados são descritivos, e podem ser coletados de diferentes formas, como entrevistas, fotografias, vídeos, notas de campo, dentre outros. O interesse do pesquisador ao estudar um fenômeno é conhecer como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas, essa dimensão de significados demonstra que a pesquisa qualitativa está centrada na perspectiva do participante, e a análise de dados é realizada de modo indutivo, não devendo o pesquisador presumir questões antes de terminar a investigação, o pesquisador por sua vez deverá ter um contato direto e prolongado com o ambiente e o objeto do estudo (Sousa; Santos, 2020).

Para alcance dos objetivos propostos o percurso metodológico está organizado em duas etapas: inicialmente foi realizada a revisão da literatura por *Scoping Review* com a finalidade de responder o objetivo específico1: Mapear as evidências científicas acerca da avaliação da satisfação de usuários adultos e/ ou cuidadores sobre o Serviço de Atenção Domiciliar.

Posteriormente foi desenvolvida uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com os cuidadores, a fim de responder os objetivos 2,3,4 e 5, a saber: 2-Identificar como aconteceu a continuidade do cuidado no ambiente hospitalar na perspectiva do cuidador; 3-Descrever a experiência dos cuidadores sobre o seu preparo para desempenhar os cuidados no domicílio; 4-Explorar a percepção do cuidador sobre a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar na continuidade do cuidado e 5-Analisar as potencialidades e fragilidades relatadas pelos cuidadores na continuidade do cuidado.

6.1 PRIMEIRA ETAPA: REVISÃO DA LITERATURA POR *SCOPING REVIEW*

Optou-se pela abordagem *Scoping Review* para a revisão de literatura, conforme diretrizes estabelecidas por Levac, Colquhoun e O'brien (2010), que se organiza em cinco fases:

1) Identificação da questão da pesquisa; 2) Identificação de estudos relevantes; 3) Seleção dos estudos; 4) Delineamento dos dados e 5) Agrupar, resumir e relatar os resultados.

1) Para definição da pergunta de pesquisa foi considerado o conceito, a população-alvo e os resultados de saúde de interesse (Levac; Colquhoun; O'brien, 2010), sendo a População: Usuários/cuidadores adultos; Conceito: Avaliação da satisfação e Resultado: Satisfação do serviço de atenção domiciliar, resultando na seguinte questão de pesquisa: Quais as evidências científicas sobre a avaliação da satisfação dos usuários/cuidadores de usuários adultos atendidos por serviço de atenção domiciliar.

2) Os estudos foram identificados por meio de buscas em bases de dados científicos, na literatura cinzenta e em sites governamentais, listados a seguir: Pubmed, Scopus, bases integradas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME), Google acadêmico e Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para as buscas foram utilizados os descritores: Mecanismos de Avaliação da Assistência à Saúde, Serviços de Assistência Domiciliar, Continuidade da Assistência ao paciente e Satisfação do paciente adaptados para cada fonte de pesquisa utilizando o operador booleano AND, conforme demonstrado no quadro 4 “Estratégia de busca”.

Quadro 4 – Estratégia de Busca

Estratégia de Busca		
Data e Local da pesquisa	Chave de busca e filtros utilizados	Número
01/07/2025 PubMed	Chave: (((Health Care Evaluation Mechanisms) AND (Home Care Services)) AND (Continuity of Patient Care)) AND (Patient Satisfaction) Filtros: últimos 10 anos / texto completo gratuito/ Idioma> português, inglês e espanhol/ espécie> Humanos/ Idade> Adultos +19	N: 79
01/07/2025 Biblioteca Virtual da Saúde	(Mecanismos de Avaliação da Assistência à Saúde) AND (Serviços de Assistência Domiciliar) AND (Continuidade da Assistência ao paciente) AND (Satisfação do paciente) Filtros: últimos 10 anos / texto completo gratuito/ Idioma> português, inglês e espanhol	N: 01

01/07/2025 Scopus	(Health Care Evaluation Mechanisms) AND (Home Care Services) AND (Continuity of Patient Care) AND (Patient Satisfaction) Filtros: últimos 10 anos / texto completo gratuito/ Idioma> português, inglês e espanhol	N: 07
02/07/2025 Google Acadêmico	"Assistência Domiciliar" "satisfação do paciente " "artigo original" Filtros: últimos 10 anos / Idioma> português, inglês e espanhol	N: 26
02/07/2025 Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)	Avaliação da Atenção Domiciliar+Cuidado Domiciliar pelo paciente Filtros: últimos 10 anos / Dissertação e Tese/ Grande Area conhecimento> ciências da saúde, multidisciplinar / Area conhecimento>Enfermagem, saúde e biológicas/ Area de avaliação> enfermagem, interdisciplinar/ Area concentração>Atenção integral a saúde, enfermagem e o processo do cuidado, enfermagem em saúde pública, práticas sociais em enfermagem e saúde, saúde e enfermagem. Selecionado apenas os estudos disponíveis na íntegra	N 05
Total		118

Fonte: Elaborado pela Autora (2026)

3) Os estudos foram selecionados tendo como critérios de inclusão: Artigos científicos originais, dissertações e teses disponíveis na íntegra, nos idiomas português, espanhol e inglês, acessíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Pubmed, Scopus, no portal periódico CAPES e no *google* acadêmico, com restrição temporal dos últimos 10 anos. Foram excluídos: Estudos de revisão, notas editoriais, Trabalho de Conclusão de Curso de graduação e pós-graduação Lato Sensu e arquivos duplicados.

Os critérios de inclusão e exclusão foram adaptados para cada fonte da pesquisa conforme os filtros disponíveis por fonte, conforme demonstrado no quadro “Estratégia de busca”.

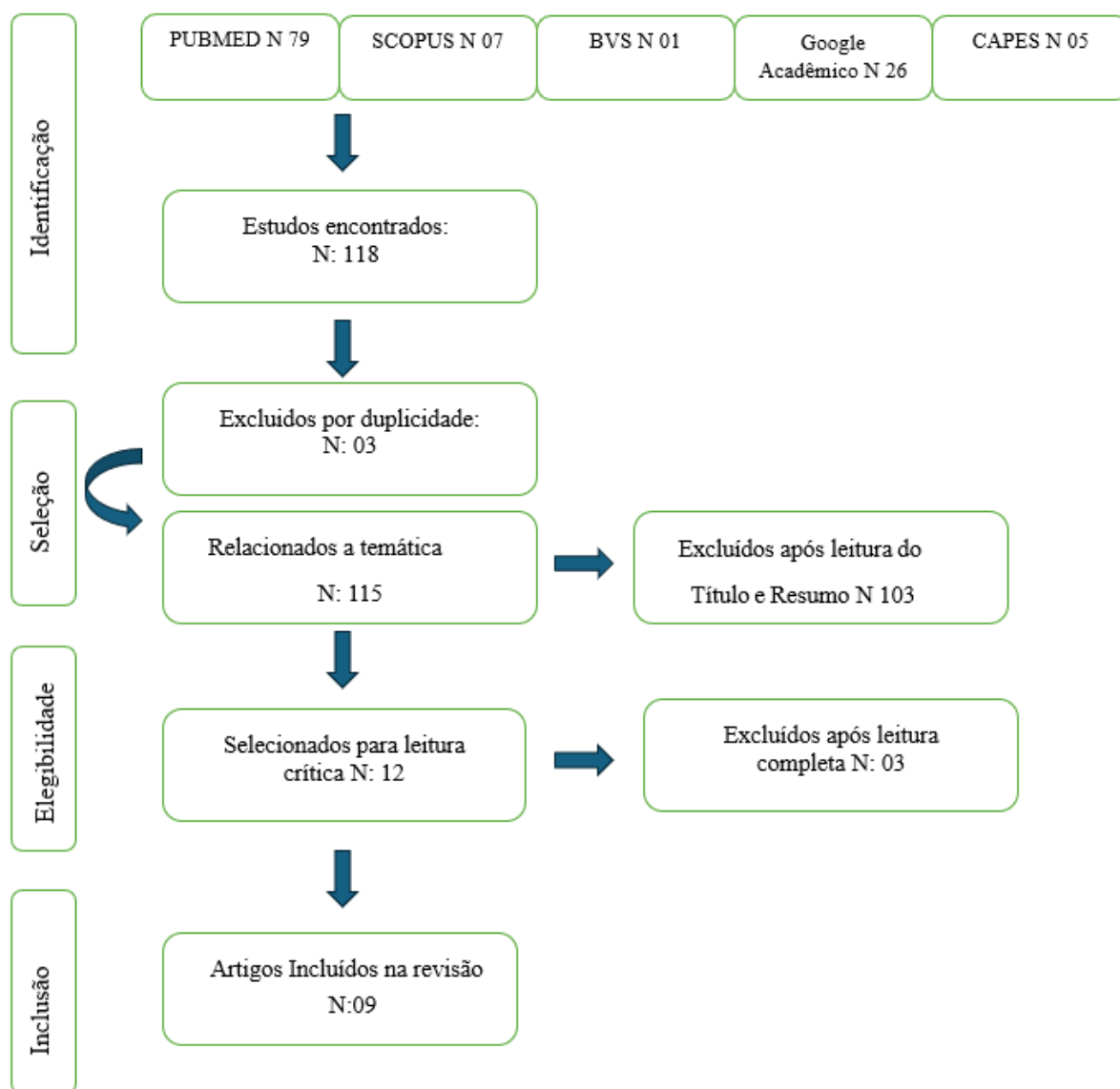
4) Os dados foram extraídos das fontes de buscas e exportados para a ferramenta online denominada *Rayyan*, a qual é específica para o desenvolvimento de estudos de revisão.

Dos 118 estudos encontrados, 113 estudos foram exportados para o *Rayan*, porém não foi possível exportar as 05 dissertações encontradas no CAPES por incompatibilidade do arquivo, então elas foram compiladas e organizadas em um quadro. Dos estudos exportados para o *Rayan* realizou-se a exclusão de 03 estudos por estarem duplicados, em seguida realizou-se a leitura dos 115 estudos referente a títulos e resumos para a seleção dos estudos condizentes com a temática.

Toda essa etapa foi realizada por dois pesquisadores de forma independente para assegurar o rigor científico na seleção dos estudos, os casos de divergência foram atribuídos a um terceiro pesquisador para a determinação final quanto a inclusão dos estudos na revisão.

Após leitura de título e resumo dos 115 estudos, as 05 dissertações foram excluídas por não condizerem com a temática, 04 artigos tiveram divergências e foram incluídos para a leitura na íntegra após avaliação de um terceiro pesquisador. Em relação aos artigos que os avaliadores tiveram dúvidas foram 12, destes foram incluídos 02 e 10 excluídos.

Posteriormente a avaliação do terceiro avaliador e resolução das divergências, dos 115 estudos, 103 foram excluídos, sendo selecionado 12 estudos para a leitura na íntegra e ao final foram eleitos 09 estudos para a inclusão na revisão de *Scoping*. O esquema de seleção dos estudos está representado no fluxograma adaptado do PRISMA conforme a figura 3.

Figura 3 – Fluxograma Adaptado Prisma

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

5) Agrupar, resumir e relatar os resultados: Os resultados foram sintetizados em dois quadros.

6.2 SEGUNDA ETAPA ABORDAGEM QUALITATIVA

6.2.1 Cenário do estudo

Este estudo ocorreu no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. O HMPGL iniciou os atendimentos na cidade de Foz do Iguaçu em

setembro de 2006, mas a inauguração oficial ocorreu em 10 de junho de 2011, e faz parte da rede de instituições de saúde que operam sob o Sistema Único de Saúde (SUS) e é gerido pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Foz do Iguaçu (Muentes, 2024).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Foz do Iguaçu/ PR, que se localiza no extremo Oeste paranaense, distante 630,20 quilômetros da capital Curitiba. É um dos municípios mais antigos do estado do Paraná instituído em 10/06/1914. Sua área territorial estimada é de 609,192km², com densidade demográfica de 468,51hab/km (IBGE, 2023).

Sua localização geográfica o posiciona como um dos municípios paranaenses de maior importância para o desenvolvimento econômico estadual e é considerado estratégico para a implementação de ações de prevenção e promoção da saúde por ser situado em uma região de fronteira internacional com outros dois países: Ciudad Del Este, localizado no departamento de Alto Paraná, Paraguai e Puerto Iguazú, situado na província de Misiones, Argentina (Figura 3). O território iguaçuense se destaca por sua característica de multiculturalidade, registrando-se a coexistência de mais de 70 línguas, faladas por mais de 14 etnias (Foz do Iguaçu, 2021).

Figura 4 – Localização geográfica da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina



Fonte: Avelar; Schneider (2019)

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do município de Foz do Iguaçu em 2010 era de 0,751, o que deixa o município na faixa de IDHM alto. O índice mais alto foi o da longevidade, tendo índice de 0,858, em segundo lugar foi a renda com índice de 0,748 e em terceiro a educação com índice de 0,661 (Foz do Iguaçu, 2021).

Com as verbas oriundas do Sistema integrado de saúde das fronteiras (SIS-FRONTIERA) houve investimentos em estruturas de unidades básicas de saúde, como a construção da Unidade Básica de Saúde Jardim América e a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Vila Yolanda, cursos de aperfeiçoamento da gestão e custeio parcial do Centro Materno Infantil. O Centro Materno Infantil (CMI) foi implantado na cidade em 2006 em parceria com a Itaipu Binacional, atende mulheres e crianças brasileiras residentes nos países vizinhos, Paraguai e Argentina, em ações de prevenção e assistência curativa (Haum; Carvalho, 2021).

A cidade também possui a Casa do Migrante, serviço sob coordenação da Secretaria Municipal de Assuntos Internacionais, integra ações de atenção à saúde e de assistência social, o encaminhamento do migrante hoje ocorre de forma organizada e mantém um banco de dados sobre os atendimentos realizados. Também participa do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde da Fronteira (GT SAÚDE/ITAIPU) este grupo tem como objetivo a integração dos serviços de saúde, bem como a discussão e troca de experiências entre os países sobre o processo do trabalho, e isso pode constituir uma importante ferramenta para reduzir as desigualdades entre os países e melhorar as estratégias da gestão em saúde (Foz do Iguaçu, 2010)

Para o atendimento à população na área da saúde, a cidade conta com 95 equipes de ESF cadastradas. Um número recorde no município e com 100% de cobertura. Na atenção terciária o HMPGL tem se destacado por prestar atendimento não somente à população local, mas também à população fronteiriça. Em 2023 houve um total de internamentos de 15.057, de usuários de Foz do Iguaçu, dos 8 municípios vizinhos, do Paraguai e vindos de outras regionais (Schaefer, 2024).

No Quadro 5 é apresentado o número de leitos existentes no Hospital Municipal Germano Lauck no período do ano de 2023.

Quadro 5 – Leitos Hospitalares do Hospital Municipal Padre Germano Lauck

LEITOS	2023
HMPGL - Clínica Cirúrgica	73
HMPGL - Clínica Médica	61
HMPGL - Clínica Pediátrica	23
HMPGL – Complementar	2
HMPGL – Psiquiatria	15
HMPGL – UTI Adulto	40

TOTAL	217
--------------	------------

Fonte: Foz do Iguaçu (2024)

Além disso, o HMPGL é uma das instituições públicas que tem oferecido campo para o ensino, a pesquisa e extensão, através dos programas de qualificação multiprofissional em assistência hospitalar, as residências médicas e de enfermagem (Foz do Iguaçu, 2023; Bogler, 2024).

Com base no manual do MS (Brasil, 2020), o HMPGL inaugurou o setor de desospitalização para auxiliar as famílias no processo da alta e para otimizar a rotatividade dos leitos hospitalares. Esse setor iniciou os trabalhos sob a liderança da enfermeira Isabela Delazari no ano de 2022, permanecendo como gerente do setor até o presente momento, pelo fato de não haver na literatura relatos de como o serviço funciona na instituição, optou-se em realizar uma visita técnica e as informações foram colhidas diretamente com a enfermeira responsável pelo setor.

Atualmente o setor da desospitalização apresenta em seu quadro de funcionários 6 técnicos de enfermagem que alternam em escalas 12/36, 1 técnica de enfermagem e 2 enfermeiras em escala de 8h/dia.

A desospitalização realiza o acompanhamento diário das evolução médicas e da equipe multidisciplinar com o objetivo de auxiliar nas demandas e processos que possam otimizar as altas hospitalares, gerando indicadores que podem ser utilizados pelos gestores para avaliar a necessidade de melhorias nos fluxos das altas, também é realizado uma reunião semanalmente com a equipe da desospitalização, a equipe médica da especialidade da clínica médica, a equipe multidisciplinar e a equipe do SAD para discussão de casos mais complexos que demandam uma ação integrada para viabilizar a alta hospitalar com segurança.

Outra ação realizada pela equipe é a orientações aos familiares referente ao preparo do domicílio, bem como aquisição de equipamentos de convalescença, e em alguns casos também é realizado empréstimos de cama hospitalar, aspirador traqueal, colchão pneumático e concentrador de oxigênio.

Usuários internados que iniciam o tratamento com hemodiálise, quando recebem alta médica, mas necessitam dar continuidade com tratamento de hemodiálise ambulatorialmente, são inseridos em uma fila do município, quem insere e acompanha esses usuários até que a vaga seja cedida é o setor de desospitalização.

Em casos em que o usuário apresenta estabilidade clínica, mas ainda necessita de antibioticoterapia, com base no manual de diretrizes brasileiras para Terapia Antimicrobiana

Parenteral Ambulatorial (OPAT), da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a desospitalização realiza o encaminhamento, se o usuário for acamado a medicação é realizada pela equipe do SAD, mas se o usuário deambula ele é encaminhado para a UPA, tudo isso é devidamente organizado em conjunto com os gerentes dos setores envolvidos e a desospitalização.

Outro processo desenvolvido pela equipe é o auxílio nos casos sociais, atualmente o HMPGL apresenta uma situação complexa em relação a casos de usuários abandonados na instituição, seja por realmente não apresentarem nenhuma rede de apoio familiar, ou pelo fato dos familiares não assumirem a responsabilidade pelos cuidados do usuário por não apresentarem condições físicas, psicológicas e financeiras, nesses casos a desospitalização auxilia intermediando as avaliações dos usuários pelas casas de apoio e acolhimento em conjunto com o serviço social da instituição.

6.2.2 População

A população foram os cuidadores/familiares de usuários maiores de 18 anos classificados como AD2 e AD3 atendidos pelo serviço de desospitalização do HMPGL, que permaneceram internados em serviço de clínica médica, e que permaneceram por, pelo menos, 24 horas. Optou-se em incluir somente usuários AD2 e AD3 por serem os usuários que são acompanhados pelo SAD e com tempo de permanência igual ou superior a 24 horas de internação, por este ser considerado o período mínimo para caracterizar uma internação no serviço e por entender que aqueles que permanecem por período inferior não teriam contato suficiente com os profissionais de saúde, para receber as orientações adequadas.

Como critério de inclusão dos cuidadores foi considerado: Ter idade superior a 18 anos; aceitar voluntariamente participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);

Os critérios de exclusão foram: os cuidadores dos usuários que foram a óbito após a alta hospitalar; aqueles que no momento do contato telefônico havia reinternado, aqueles que não se obteve êxito no contato após três tentativas consecutiva; aqueles que o contato telefônico acusou inexistente ou a pessoa que atendeu não conhecia o usuário, aqueles que recusaram participar da pesquisa, os participantes que aceitaram realizar a entrevista, porém não compareceram no dia e hora marcados ou não atenderam a vídeo chamada sem justificativa e sem retorno mesmo após um novo contato. Os usuários institucionalizados não foram incluídos

nesta pesquisa por não apresentarem cuidador durante a internação hospitalar e pelo fato de que após a alta eles são assistidos por profissionais da enfermagem.

O número de participantes no presente estudo foi estabelecido pelo quantitativo de usuários que atenderam ao critério de inclusão e exclusão no período correspondente a coleta de dados.

6.2.3 Coleta de dados

Os participantes foram identificados semanalmente por meio de uma lista fornecida pelo serviço de desospitalização do HMPGL. Nesta lista foi possível identificar os nomes dos usuários que receberam alta e a classificação deles (AD1, AD2 e AD3), a partir disso foi realizado a seleção de apenas os usuários que foram classificados como AD2 e AD3 e realizado uma busca no prontuário eletrônico (sistema Tasy) para se obter o contato telefônico dos usuários e/ou cuidadores, em seguida esses cuidadores foram contactados por meio de ligação telefônica e mensagens de whats app para solicitar se havia interesse na participação da pesquisa. Os cuidadores que manifestaram o interesse em participar da pesquisa, novamente o prontuário eletrônico foi utilizado para obter os seguintes dados: Data da internação, data da alta, motivo da internação.

A coleta de dados ocorreu no período de abril a agosto de 2025, neste período estiveram internados nos setores de clínica médica 109 usuários classificados como AD2 e AD3 pelo serviço de desospitalização. Destes foram excluídos 97 por não atenderem os critérios de inclusão e exclusão, resultando em 12 participantes. Na tabela 01 é demonstrado de forma detalhada o número dos participantes e os respectivos critérios de inclusão e exclusão.

Tabela 1 – Critérios de Inclusão e Exclusão dos participantes

Critérios de Exclusões e Inclusões	N	%
Óbito após a alta	9	8,26
Institucionalizados	4	3,67
Reinternações	4	3,67
Telefone inexistente ou a pessoa não conhece o usuário	5	4,59
Marcaram entrevista por vídeo chamada, mas não atenderam no dia agendado	2	1,83
Respondeu, mas recusou participar	1	0,92
Não responderam ao contato	72	66,06
Participaram	12	11

Total	109	100%
-------	-----	------

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

O período para contactar os cuidadores foi de até quatro semanas após a alta do usuário, com o propósito de assegurar que o cuidador consiga recordar com precisão do momento da transição do cuidado do hospital para o domicílio.

A entrevista foi realizada por meio de um roteiro semiestruturado (Apêndice A), fundamentado nas diretrizes comuns para a continuidade do cuidado, estabelecidos por Coleman *et al.* (2006), Burke *et al.* (2013) e Brasil (2020), conforme Quadro 3, com perguntas abertas referentes à experiência dos cuidadores que utilizam o serviço de desospitalização de um hospital público em região de fronteira. As questões de pesquisa foram elaboradas com o propósito de alcançar os objetivos propostos, conforme apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 – Objetivos específicos com os eixos da continuidade do cuidado

Objetivo Específico	Eixos comuns para continuidade do cuidado, conforme Quadro 3
Identificar como aconteceu a continuidade do cuidado no ambiente hospitalar na perspectiva do cuidador	Planejamento de Alta; Comunicação.
Descrever a experiência dos cuidadores sobre o seu preparo para desempenhar os cuidados no domicílio	Reconciliação e autogestão de medicamentos; Educação em saúde para o usuário e o cuidador/familiar.
Explorar a percepção do cuidador sobre a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar na continuidade do cuidado. Analisar as potencialidades e fragilidades relatadas pelos cuidadores na continuidade do cuidado	Continuidade do cuidado e Acompanhamento do paciente no pós-alta

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

As entrevistas foram realizadas no idioma português, não houve cuidadores que falassem a língua espanhola. Inicialmente foi realizado uma entrevista como teste piloto pela mestranda, supervisionada pela orientadora responsável que é experiente em pesquisas qualitativas, com o objetivo de treinamento para a coleta de dados, não sendo necessário correções no roteiro semiestruturado. A entrevista piloto foi incluída na pesquisa conforme avaliação das pesquisadoras.

Das 12 entrevistas realizadas, 11 foram realizadas presencialmente, em ambiente privado, escolhido pelo cuidador, e uma das entrevistas foi realizada por vídeo chamada por

preferência do cuidador, neste caso foi orientado o mesmo sobre a necessidade de estar em um local reservado e sem interferências externas. A pesquisadora que conduziu as entrevistas é enfermeira e mestranda de saúde pública em região de fronteira, as entrevistas foram áudio gravadas com autorização dos participantes e transcritas na íntegra para posterior análise, a média de duração das entrevistas foram de 20 minutos. As transcrições das entrevistas na íntegra foram enviadas para todos os participantes para que eles pudessem revisar e realizar alterações caso achassem necessário, dos 12 participantes, 07 não deram devolutiva sobre a transcrição e 05 responderam que concordavam com a transcrição e não solicitaram alterações.

6.2.4 Processamento e Análise de dados

Para a análise dos dados será utilizado a análise de conteúdo na modalidade temática, conforme Minayo (2014). A palavra Tema está relacionada com a afirmação de um determinado assunto e comporta-se como um fascículo de relações capaz de ser graficamente demonstrado por uma palavra, uma frase, um resumo. Para realizar a análise temática é necessário descobrir os núcleos de sentido de uma comunicação, em que sua presença ou frequência signifiquem algo para o objeto em análise. De forma tradicional, a análise temática era realizada pela contagem da frequência das unidades de significação que definia o cunho do discurso.

A análise temática se desenvolve em três etapas: 1) Pré - Análise: Realiza-se seleção dos documentos que serão analisados, retoma-se as hipóteses e os objetivos que deram início à pesquisa. O pesquisador precisa observar as relações entre as etapas já realizadas constituindo tópicos que possam orientá-lo na compreensão e interpretação do material. Nessa fase determina-se a unidade de registro (palavra-chave ou frase), a unidade de contexto (a delimitação do contexto de compreensão da unidade de registro), os recortes, a forma de categorização, o tipo de codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão a análise.

2) Exploração do material: É realizado a forma de classificação para alcançar o centro de compreensão do texto e para isso o pesquisador precisa encontrar categorias que são manifestações ou palavras que tenham significância segundo a qual o conteúdo de uma fala será organizado.

3) Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: Os resultados brutos são submetidos a simples operações estatísticas (porcentagens) ou complexas (análise fatorial) evidenciando as informações obtidas. A partir deste ponto o pesquisador poderá realizar

inferências e interpretações, fazendo relação com a teoria proposta inicialmente, ou poderá apresentar novas dimensões teóricas e interpretativas, a partir da leitura do material.

6.2.5 Aspectos éticos

A pesquisa foi aprovada na instituição onde foram coletados os dados (Anexo 1) e foi submetida para a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Oeste do Paraná (UNIOESTE) sendo e aprovada com Número do Parecer: 7.469.330 e CAAE: 87222025.0.0000.0107.

Após a aprovação no CEP, os participantes foram contactados para a apresentação do estudo e consultados quanto ao interesse na participação, bem como, esclarecidos sobre os riscos e benefícios, havendo a concordância assinaram o TCLE (Apêndice B).

A pesquisa seguiu as orientações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos (Brasil, 2012), sendo garantido todo o anonimato e sigilo dos participantes. No estudo os participantes foram citados como: cuidador 1, cuidador 2..., de forma a preservar a sua identificação.

6.3 RISCOS DA PESQUISA

Os riscos da pesquisa incluíram: 1) risco de ansiedade para o participante caso ele tivesse alguma lembrança desagradável e ao lembrar para responder à pergunta se sentisse desconfortável e ou sentisse sua privacidade invadida; 2) risco de que a entrevista levasse um tempo maior que o esperado e assim ocupasse o tempo do participante e 3) risco de vazamento de dados.

Para minimizar os possíveis riscos da pesquisa foram adotadas as seguintes medidas: 1) Utilizado um local reservado para as entrevistas e foi explicado para o participante que caso alguma pergunta o fizesse se sentir constrangido ele poderia não a responder, não sendo necessário esclarecer o motivo da sua escolha. Houve um olhar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto. Foi explicado ao participante que a entrevista seria interrompida imediatamente caso se percebesse algum risco ou danos à saúde do sujeito participante da pesquisa, conseqüente à mesma, não previsto no TCLE. 2) O entrevistador estava devidamente preparado e familiarizado com o método de coleta de dados. 3) Foi assegurado o anonimato dos

participantes, garantindo que nenhum dos participantes possam ser identificados, e que os dados sejam divulgados apenas para o propósito da pesquisa.

6.4 BENEFÍCIOS DA PESQUISA

Esta pesquisa poderá contribuir na identificação das potencialidades e fragilidades da continuidade do cuidado na perspectiva dos usuários do serviço de desospitalização de um hospital público que vivem na região de fronteira e poderá auxiliar na tomada de decisões por parte dos gestores de saúde para melhorar a qualidade da transição do cuidado e na formulação de políticas públicas específicas para regiões de fronteira.

7. RESULTADOS

7.1 PRIMEIRA ESTAPA

Para responder ao primeiro objetivo específico “Mapear as evidências científicas acerca da avaliação da satisfação de usuários adultos e/ ou cuidadores sobre o Serviço de Atenção Domiciliar, utilizando a revisão da literatura por Scoping Review”, os resultados foram sintetizados em dois quadros, o quadro 7 contém as informações: Título, Ano e País de publicação, Objetivo, Método e Desfecho sobre a Satisfação, o Quadro 8 demonstra os tipos de métodos utilizados em cada estudo.

Quadro 7 – Resultados sintetizados

TÍTULO	Ano/ País	Objetivo	Método	Desfecho sobre a Satisfação
As experiências e necessidades de idosos frágeis que recebem cuidados de saúde domiciliares: um estudo qualitativo.	2022, Praga, República Tcheca.	Explora as experiências e necessidades de idosos que receberam cuidados de saúde em domicílio.	Abordagem qualitativa descritiva exploratória. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio, com quinze idosos em atendimento domiciliar. Utilizou a análise de conteúdo indutiva, conforme descrito por Graneheim <i>et al.</i> (2017).	Os participantes relatam que a sua experiência geral de cuidados de saúde domiciliares foi positiva, descrevendo o cuidado como “Incrível”, “Ótimo”, “Perfeito” e “Excelente”. O atendimento prestado por enfermeiros treinados, experientes e com habilidades de comunicação foram percebidas pelos participantes como sendo bom. A continuidade do pessoal de enfermagem e as atitudes individuais dos enfermeiros também foram importantes para eles. Segurança e Confiança foram sentimentos expressados pelos participantes como resultado do cuidado.
Intervenção domiciliar como ferramenta para o cuidado de enfermagem: avaliação da satisfação de idosos.	2016, Maringá, Paraná, Brasil.	Avaliar os resultados de intervenções domiciliares de enfermagem na perspectiva da satisfação de idosos.	Pesquisa avaliativa <i>ex post</i> , com abordagem qualitativa e caráter descritivo, realizada no período de novembro de 2015 a janeiro de 2016. Participaram 12 idosos dependentes de cuidados, acompanhados por um projeto de extensão na cidade de Maringá/PR. A coleta de dados ocorreu, após intervenções domiciliares realizadas segundo o referencial do Projeto Terapêutico Singular, por meio de entrevistas semiestruturadas, submetidas à análise de conteúdo e posteriormente analisadas segundo	Na perspectiva dos participantes as intervenções domiciliares de enfermagem foram benéficas e proporcionaram mudanças significativas em seus saberes. Os idosos destacaram a melhoria em seu estado de saúde e bem-estar como sendo um resultado positivo das intervenções domiciliares de enfermagem.

			o referencial teórico de Donabedian.	
Eficácia do programa VA-Geriatric Resources for Assessment and Care of Elders (VA-GRACE): Um estudo de coorte observacional	2022, Indianápolis, Indiana, EUA	Examinar o programa VA-GRACE desde a sua implementação (2010-2020) em termos do efeito sobre a mortalidade e as readmissões, além de examinar a satisfação dos pacientes, cuidadores, prestadores de cuidados primários e da equipe do VA-GRACE.	Estudo de coorte retrospectivo incluiu pacientes admitidos no hospital Richard L. Roudebush VA (de abril de 2010 até dezembro de 2019). O estudo examinou o programa <i>Geriatric Resources for Assessment and Care of Elders</i> (GRACE), o qual é um modelo de cuidados colaborativo e multidisciplinar que permite a gestão de cuidados geriátricos no domicílio. Os resultados foram comparados entre os pacientes que receberam serviços VA-GRACE após a alta (N= 49) e um grupo de controle de idosos potencialmente elegíveis para o VA-GRACE, que não receberam os serviços (N = 19) com um total de (N = 68). A satisfação do doente, do prestador de cuidados de saúde, do prestador de cuidados primários e dos membros da equipe VA-GRACE foi obtida através de entrevistas semiestruturadas e incluiu perguntas com respostas em escala de Likert (1 representava "discordância" e 5 representava "concordância") e dados qualitativos abertos. Realizou-se	Tanto os doentes como os prestadores de cuidados que receberam os serviços do VA-GRACE referiram estar muito satisfeitos com o programa, com a maioria das classificações iguais a 5, a classificação mais elevada na resposta à escala de Likert. A satisfação dos doentes e dos prestadores de cuidados baseou-se nos conhecimentos especializados do pessoal do VA GRACE, no seu empenho e no sentimento de carinho genuíno; na redução dos encargos com as deslocações dos idosos e dos prestadores de cuidados; e na assistência da equipe do VA GRACE ligando os idosos e os prestadores de cuidados de saúde a recursos necessários e muitas vezes desconhecidos, como cuidados de saúde ao domicílio ou equipamento médico duradouro.

			análise dos prontuários de todos os doentes do VA-GRACE para identificar a extensão dos serviços recebidos. Realizou-se análises estatísticas e da avaliação da eficácia. Utilizando pontuações de propensão com ponderação sobreposta. Foi usado o Microsoft Excel para calcular estatísticas descritivas para os itens da escala de Likert (intervalo de resposta: 1-5). Foi realizado uma análise temática rápida dos dados qualitativos que apoiou as respostas dos participantes à escala de Likert. Os temas foram enviados à uma equipe de avaliação clínica que confirmou a saturação temática.	
"Mudou tudo": vozes de veteranos no programa de serviços domiciliares e comunitários. dirigido por veteranos	EUA,2018	Compreender o valor e o impacto do programa de Serviços Domiciliares e Comunitários Dirigidos por Veteranos (VD HCBS) na vida dos veteranos, a partir de suas próprias vozes.	O VD-HCBS é destinado a veteranos com condições crônicas de saúde ou deficiências que correm o risco de serem internados em uma instituição de cuidados de longa permanência que necessitam de mais de 20 horas de cuidados domiciliares por semana, são elegíveis para o nível de cuidados de uma casa de repouso ou têm três ou mais dependências para atividades da vida diária ou comprometimento cognitivo	Cinco categorias principais capturaram o conteúdo informativo fornecido pelos participantes em grupos focais e entrevistas: 1- Eu sou uma pessoa; 2- É um salva-vidas; 3- Voltando à vida; 4- Mantendo-me saudável e seguro e 5- Que diferença a escolha faz. Essas categorias refletem o que era mais importante para os veteranos sobre o programa VD-HCBS, que diferença o programa fez em suas vidas. Muitos deles enfrentavam condições neurodegenerativas e/ou de saúde mental graves que exigiam cuidados complexos e 24 horas por dia, incluindo o uso de ventiladores, sondas de

			significativo. Os participantes foram recrutados de setembro de 2014 a março de 2015. A amostra incluiu 21 Veteranos. Todos estavam em risco de colocação institucional com base em seu nível de deficiência. Quatro veteranos com condições neurodegenerativas foram entrevistados com um cônjuge ou cuidador atuando como assistente. A pesquisa se deu por grupos focais, e entrevistas individuais foram realizadas para acomodar os veteranos que preferiram essa alternativa e para facilitar o agendamento. Os dados quantitativos do questionário demográfico foram analisados utilizando estatística descritiva simples. Os dados qualitativos por meio da análise de conteúdo.	alimentação e constantes monitoramento por cônjuges, familiares e/ou cuidadores contratados. Mesmo com esse nível de necessidade, os participantes relataram como o VD-HCBS os ajudou a atingir seus objetivos de acordo com seus próprios valores. Os veteranos relataram sentir que o programa apoiou sua dignidade, os capacitou a fazer escolhas, melhorou sua capacidade de participar da sociedade novamente e os manteve saudáveis e seguros por meio de cuidados de qualidade.
Por que é melhor em casa? A percepção de usuários e cuidadores da atenção Domiciliar.	2017, Minas Gerais, Brasil.	Analisar as perspectivas dos usuários sobre os atendimentos de suas necessidades pelo serviço de Atenção Domiciliar.	Estudo qualitativo, com abordagem descritiva e exploratória, realizado entre fevereiro de 2014 e julho de 2015. Participaram do estudo 15 usuários e 15 cuidadores da Atenção Domiciliar de oito municípios de Minas Gerais. Realizou-se entrevistas com um roteiro semiestruturado com questões	A satisfação dos participantes relaciona o Serviço de Atenção Domiciliar como uma forma de evitar barreiras ao acesso, em especial para os serviços de diagnóstico e de consultas especializadas. Então, é Melhor em Casa porque o Programa abre as portas para outros pontos da rede, desta forma o usuário deste programa torna-se, diferenciado do conjunto geral dos usuários do sistema de saúde. Os resultados apontam que a satisfazer as necessidades de

			sobre os dados sociodemográficos e sobre o atendimento no Serviço de Atenção Domiciliar. Para a análise foi aplicada a análise de conteúdo temática, conforme Bardin.	saúde supõe o acesso às tecnologias, seja relacionado aos equipamentos e insumos ou as que indicam a leveza das relações estabelecidas no cuidado domiciliar representadas nos dados pela referência aos vínculos, acolhimento, escuta e presteza que as equipes produzem junto aos usuários e cuidadores. Esse conjunto de tecnologias é utilizado na mediação do trabalho na AD, resultando num campo intermédio que contribui para satisfazer tanto as necessidades naturais (contato social e cooperação) quanto as necessidades radicais (autonomia, autorrealização reflexão, entre outras). Dessa forma compreende-se que é Melhor em Casa porque além da configuração de um novo espaço de cuidado, ocorrem novas relações que ampliam o acesso, a autonomia e a qualidade de vida do usuário.
A percepção do cuidador sobre a atuação do fisioterapeuta no atendimento domiciliar de pacientes acamados.	2016, Ceará, Brasil.	Avaliar a atuação do fisioterapeuta do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) no atendimento domiciliar de pacientes acamados, sob a visão do cuidador.	Estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa, realizado no município de Horizonte – CE. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2016. Participaram da pesquisa 20 cuidadores de pacientes com condições neurológicas acamados, dentre os 28 cuidadores esperados., os quais são acompanhados através de visita domiciliar dos fisioterapeutas do NASF. O instrumento de coleta de dados foi	Os participantes relatam que estão satisfeitos com os serviços prestados pelos profissionais de fisioterapia, a ponto de recomendarem este serviço a outras pessoas. No entanto, nota-se uma pequena insatisfação dos participantes da pesquisa em alguns tópicos como horário da sessão, atenção dada às suas queixas, satisfação com o número de atendimentos e frequência no intervalo das sessões. Contudo, todos os cuidadores entrevistados relataram a satisfação de suas necessidades. Observa-se através do estudo que a visita domiciliar, no contexto da atenção em saúde, é um instrumento de assistência importante por contribuir para a

			construído e adaptado a partir de um questionário validado por Moreira <i>et al.</i>, contendo nove questões descritivas e 21 objetivas. A aplicação do questionário durou, em média, 30 minutos por participante. Os dados foram tabulados e apresentados como percentuais agrupados em tabelas, usando para isso o software Microsoft Office Excel 2007.	mudança de padrões de comportamento. Além disso, os fatores interpessoais colaboram para que haja um melhor vínculo entre cuidador e fisioterapeuta, ocasionando uma maior adesão ao tratamento domiciliar.
Atenção domiciliar do enfermeiro na estratégia saúde da família.	2015, São Paulo, Brasil.	Avaliar a visita domiciliar realizada pelos enfermeiros que trabalham na Estratégia Saúde da Família no município de Assis-SP por meio da percepção dos usuários que utilizam o serviço.	Pesquisa quantitativa, participaram 100 usuários que utilizam a saúde da família de 10 equipes de ESF do município de Assis-SP. A coleta de dados foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2014, por meio de visitas domiciliares com o auxílio do agente comunitário de saúde das ESFs, foi disponibilizado questionário com questões fechadas. A organização e análise dos dados foram realizadas com auxílio do Software Microsoft Excel.	A maioria dos usuários entrevistados estão satisfeitos com a atenção domiciliar dos profissionais das ESFs, conforme demonstrado nas respostas dos entrevistados. No item: Opinião dos usuários sobre a atenção domiciliar dos profissionais da ESF, 68% classificaram como ótimo, 23% como Bom, 7% como regular, 2% como ruim. No item: Grau de satisfação com atendimento geral do enfermeiro, 54% classificaram como ótimo, 32% como Bom, 11% como regular, 2% como ruim e 1% não respondeu. No item: Grau de satisfação com atendimento geral dos profissionais da ESF, 57% classificaram como ótimo, 35% como Bom, 8% como regular. No entanto devemos destacar que a maioria dos entrevistados relataram como um ponto negativo que a realização de visitas domiciliares não acontece como preconiza-se na PNAB (Política Nacional de Atenção Básica).

Satisfação dos cuidadores e dos idosos usuários do Programa Melhor em Casa.	2022, Brasil	Avaliar a satisfação dos cuidadores e dos idosos usuários do serviço de atenção domiciliar por meio do Programa Melhor em Casa e seus fatores associados.	Estudo transversal com dados da pesquisa nacional sobre o Programa Melhor em Casa, conduzida pela Ouvidoria Geral do SUS no período de abril a junho de 2017. Foram entrevistados 5.595 cuidadores e 950 idosos. A pesquisa foi feita a partir de um questionário composto de 22 perguntas, sendo três relacionadas ao perfil do paciente, uma sobre o cuidador – quando ele respondeu à pesquisa por impossibilidade do paciente de fazê-lo – e 18 questões relativas ao Programa Melhor em Casa. O questionário foi aplicado por meio de contato telefônico por teleatendentes, monitorados e supervisionados por uma equipe de profissionais de uma empresa de teleatendimento sob a orientação e supervisão da Ouvidoria Geral do SUS. A variável dependente foi analisada por meio de Análises de Classes Latentes (ACL). Após a criação da variável latente “satisfação” (variável dependente), foi realizado o teste de qui-quadrado de Pearson e análise dos resíduos padronizados para as medidas de associação entre a variável dependente e as	Mostraram-se satisfeitos com o serviço, 93,7% dos idosos e 90,2% dos cuidadores. Constatou-se que a maioria dos idosos e dos cuidadores demonstraram satisfação com o programa, havendo distinção nos aspectos associados a essa satisfação, nos quais apenas as características diretamente relacionadas ao programa influenciaram na satisfação, não ocorrendo o mesmo com as características socioeconômicas e demográficas.
--	---------------------	--	--	--

			independentes. Nos casos em que as suposições do teste não foram satisfeitas, aplicou-se o teste exato de Fisher. Todas as conclusões foram tiradas considerando o nível de significância de 5%. Como medida de efeito foi utilizado o odds ratio (OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95%, por meio de modelos de regressão logística multinomial. Foram realizadas análises simples e múltipla. Na análise simples foram eletivas para a análise múltipla as variáveis que obtiveram valor-$p < 0,2511$. Para a regressão múltipla foi utilizado o método forward e as demais conclusões foram tomadas com nível de significância de 5%. A análise estatística foi realizada por meio do programa Mplus 8 para a ACL e do Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20, para as demais análises.	
Significado da atenção domiciliar e o momento vivido pelo paciente oncológico em cuidados paliativos.	Sul do Brasil, 2015	Conhecer o momento vivido e o significado da atenção domiciliar para o paciente oncológico em	Pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa, fundamentada nos pressupostos da Teoria Humanística de Paterson e Zderad, realizada em uma cidade no Sul do Brasil. Fizeram parte do estudo cinco pacientes	A internação domiciliar mostra-se como espaço que permite liberdade, conforto e autonomia. Ainda, proporciona que a atuação da equipe de saúde possa contemplar os princípios dos Cuidados Paliativos, os vínculos são mais fortes e a atuação dos profissionais pode transformar o momento vivenciado por estes pacientes

		cuidados paliativos sob o olhar da teoria humanística de Paterson e Zderad.	oncológicos em cuidados paliativos, assistidos em seu domicílio pelo Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI) de um hospital escola. Os dados foram coletados nos meses de maio a agosto de 2013, por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados de acordo com os fundamentos da análise temática de conteúdo, em etapas conforme descrito por Minayo.	trazendo benefícios visíveis, objetivando a qualidade de vida. Também, permitiu conhecer as dificuldades enfrentadas, como o sentimento de tristeza frente à sensação de improdutividade com a progressão da doença, grande desafio para o serviço e para a equipe de saúde.
--	--	---	--	--

Fonte: Elaborado pela Autora (2026)

Após a análise crítica dos 9 estudos selecionados, constatou-se que 3 são estudos internacionais, sendo 01 realizado na República Tcheca e 2 nos Estados Unidos da América. Os outros 6 estudos foram realizados no Brasil em diferentes regiões (Sul, Sudeste, Nordeste e abrangência nacional), o que possibilita uma compreensão ampla sobre a satisfação com o SAD.

O período dos estudos nacionais vai de 2015 a 2022, mostrando uma continuidade da pesquisa sobre a satisfação do paciente e/ ou cuidador referente ao Serviço de Atenção Domiciliar no Brasil. Os estudos internacionais mais recentes são de 2018 e 2022, indicando interesse global no tema, especialmente nos últimos anos.

O Brasil foi pioneiro em pesquisas sobre a satisfação referente ao Serviço de Atenção Domiciliar na perspectiva do paciente e/ ou do cuidador, no período entre 2015 e 2017, enquanto estudos internacionais aparecem apenas em 2018 e 2022, sendo 2022 o ano com maior produção internacional e destaca-se por ter estudos tanto nacionais quanto internacionais, o que sugere que o tema é relevante tanto no Brasil quanto globalmente, provavelmente impulsionados pela pandemia, envelhecimento populacional e avanços em políticas de saúde, e o Brasil pode se beneficiar de experiências internacionais recentes, adaptando modelos e práticas inovadoras.

Em relação a metodologia empregada nos estudos analisados, foram utilizadas as abordagens Qualitativa, Quantitativa e Misto/Observacional, sendo a abordagem Qualitativa a mais empregada, abrangendo 5 estudos, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 8 – Tipos de abordagem metodológicas

Abordagem Metodológica	N °
Abordagem Qualitativa • Entrevistas semiestruturadas; • Análise de conteúdo temática; • Grupos focais.	5
Abordagem Quantitativa • Questionário estruturado; • Análise estatística; • Regressão logística.	3
Abordagem Misto/Observacional • Coorte retrospectivo; • Entrevistas; • Análise estatística e qualitativa.	1

Fonte: Elaborado pela Autora (2026)

Ao analisar o desfecho quanto a satisfação, de um modo geral, é predominante um grau de satisfação elevada em todos os estudos, tanto nacionais quanto internacionais, os termos “incrível”, “ótimo”, “perfeito”, “excelente” e “muito satisfeitos” aparecem nos relatos dos participantes dos estudos qualitativos. Da mesma forma nos estudos quantitativos os percentuais são altos, mais de 90% dos idosos e cuidadores relataram satisfação com o SAD.

Dentre os benefícios sentidos e relatados pelos participantes durante o atendimento domiciliar podemos destacar: A qualidade técnica e humana dos profissionais: O cuidado prestado por enfermeiros e fisioterapeutas treinados, experientes e com boa comunicação é citado como fator de satisfação; O vínculo e a continuidade: A continuidade do pessoal de enfermagem e o vínculo estabelecido com os profissionais são valorizados; O acesso facilitado: O atendimento domiciliar é visto como uma forma de superar barreiras de acesso a serviços de saúde, especialmente para diagnósticos e consultas especializadas; A autonomia e a dignidade: Os usuários relatam que o cuidado domiciliar promove autonomia, dignidade e participação social; A redução de deslocamentos: A assistência em casa reduz o desgaste físico e emocional de deslocamentos frequentes para hospitais ou unidades de saúde; O apoio emocional: O cuidado domiciliar é percebido como um suporte não só físico, mas também emocional, especialmente em situações de doenças crônicas ou terminais.

Os idosos destacam mudanças positivas em sua saúde e qualidade de vida após as intervenções domiciliares pois permitem que eles façam escolhas e participem ativamente do seu próprio cuidado. Além dos pacientes, os cuidadores também relatam satisfação, especialmente quando sentem que suas necessidades e as dos idosos são atendidas.

Embora de uma forma geral os índices de satisfação com o SAD foram considerados elevados, houve relatos de alguns pontos de insatisfação pontuais e desafios que ainda precisam ser superados, como por exemplo: Alguns participantes relataram insatisfação com horários das sessões de fisioterapia no atendimento domiciliar, frequência das visitas, atenção às queixas e o intervalo entre as sessões. Também em alguns contextos, a realização das visitas domiciliares não ocorre conforme preconizado pelas políticas públicas, o que pode gerar frustração.

Após a análise dos estudos, conclui-se que os desfechos sobre a satisfação são predominantemente positivos, destacando o SAD como uma forma de cuidado humanizado, que promove a autonomia e a valorização do vínculo entre a equipe e o paciente. Pontos de insatisfação existem, mas são a minoria e geralmente são relacionados a questões pontuais, sugerindo que o aprimoramento da gestão pode elevar ainda mais os índices de satisfação.

7.2 SEGUNDA ETAPA

Para responder aos objetivos específicos, por meio da abordagem qualitativa, com uma pesquisa de campo e entrevistas com cuidadores, foram respondidos os objetivos 2,3,4 e 5 (2- Identificar como aconteceu a continuidade do cuidado no ambiente hospitalar na perspectiva do cuidador; 3- Descrever a experiência dos cuidadores sobre o seu preparo para desempenhar os cuidados no domicílio; 4- Explorar a percepção do cuidador sobre a atuação do Serviço de Atenção Domiciliar na continuidade do cuidado e 5-Analisar as potencialidades e fragilidades relatadas pelos cuidadores na continuidade do cuidado).

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Participaram da pesquisa 12 cuidadores, a média de idade dos participantes foi de 46 anos, sendo todos (100%) de nacionalidade brasileira, 9 (75%) do sexo feminino, 3 (25%) do sexo masculino, 7 (58,33%) da etnia branca, 5 (41,67%) da etnia parda, 9 (75%) eram casados, 1 (8,3%) era solteiro, 1 (8,3%) viúvo, 11 (91,67%) moravam em casa própria, 1 (8,3%) morava em casa cedida, 7 (58,33%) possuíam renda familiar de 1 a 2 salários-mínimos, 2 (16,67%) possuíam renda familiar de 2 a 3 salários-mínimos, 3 (25%) possuíam renda familiar de mais de 3 salários-mínimos, 4 (33,3) não possuíam dependentes, 8 (66,6%) possuíam dependentes. Referente à ocupação 6 (50%) estavam desempregados, 3 (25%) eram aposentados, 2 (16,67%) trabalhavam como autônomo, 1 (8,33) trabalhava como empregada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), referente ao grau de instrução 1 (8,33%) possuía o ensino fundamental incompleto, 3 (25%) possuíam o ensino fundamental completo, 4 (33,33%) possuíam o ensino médio completo, 2 (16,67%) possuíam o ensino superior incompleto e 2 (16,67%) possuíam o ensino superior completo. Os dados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados Sociodemográficos dos participantes

Indicador	Categoria	Quantidade	Porcentagem (%)
Nacionalidade	Brasileira	12	100
Gênero	Feminino	9	75
Gênero	Masculino	3	25
Etnia	Branca	7	58,33
Etnia	Parda	5	41,67
Estado civil	Casado(a) ou amasiado (a)	10	83,3
Estado civil	Solteira	1	8,3
Estado civil	Viúva	1	8,3
Moradia	Casa própria	11	91,67
Moradia	Casa cedida	1	8,33
Renda familiar	1 a 2 salários-mínimos	7	58,33
Renda familiar	2 a 3 salários-mínimos	2	16,67
Renda familiar	Mais de 3 salários-mínimos	3	25
Dependentes	Não	4	33,3
Dependentes	Sim	8	66,6
Ocupação	Desempregada	6	50
Ocupação	Aposentado(a)	3	25
Ocupação	Autônomo(a)	2	16,67
Ocupação	Empregada CLT	1	8,33
Escolaridade	Ensino fundamental (incompleto)	1	8,33
Escolaridade	Ensino fundamental (completo)	3	25
Escolaridade	Ensino médio completo	4	33,33
Escolaridade	Ensino superior (incompleto)	2	16,67
Escolaridade	Ensino superior (completo)	2	16,67

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Na sequência, são apresentadas as entrevistas com os participantes da presente pesquisa.

7.4 ENTREVISTAS COM OS PARTICIPANTES

A partir das entrevistas realizadas com os participantes foram delineadas cinco categorias temáticas que respondem aos objetivos propostos e destas cinco categorias

emergiram 18 subcategorias as quais possuem articulação com os eixos comuns do referencial teórico para continuidade do cuidado (Quadro 3) como demonstrado no Quadro 9.

Quadro 9 – Categorias e Subcategorias

Eixos comuns para continuidade do cuidado	Categoria temática	Subcategoria
Planejamento de Alta	Planejamento e abordagem médica para a alta	Informação efetiva e acolhedora; Abordagem limitada e pouco segura; Alta planejada e comunicada ao cuidador; Ausência e descontinuidade do planejamento no preparo da alta.
Comunicação	Comunicação entre a equipe de saúde e o cuidador	Atendimento e comunicação da equipe de saúde com o cuidador; Comunicação fragilizada e desarticulada entre a equipe de saúde e entre a equipe e o cuidador durante a internação.
Reconciliação e autogestão de medicamentos;	Autonomia e segurança terapêutica	Compreensão das orientações da terapia medicamentosa; Lacuna em orientação sobre uso do medicamento.
Educação em saúde para o usuário e o cuidador/familiar.	Educação em saúde para o cuidado domiciliar	Preparo do cuidador durante internação, para desempenhar cuidados no domicílio; Ausência do preparo do cuidador para desempenhar os cuidados domiciliares; Habilidade para desempenhar os cuidados fortalecida pela educação em saúde e cuidador experiente; Orientação insuficiente para os cuidados domiciliares.
Continuidade do cuidado e Acompanhamento do paciente no pós-alta	Continuidade do cuidado	Alta com relatório médico e encaminhamento ambulatorial; Falha no encaminhamento ambulatorial;

		Barreiras no acesso aos medicamentos e materiais médico-hospitalares para os cuidados domiciliares; Percepção do cuidador sobre a visita domiciliar; Falta de encaminhamento médico para o SAD; Dificuldades no cuidado
--	--	--

Fonte: Elaborado pela Autora (2026)

As categorias e subcategorias temáticas apresentadas no Quadro 9 serão apresentadas detalhadamente a seguir, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais ampla do conteúdo.

a) Categoria - Planejamento e abordagem médica para a alta

Nesta categoria, os participantes relataram como ocorreu o repasse das informações sobre o tratamento e planejamento de alta pelos profissionais médicos. Destacando aspectos referentes a efetividade, acolhimento, segurança, ausência e descontinuidade do planejamento no preparo da alta, conforme apresentado nas subcategorias a seguir.

Subcategoria: Informação efetiva e acolhedora; as falas a seguir demonstram que, na admissão, os profissionais médicos forneceram as informações pertinentes ao tratamento clínico que seria instituído ao usuário.

“[...] Tinha um médico lá que falou que ia tentar um procedimento via endoscopia, para fazer a desobstrução da traqueia dele, para ver se a estenose diminuía, via endoscopia, ia deixar um pouquinho e ia verificar se essa estenose diminuiria, de certa forma, para que ele pudesse ter um pouco de qualidade de vida. Foi feito esse procedimento [...] e não resolveu. Quando foi retirado, não resolveu para ele, ele continuou da mesma forma. Então, um médico reuniu a família novamente, falou que ele seria transferido para a UTI para fazer uma traqueostomia [...]” (Cuidador 5).

“[...] Quando a equipe médica passava, a gente perguntava, né? A equipe médica passava todo dia, daí quando passava, a gente perguntava alguma coisa. “Vamos fazer um exame disso, vamos fazer um exame daquilo, isso é pra saber como é que tá a tal coisa.” Então eles explicavam [...]” (Cuidador 6).

“[...] eles repassavam as informações, depois que eu estava com ele já no quarto, daí ali eu tenho todo o acesso. O médico me passava certinho o que ele tem, a cada exame que era feito, o médico vinha e me passava o que estava acontecendo [...] Sim, sim, Perfeito. Cada médico que troca o plantão vinha e ele passava as informações, tudo certinho [...]” (Cuidador 11).

Outro aspecto relevante percebido nas falas dos participantes, a seguir, é que eles se sentiram acolhidos pelos profissionais médicos no momento do repasse das informações:

“[...] eu tenho, assim, um relacionamento muito bom com os médicos, eles conversam comigo [...] aí ele falou não, porque é muito perigoso estar dentro do hospital, por causa das bactérias que tem aqui dentro, ele não vai ter que tomar mais 7 dias de antibiótico, ele já tinha tomado 7, então é no máximo 7 dias. Mas como ele tem KPC que veio com um nome diferente, que eu não lembro é um nome difícil é na urina e então em menos de 3 dias ele já estava aqui dentro de novo, então não vou dar mais 7 dias para ele, mas assim é, se ele piorar, a gente vai estar mais 7 dias, aí eu falei, então tá bom, doutor [...]” (Cuidador 2).

“Fomos muito bem acolhidos e recebidos pelo médico. Na hora, inclusive, ele falou sobre cuidados paliativos, porque parecia ser bem grave, o caso dela já era o terceiro AVC, mas foi muito educado, muito ponderado, muito empático nas palavras [...]” (Cuidador 7).

“[...] foi tudo tranquilo, assim, fui bem atendida [...] eles foram bem atenciosos com ela [...] falou assim, ele já explicou para mim, né, que poderia ser uma infecção do pulmão[...]foi bem atendida [...]” (Cuidador 8).

“[...] foi muito bom [...] quando ele chegou no hospital, o médico veio lá e falou que ele ia ser internado e ia ficar em tratamento [...] falou que não tinha dado outro AVC e estava com pontada e tinha que ficar lá uns dias [...]” (Cuidador 9).

Subcategoria: Abordagem limitada e pouco segura.

Embora nas falas anteriores é demonstrado que houve repasse de informações na admissão do usuário na instituição hospitalar, quando foi questionado sobre a clareza e entendimento dessas informações, alguns dos participantes relataram dificuldades no entendimento, quando repassado por estudantes, principalmente médicos residentes:

“[...] A única coisa assim mesmo é que os médicos que ficam lá, a maioria assim são aqueles que estão estudando ainda, sabe? Aí às vezes tu perguntas coisas eles não sabem bem te responder tudo e daí você pergunta uma informação, eles não sabem [...]” (Cuidador 1).

“[...] Chegando na visita, veio uma médica, uma senhora, uma moça bem novinha assim, e disse bem assim pra gente 'Ah, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês.' Eu falei 'Opa, boa notícia, deve ser coisa boa, né?' 'Ah, o senhor [...] não estava com torção intestinal.' Estava tudo certo, mas a gente abriu e não precisou fazer nada porque ele não teve uma torção intestinal [...] tá, mas se ele não teve uma torção não tinha como você vê isso antes? você precisava fazer a cirurgia? que é uma laparotomia [...] aí eu perguntei, eu falei para essa moça que estava lá, que veio me passar e falar assim tá, mas vocês não fizeram a limpeza que vocês deveriam ter feito, que você sabe o que deve ser feito? Ela falou não, porque a gente está dando medicação para ele para que o corpo dele faça esse processo. Eu falei doutora, vamos ser sinceros nas duas aqui. Eu falei é um paciente acamado. É um paciente que não levanta, é um paciente que não está andando, que não está se movimentando. Que medicação que você deu para ele para que o intestino dele volte a funcionar naturalmente, que a senhora sabe que não vai voltar, entendeu? A senhora sabe que não vai, que ele precisa [...]” (Cuidador 5).

“[...] Entre eles falando, a gente não entendia, mas daí a gente pedia. Explica pra nós que nós não entendemos nada. Aí eles explicavam. Porque na língua dos médicos é diferente, né [...]” (Cuidador 6).

“[...] Então, as primeiras informações foram para o meu irmão[...] só que ele não entendeu, ele acabou me explicando errado o que o meu pai tinha [...] daí eu demorei um pouco para descobrir o que realmente tinha acontecido com o meu pai. Foi eu perguntando para as enfermeiras que eu descobri o que meu pai tinha, porque com os médicos eu não conseguia saber o que o meu pai tinha, entendeu? [...] Ela não é a médica mesmo, ela tá acho que estudando ainda, tá no primeiro ano dela, né, de medicina [...] ela não sabia explicar as coisas pra gente. Ela tinha uma dificuldade com ela [...] eu não entendia muito bem por que ela falava com as coisas meio por cima, daí a gente não conseguia entender o que estava acontecendo com o meu pai. A gente só foi entender quando veio o médico mesmo, o médico cirurgião, quando veio, as enfermeiras falando, no meu caso, eu entendi que estava se passando com o meu pai. Mas quando veio essa médica residente, eu não conseguia entender o que estava se passando com o meu pai [...]” (Cuidador 12).

Subcategoria: Alta planejada e comunicada ao cuidador

Quando foi questionado aos respondentes sobre o planejamento da alta médica, a maioria relatou que foram informados sobre o plano de alta:

“[...] Sim, foi falado, né? Foi falado na sexta-feira, doutor [...] me falou, aí ele foi de alta na segunda-feira [...]” (Cuidador 2).

“[...] uma semana antes ele já falava, vai tá de alta [...]” (Cuidador 6).

“[...] Um dia antes. Sim [...]” (Cuidador 7).

“[...] Acho que uma semana antes [...]” (Cuidador 10).

“[...] Na verdade, ele estava esperando soltar o intestino dele. Quando a gente subiu para a clínica médica, já foi mais pelo abdômen distendido. Então daí aqueles que estavam tentando fazer soltar o intestino. Daí foi passado com o cirurgião, não, o gastro. Daí o médico residente falou que ia no outro dia ia passar o gastro, para estarem avaliando melhor o quadro dele e daí dependendo já ia ter alta. E passou o gastro no domingo de manhã, fez avaliação, logo em seguida, graças a Deus, soltou o intestino e daí ele já me avisou que ia dar alta [...]” (Cuidador 11).

“[...] Foi uns quatro dias antes, mas antes, no mesmo dia ele (médico) veio para o quarto e eles (equipe desospitalização) já vieram falar da desospitalização que era as informações do que a gente tinha que fazer em casa, como dar a dieta, se ele viesse para casa com a dieta (sonda enteral), como cuidar da traqueo, porque ele está com a traqueo, como fazer a higienização dos equipamentos, a gente fazer a higienização nele, tudo isso deu no hospital antes de vir para casa, mas demorou uma semana e pouquinho para a gente sair do hospital nesse tempo eles estavam preparando a gente e ao mesmo tempo deixando dando tempo pra gente preparar as coisas para trazer para casa do meu pai [...]” (Cuidador 12).

Subcategoria: Ausência e descontinuidade do planejamento no preparo da alta

Em algumas situações foi evidenciado a ausência de planejamento para a alta, demonstrada através da fala a seguir, uma vez que o cuidador fala que foi informado sobre a alta no dia em que ela ocorre;

“[...] Eles me informaram depois de oito dias que ela estava lá, internada, daí achou melhor mandar para casa para acabar de tomar um antibiótico em casa, eles me mandaram no mesmo dia, eles falaram assim que ela hoje vai ganhar alta [...]” (Cuidador 8).

A seguir, pode-se observar a falta de planejamento, pois o cuidador foi informado do protocolo da alta em um dia e no mesmo dia a noite já comunicaram a alta médica, não havendo tempo hábil para a organização do domicílio e equipamentos.

“[...] A médica falou que ele ia entrar no protocolo de alta [...] aí foi pedido para a família comparecer até lá. Então, o que a gente disse

para a médica naquele dia? Olha, vocês estão dando agora para a gente, a gente precisa se organizar, a gente precisa comprar um sugador, a gente precisa adaptar a casa para ele, arrumar a casa para ele, visto que a esposa dele se evadiu, então a gente precisa se organizar. Ai assim, a gente não vai levar [...]” (Cuidador 5).

Neste mesmo caso, o usuário estava sendo acompanhado por mais de uma especialidade e as orientações para a alta não ocorreram de forma coordenada, demonstrando a ausência de planejamento por parte de todas as áreas médicas envolvidas.

“[...] Ainda faltava alta dos outros médicos, o clínico, as outras especialidades que estavam atendendo ele, ainda faltava alta daquele pessoal. Só que daí passou no outro dia, já no outro dia, isso foi à noite. Ligaram pra gente dizendo que ele estava de alta [...]” (Cuidador 5).

Na fala a seguir podemos observar que as orientações ocorreram de forma fragmentada, e que foi o médico plantonista e não o médico que estava acompanhando o usuário durante a internação que realizou a orientação sobre a alta.

“[...] A única pessoa que falou comigo foi a nutri e a fono e daí já no outro dia (a assistente social) passou para gente já que ele tava de alta, aí eu fui até o hospital, daí pedi para falar com o médico cirurgião. Aí a assistente social chamou um médico cirurgião que estava de plantão. Ele veio até ali porque eu queria entender como é que seria a alta dele, o procedimento, como é que seria ali sobre a cirurgia dele, tudo mais. Aí essa assistente social meio com má vontade. Ela conseguiu chamar o médico, o médico explicou pra gente [...]” (Cuidador 5).

Com este mesmo usuário a documentação de alta não foi repassada para o cuidador e sim para o usuário que estava em uso de traqueostomia e impossibilitado de falar.

“[...] Daí já tinha deixado com ele. E como que você entrega os papéis de alta para uma pessoa que não fala? Como é que a família vai se organizar? Tipo assim, como é que ele vai explicar para mim? [...]daí no protocolo de alta dele que entregaram para ele tinha lá a receita dele do que ele tava tomando dos Remédios que ele precisaria tomar tinha ali a medicação que o médico passou sobre a cirurgia que ele teria que tomar, anti-inflamatório por mais sete dias, foi passado para ele também ali é esse negócio de gases, as coisas que eu não consegui no posto de saúde, mas eles encaminharam [...]” (Cuidador 5).

Nas próximas falas, foi identificado que houve o planejamento da alta em conjunto com a equipe de saúde, desospitalização, SAD e o cuidador, porém o planejamento não foi seguido pela equipe de saúde.

“[...] Para mim uma coisa assim que eu fiquei bem de cara mesmo, que aconteceu na desospitalização dela foi o seguinte; o Combinado comigo no hospital foi o que? Tanto que não foi só comigo, foi com a doutora do SAD, que avaliou ela. Que era o quê? Que a minha mãe ia sair do hospital com oxigênio, porque a minha mãe não conseguia sair sem oxigênio. Aí ela saturou bem a manhã inteira e eles mandaram minha mãe ir para casa sem oxigênio [...] sendo que ela ficou 2 meses usando oxigênio no hospital, ela foi entubada tudo e daí uma manhã que ela saturou bem, eles me mandaram sem oxigênio. Daí eu até no dia que foi receber alta, ainda fui lá, falei com enfermeiras, chefe que estava lá e falei, gente, não foi isso que foi combinado comigo, não foi isso que foi combinado com a médica do SAD [...] porque até mesmo a enfermeira da desospitalização ela tinha combinado comigo que a minha mãe ia para casa com oxigênio, que o hospital ia me emprestar o oxigênio até que a prefeitura viesse trazer o que a prefeitura empresta [...] Ela veio sem oxigênio, na sexta-feira [...]” (Cuidador1)

Essa descontinuidade do planejamento da alta ocasionou grandes transtornos para o cuidador e risco para o usuário, devido vários episódios de queda na saturação de oxigênio, como pode-se observar nas falas a seguir.

“[...] Daí passei o final de semana bem doida, o tempo todo, controlando pelo oxímetro. Eu comprei o oxímetro, tanto que na sexta-feira quando eu vi que ela veio sem oxigênio, eu fiquei desesperada [...] por que eles me disseram lá no hospital, que até 86 para ela, ainda estava de boa, porque ela fumou a vida inteira [...] Jacordava 20 vezes na noite para ir lá ver como é que estava, daí tinha vez que do nada, assim você ia lá, estava 72 ou 70. Aí eu ia correndo, aspirava, aspirava, levantava ela para ver se voltava, né? Já com o celular na mão para ligar para o SAMU. Mas daí, graças a Deus, todas as vezes que eu aspirei, que eu levantei aí tudo voltou, aí não precisou ser internada nesse final de semana, né? Aí na segunda-feira de manhã o SAD me trouxe o oxigênio [...]” (Cuidador 1).

b) Categoria - Comunicação entre a equipe de saúde e o cuidador

Nesta categoria as falas demonstram como ocorreu a comunicação entre o cuidador e equipe de saúde, sendo dividido em duas subcategorias apresentadas a seguir.

Subcategoria: Atendimento e comunicação da equipe de saúde com o cuidador

Quando foi questionado sobre como foi a comunicação da equipe de saúde com os cuidadores, as falas refletem que os cuidadores relacionam o bom atendimento com a comunicação.

“[...] Acho que assim foi bem tranquilo assim. Quero ressaltar que o tempo todo assim, os enfermeiros assim que me atenderam lá, sabe? Todos assim foram muito cuidadosos. Tinha um carinho muito grande por ela, no que podiam me ajudar, me ajudavam [...]” (Cuidador 1).

“[...] Ele foi bem atendido, até porque o caso dele né, era extremamente complicado, né? Fizeram o que tinha que fazer e ele melhorou. Assim eu para dizer a tal coisa. Tem que melhorar aquilo ali, não. Para mim está tudo bem [...]” (Cuidador 4).

“[...] É importante, sim, porque a gente tá lá e vê que os médicos estão dando atenção, né? A gente saía a sonda, corria chamava, atendiam, tratava dele com carinho, então isso é muito importante pra gente, porque já teve internação, assim, que a gente o médico estava nem aí, outras vezes foi internado, não ele, né? Eu já tive tempo com meus filhos internados, mas com ele foi bem atendido, não tem que reclamar [...]” (Cuidador 6).

“[...] Foi tudo muito bem. Ela foi para uma área de isolamento por causa da que ela teve, ela tava com uma bactéria também, ela teve uma bactéria resistente que foi multirresistente, que foi o que ocasionou [...] ela ficou no isolamento. Então ficou num quarto sozinha e tal. Então, foi diferenciado de ela ficar num quarto de enfermaria, por exemplo [...]” (Cuidador 7).

“[...] Foi tranquilo [...]” (Cuidador 8).

“[...] Foi muito bom [...]” (Cuidador 9).

“[...] É, perfeito. Então eles atendem muito bem, a gente já conhece a maioria deles, então faz tempo que a gente vai lá, então é muito bom o atendimento deles [...]” (Cuidador 11).

Na fala a seguir, demonstra-se que houve a comunicação da equipe de saúde, porém de forma isolada, evidenciando a fragmentação nas condutas dos profissionais

“[...] Foi os próprios enfermeiros que perguntavam: "Ah, você que vai ser a cuidadora do seu pai, falei sim, então, a gente já vai passando aqui pra você o que você tem que fazer em casa." Porque daí alguns não falavam, alguns falavam, né? "Isso, eu já vou te passando, então, porque no caso você conseguir cuidar do seu pai sozinha, porque aí vai

ser difícil, as primeiras semanas vão ser difícil pra você se adaptar. Então, aqui no hospital a gente já vai ter que aprender algumas coisas. Daí iam me passando, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, um de cada ia lá e falava para mim, né, como que eu tinha que fazer [...]” (Cuidador 12).

“[...] na verdade eles queriam dar alta para ele antes de fazer a cirurgia plástica na parte do testículo, eles queriam mandar ele para casa todo aberto. E daí com bastante insistência e com a ajuda das moças que fazem o curativo, daí o médico fez a cirurgia plástica ali [...]” (Cuidador 10).

Subcategoria: Comunicação fragilizada e desarticulada entre a equipe de saúde e entre a equipe e o cuidador durante a internação.

Nessa fala é possível identificar que o profissional não apresentou articulação na comunicação com o cuidador, apenas impôs como argumento para a sua conduta a rotina da instituição.

“[...] Daí ela falou assim, não vou fazer nada, não vou chamar a médica, aqui só chama o médico se for caso de emergência. Daí eu virei e falei assim pra ela, ó se acontecer alguma coisa com meu filho que nem aconteceu há anos atrás, eu não fiz nada, você vai ser responsável? Aí ela viu e falou assim, eu sou responsável, você está enganada, brigou comigo [...]” (Cuidador 2).

Observa-se na fala seguinte que a comunicação entre o cuidador e a equipe ocorreu, porém houve falha na comunicação entre os integrantes da equipe de saúde, ocasionando prejuízo ao usuário.

“[...]Ele internou no domingo, na quarta ele teria uma consulta, retorno com o vascular que amputou a perna, e eu solicitei para médica, avisei ela na segunda-feira, que ele teria na quarta a consulta e ela mandou uma mensagem para o médico, eu fiquei aguardando perguntando todos os dias lá se o médico viu se o médico passou, mas parece que não passou, então ele acabou perdendo essa consulta que estava tão fácil ali de resolver o problema né que era só ir lá olhar ele, e dizer que está tudo ok com a amputação [...]” (Cuidador 3).

“[...]Eu nem fui atrás porque eu não tenho condições de levar ele, juntar ele e colocar no carro aí se eu for pedir hoje tem que pedir um transporte para ir, um transporte para voltar, aí o transtorno de tirar ele do quarto e a maca não entra lá tem que carregar ele até o chão aqui pra colocar ele na maca [...]” (Cuidador 3).

Na fala abaixo é evidenciado que mesmo após questionamentos por parte do cuidador não houve respostas satisfatórias, evidenciando a falta de articulação e fragilidade na comunicação.

“[...] assim eu lembro que todos os meus questionamentos assim elas nunca chegaram para falar assim olha é assim assado ele tá assim [...] tudo que você perguntava, eu não sei, eu vou ver, tem que ver quem é enfermeira dele, eu não sou a enfermeira dele, tem que vir na hora que o médico tá, tem que isso, tem que aquilo outro. Tanto que depois que ele fez a cirurgia, eu questionei o médico que estava passando, falei assim, doutor, eu fico muito surpresa, que o senhor, sendo o médico, o senhor tem que acompanhar a evolução do seu paciente. E o senhor não percebeu que o teu paciente estava aí há 12 dias sem ele defecar, o senhor não percebeu, o senhor não se preocupou em ver a situação que ele estava. Mesmo eu falando que estava com o abdômen distendido, mesmo eu perguntando se estava defecando, mesmo eu questionando o porquê da cor da urina, daquela cor que estava. Ele não foi me responder para mim. Eu falei então eu fico muito surpresa porque eu questionei, eu perguntei tantas vezes, eu perguntei muitas vezes, eu falei tá ou não tá [...]” (Cuidador 5).

c) Categoria - Autonomia e segurança terapêutica

Nesta categoria percebe-se que os participantes receberam orientações sobre a terapia medicamentosa, pois eles relatam de forma detalhada sobre a forma de uso e alguns citam os nomes dos medicamentos, e relataram não ter dúvidas quanto à administração de medicamentos.

Subcategoria: Compreensão das orientações da terapia medicamentosa.

“[...] no hospital, ela começou a tomar o levetiracetam, porque ela começou a convulsionar, né? Aumentou a dose do risperidona. Daí Ela tomava morfina no hospital. Esses medicamentos que mudaram, assim, daí depois de um tempo, ela começou a tomar aquele atenolol [...] Não tive nenhuma dúvida, foi tranquilo” (Cuidador 1).

“[...] Sim, as medicações é a domiciliar, o médico [...] queria chamar a equipe da psiquiatria para a retirada das medicações [...] e colocar um pouco menos. Aí eu conversei com o médico [...] falei, não, doutor, eu vou viver como daí? porque ele é agressivo, ele me bate, Ele tem muita força, daí ele falou, então está bom, vamos deixar do jeito que está, nem vamos mexer [...]” (Cuidador 2).

“[...] É eles alteram um pouquinho lá pela situação momentânea ali, e avisam sempre, ó não vamos dar isso, vamos dar aquilo, bem tranquilo [...]” (Cuidador 3).

“[...] E daí ele toma captopril, mais um outro medicamento e o continuou tratamento com o medicamento que a gente levou de uso contínuo, Só uma bombinha que eles mudaram. Ele usa uma bombinha que ele usava 3 ou 4 vezes por dia. Passaram uma outra que é mais forte, não lembro o nome dela agora. E ele só pode usar 2 vezes por dia. Parece que isso foi que melhorou bastante [...]” (Cuidador 4).

“[...] Teve, teve bastante mudança porque mesmo dessa ferida que veio de lá, não estava dando certo. Aí o médico passou outra medicação, daí a gente comprou, aí deu certo [...]” (Cuidador 6).

“[...] Não, não houve mudança na medicação[...] manteve o mesmo, os cardíacos [...]” (Cuidador 7).

“[...] Ela já tomava, e ela permaneceu com os mesmos remédios [...]” (Cuidador 8).

“[...] Fui informada [...] houve mudança que ela tomava duas vezes por dia, agora ela vai tomar três [...]” (Cuidador 9).

“[...] Sim, foi orientado [...] Não usava nada. E depois, agora que ele veio, ele tem medicações que ele faz uso [...] foi passado vários medicamentos para dor e psiquiatra também, passou vários medicamentos [...]” (Cuidador 10).

“[...] Sim, tanto do médico que passava para o enfermeiro e o enfermeiro também me comunicava. [...] O efeito colateral não chegava a me falar, mas que eles me falavam qual medicação estava sendo dada[...] não houve mudança. Até toda vez eu conversava com o médico e com o enfermeiro e manteve a medicação dele. Eles mantiveram a medicação e o que entrou a mais, eles davam certinho lá. Então, eu mantive a medicação e os horários. Até eles explicaram, você pode continuar dando a medicação que ele faz uso contínuo, e a gente acrescenta [...]” (Cuidador 11).

Subcategoria: Lacuna em orientação sobre uso do medicamento

“[...]a questão do remédio do Parkinson, como que eu deveria dar depois de tudo isso que aconteceu com ele, eu não recebi informação. E isso eu fui ganhar informação do próprio médico da SAD que veio em casa. Aí ele me passou como que eu deveria continuar dando o remédio para o meu pai [...]” (Cuidador 12).

“[...] não houve mudança de medicação na internação. Não houve, tudo se manteve [...] entregaram para ele tinha lá a receita dele do que ele tava tomando dos Remédios que ele precisaria tomar, tinha ali a medicação que o médico passou sobre a cirurgia que ele teria que tomar anti-inflamatório por mais sete dias [...] mas não foi orientado sobre medicação [...]” (Cuidador 5).

d) Categoria - Educação em saúde para o cuidado domiciliar

Esta categoria compreende a experiência dos participantes sobre o seu preparo para desempenhar os cuidados no domicílio.

Subcategoria: Preparo do cuidador durante internação, para desempenhar os cuidados no domicílio. Nas falas a seguir, os cuidadores afirmaram ter recebido orientações específicas para os cuidados.

“[...] Geralmente eu ficava de manhã, né? Eu já falava para as enfermeiras, vamos dar banho logo que eu estou aqui, que eu quero ajudar[...] então daí o fisioterapeuta me ensinou a aspirar, me ensinou a trocar o cordão, né? Me ensinou todos os cuidados com a traqueia e me ensinou os exercícios, né? Pra não atrofiar. Daí a nutri me explicou sobre as receitas, né? Por que ela usa uma sonda que, como é que tinha que fazer, como é que fazia limpeza [...]” (Cuidador 1).

“[...] Nós tivemos uma aula lá de uma pessoa com a fisio, né? A fisio foi lá antes, ensinou tudo certinho, inclusive algumas vezes no hospital mesmo a gente fazia, minha esposa que fazia a aspiração [...]” (Cuidador 4).

“[...] Sim teve, tudo que eles passavam lá e falavam que está de alta, tem que fazer assim. Deu uma lista, tudo escrito que tinha que fazer, que não tinha que fazer [...]” (Cuidador 6).

“[...] Eles falaram para mim que eu tinha que é dissolver tudo na água, porque como é comprimido, era difícil dela engolir e dar a dose ali certinha pela sonda. Depois que eu desse o remédio, passasse a água para fazer a limpeza da sonda [...]” (Cuidador 8).

“[...] Então eu não recebi assim cursos, nem nada, do tipo, foram os próprios enfermeiros que perguntavam: "Ah, você que vai ser a cuidadora do seu pai, falei sim, então, a gente já vai passando aqui pra você o que você tem que fazer em casa." Porque daí alguns não falavam, alguns falavam, né? "Isso, eu já vou te passando, então, porque no caso você conseguir cuidar do seu pai sozinha, porque aí vai ser difícil, as primeiras semanas vão ser difícil pra você se adaptar.

Então, aqui no hospital a gente já vai ter que aprender algumas coisas. Daí iam me passando e foi enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, um de cada ia lá e falava para mim, né, como que eu tinha que fazer, mas não precisamos de um curso nem nada. Só foi a explicação deles mesmo quando eu estava no hospital com meu pai [...] (Cuidador 12).

Subcategoria: Ausência do preparo do cuidador para desempenhar os cuidados domiciliares. Durante análise dos dados observou-se que alguns dos cuidadores não receberam o treinamento dos cuidados por já possuírem experiências de internações anteriores, como demonstrado nas falas a seguir.

“[...] Sim, já faz 12 anos que ele usa os dispositivos de traqueo e cistostomia, então, na época, assim eu sabia já os cuidados [...]” (Cuidador 2).

“[...]Sim, eu já sabia né, não tive treinamento porque eu já estava lidando com ela né, dessa forma, não é a primeira do ano, ano passado também eu tive, da amputação também já tive, então para mim estava tranquilo[...]” (Cuidador 3).

“[...] É assim das outras vezes eu tive né, mas daí agora não, porque a gente já sabia, já conhecia, mas nas outras internações que ele internou sim, no começo sim eu tive todo o treinamento lá, fisioterapeuta, quando foi colocada a traqueo mesmo, o fisioterapeuta me ensinou tudo, os enfermeiros me ensinaram tudo, então tive todo o acompanhamento naquela época e eles me ensinaram tudo e agora eles já sabem que eu sei [...]” (Cuidador 11).

Houve três participantes que relataram não terem recebido nenhum tipo de treinamento para os cuidados, porém é possível identificar nas falas que todos apresentavam familiares profissionais da área da saúde, podendo isto estar relacionado com o fato de não terem recebido o treinamento.

“[...] Não, não teve nenhum treinamento, não teve nenhuma explicação [...] Pra vocês terem uma noção, eu procuro até hoje dentro da pasta [...] que eu deveria passar, não porque eu não soubesse, porque graças a Deus eu sabia, mas eu procurei lá o que faria o curativo, né? Na ferida. Como fazer o curativo dele. Porque o curativo dele, como gerou uma infecção, tinha aquela parte das gazes, vai rodando, todo um procedimento que a gente sabe fazer. Só que daí nenhum outro familiar sabia fazer e também não teve nenhuma explicação para nenhum outro familiar fazer[...]” (Cuidador 5).

Nesta fala a cuidadora aponta como possível causa de os familiares não terem recebido nenhuma orientação, porque eles tinham a segurança de ter um profissional de saúde na família.

“[...] Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como 100% culpa do hospital. Você entende? Eu vejo isso também como a predisposição de um familiar para ficar ali e perguntar. Por que o que acontece? Como eles sabiam que tinha uma pessoa que sabia fazer, a família em si, sabia que tinha uma pessoa que sabia fazer, então, não, a minha cunhada (é enfermeira), pode deixar que ela vai fazer. Às vezes, até o pessoal pode ter tentado. Mas durante todo o tempo que eu visitei [...], na última alta dele, ninguém veio falar. Ninguém, ninguém [...]” (Cuidador 5).

“[...] Não, não houve treinamento para preparo [...] na outra internação ela teve também, ela veio para casa [...] nós tínhamos uma neta dela que é enfermeira e que veio cuidar, ajudou a cuidar [...]” (Cuidador 7).

“[...] Não. Nenhum tipo de treinamento [...] faltou um apoio, pode ser um treinamento. Como que eu posso te explicar? O meu irmão na verdade saiu do hospital, não era para ele ter saído daquela forma, entendeu? Ele precisava muito da ajuda médica, da enfermagem, porque ele saiu de lá gritando, de dor, entendeu? Então a gente resolveu só trazer ele para casa mesmo, porque minha mãe é técnica de enfermagem, meu pai também tem conhecimento na área da saúde, por isso que nós trouxemos ele. Porque se não fosse assim não teria como nós ter trazido ele da forma que ele está [...]” (Cuidador 10).

Subcategoria: Habilidade para desempenhar os cuidados fortalecida pela educação em saúde e cuidador experiente. Os participantes relataram que conseguiram desempenhar os cuidados domiciliares e que foi importante as orientações recebidas pela equipe de saúde.

“[...] Quanto a isso, pra mim foi tranquilo, assim foi bem tranquilo essa parte pra mim [...]” (Cuidador 1).

“[...] Sim, para mim é tranquilo [...]” (Cuidador 3).

“[...] Eu acho que foi, eu consegui fazer né do jeito que eles falaram e eu acho que foi muito certo assim o jeito de eles falarem que a gente, eu consegui [...]” (Cuidador 8).

“[...] Com certeza, porque pra gente é uma coisa nova, né, a gente não sabia nada. É muito importante [...]” (Cuidador 11)

Os participantes destacaram o fato de já possuírem experiências anteriores ou apresentarem um profissional de saúde na rede de apoio familiar, como fatores que contribuíram para o seu desempenho nos cuidados domiciliares.

“[...] Eu sabia já [...]” (Cuidador 2).

“[...] Tranquilo. A minha esposa é já está prática nisso daí ela faz. E tenho uma filha também, que é técnica em enfermagem, às vezes ela ajuda aqui[...]” (Cuidador 4).

“[...] Eu já tinha cuidado do meu pai e da minha mãe também com o AVC. Daí a minha filha tinha muito medo de dar as coisas pra ele. Eu já não tinha, porque com a minha mãe, ainda era que no tempo da minha mãe fosse que nem agora, né? Tempo da minha mãe, dez anos atrás, mas não tinha ajuda de nada, aí sim nós não tivemos informação nenhuma. E não teve uma ajuda, e minha mãe teve um AVC, veio a gente tratava dela deitada, ninguém sabia que tinha que sentar ela. Agora dele diferente, né? Ele já sabe [...] eu não acho que teve nada difícil esperando que a gente já passou com os outros, né? Porque não é fácil, ter a pessoa assim, tudo é mais difícil mesmo. Mas como eu já passei por mais dificuldades com os meus pais, então eu acho que com ele tá sempre tranquilo [...]” (Cuidador 6).

“[...] Não, foi tudo normal. Nós já temos uma experiência em função que nós já cuidamos do esposo dela, por cinco anos [...]” (Cuidador 7).

Subcategoria: Orientação insuficiente para os cuidados domiciliares. Apenas um dos participantes relatou que as informações sobre os cuidados foram insuficientes.

“[...] Na questão da ferida, né, que deu uma ferida, né, que eles falam escara, né, eu senti que um pouco eles, é assim, não me deram tanta informação, só falava assim, ó, coloca assim, assim, pronto e fecha. Aí quando eu estava aqui em casa, o médico veio que olhou, o médico e as enfermeira da SAD, né, a técnica e a enfermeira, que me deram mais instrução de como cuidar da ferida [...]” (Cuidador 12).

e) Categoria - Continuidade do cuidado

Esta categoria explora a percepção dos participantes sobre a continuidade do cuidado além do hospital, na rede de atenção domiciliar, serviços de ambulatório, acesso a medicamentos e materiais, bem como as fragilidades e potencialidades dos processos percebidas por eles. No momento da alta, os participantes relataram que receberam as orientações em formato de relatório, receitas e encaminhamentos ambulatoriais

Subcategoria: Alta com relatório médico e encaminhamento ambulatorial. Nas falas a seguir os cuidadores relataram no momento da alta médica eles receberam orientações por escrito, como receita, relatório médico e encaminhamento ambulatorial.

“[...] Sim, recebi as orientações, relatório de alta, receita e encaminhamento, ele já tem consulta com o urologista dia 16 [...]” (Cuidador 2).

“[...] Recebi todos os papéis aí de receita e isso, é não teve encaminhamento para retorno só encaminhamento para UBS para acompanhamento, mas a equipe médica do hospital vem em casa ainda né, tá tranquilo[...]” (Cuidador 3).

“[...] Sim. Tem um retorno com acho que o doutor [...] Lá no CEM agora para não lembro o dia também, mas parece que eu tenho um retorno para verificação da traqueia ou essas coisas assim [...]” (Cuidador 4).

“[...] Sim, recebi tudo, relatório médico e receita [...]” (Cuidador 6).

“[...] Sim, eu recebi por escrito, receita, orientação, tudo [...]” (Cuidador 9).

“[...] Sim, recebi os encaminhamentos e receita [...]” (Cuidador 10).

“[...] Sim, eu recebi o relatório médico [...]” (Cuidador 11).

Subcategoria: Falha no encaminhamento ambulatorial. Apesar dos participantes manifestarem que receberam os documentos por escrito na alta, houve relatos de falha no encaminhamento ambulatorial.

“[...] Eu nem consegui fazer o cadastro na nona regional ainda, ela está em casa há 3 semanas, por quê? Porque a receita tem que ser dada por um especialista [...] então eu estou aguardando uma consulta com o especialista para ele poder me dar uma receita e tem que ser um especialista do SUS, né, obviamente, para ele poder me dar uma receita para mim, poder fazer o cadastro na nona regional para daí ver se vão aprovar para daí ir lá agendar para pegar o medicamento [...]” (Cuidador 1).

“[...] Ele tinha retorno para a gente marcar o retorno com a cirurgia, o médico cirurgião da Laparotomia, da traqueia não tinha [...] A causa da internação dele não foi o abdômen, não foi o intestino. O internamento dele foi referente a traqueostomia para ele fazer a traqueia. Então, quando saiu, eu tenho aqui no WhatsApp quantas vezes eu mandei lá para eles que ele tinha saído sem o pedido de retorno da

cirurgia da traqueo. Então, quando eu estava lá dentro do hospital mesmo [...]” (Cuidador 5).

“[...] Não, o retorno não, só foi mandado para casa mesmo né [...] só a única coisa que eles pediram para mim procurar o posto de saúde [...]” (Cuidador 8).

“[...] Eu recebi assim os números do CID dele, algumas coisas escritas, mas não era um completo [...] no CID mesmo eu tive que ir lá no hospital e pedir para eles me mandarem, daí eles pegaram meu e-mail, daí vai ser, vai ser ainda, acho que tem 20 dias para eles me mandarem. [...] É, porque o médico pediu para mim, quando ele veio aqui, o médico da SAD, eu não tinha [...]” (Cuidador 12).

Subcategoria: Barreiras no acesso aos medicamentos e materiais médico-hospitalares para os cuidados domiciliares.

Nesta Subcategoria podemos conhecer as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores no momento de adquirir os materiais necessários para o cuidado domiciliar. Na fala a seguir podemos identificar que o cuidador não conseguiu os medicamentos por falta de orientações que deveriam ser realizadas sobre cadastro nos programas do governo antes da efetivação da alta hospitalar, e os materiais que deveriam ser disponibilizados pela UBS, conforme o relato, não estava disponível.

“[...] O único remédio que eu peguei de todos 7 Medicamentos, o único que eu consegui pegar foi o dipirona na farmácia do SUS, o resto nenhum deles a gente conseguiu pegar [...] não, porque daí tem que fazer cadastro em nona regional, aí tem que fazer cadastro na Paraná sem dor. Então assim, graças a Deus, que naquele momento, a gente tinha um dinheiro para comprar o remédio. Mas se é uma família que não tem, faz o quê? [...] A única coisa que é enfermeira da desospitalização falou para mim foi assim, a única compra que você vai ter que fazer, a princípio, é o aspirador de traqueostomia, tudo você vai pegar pelo SUS, então, só que não é assim, é porque se você tem que fazer cadastro na regional [...] de várias coisas eu não consegui nada, não consegui material, não consegui remédio. Aí no final, tive que ir na farmácia comprar tudo. Aí basicamente o dinheiro que a gente tinha ali a gente deixou tudo na farmácia, porque foi uns 500 reais assim na farmácia que ficou lá. Então eles teriam que já ter preparado tudo isso, ter falado para mim, olha, vai lá na nona regional, já se cadastra lá, porque você vai precisar desses medicamentos para ela, né? Vai lá no Paraná sem dor, vai no postinho, faz o pedido do material, porque até hoje os materiais que ela saiu do pedido não chegou no postinho, gases, é sonda, não chegou, luva eu compro. Às vezes eu vou lá no postinho, as meninas me arrumam uns que tem lá e me dá [...]” (Cuidador 1).

Na fala seguinte também é relatado a indisponibilidade de materiais pela UBS.

“[...] Não, está bem complicado, está em falta também, hoje que eu consegui alguns frascos no postinho [...] está em falta na UBS e não consegui tudo ainda. Uso luva muito, fralda eu não consegui, é gaze, chumaço, soro pra limpeza, eu estou tendo que comprar a luva para suprir o que eu estou usando ali, faltou o equipo né que é aquela mangueirinha que vai nos frasquinhos e está em falta ainda [...]”
(Cuidador 3).

“[...] agora, quando ele deu as coisas, não tinha nada no posto. Aí a gente comprou. Aí agora, essa semana, que vai fazer um mês já que está em casa, é que a minha filha conseguiu as pomadas e tudo [...]”
(Cuidador 6).

“[...] Na época foi difícil, foi muita luta, eu ia no posto, eu voltava, foi muita luta para mim conseguir, mas daí depois que eu consegui, daí foi uma maravilha. [...] Esse eu já tenho tudo em casa, porque eles já fazem o acompanhamento com o Melhor em casa, então daí não precisou ter. Da primeira vez, sim tive para me trazer para mim começar ali [...]”
(Cuidador 11).

Na maioria das falas os cuidadores relatam que tiveram que comprar os materiais, alguns conseguiram posteriormente ter acesso e outros até o momento da entrevista ainda não haviam tido acesso.

Subcategoria: Percepção do cuidador sobre a visita domiciliar. Nas falas a seguir, os cuidadores descrevem como ocorreu a visita da equipe do SAD, percebe-se que os profissionais presentes são o médico, a enfermagem e a nutricionista, e eles destacam a falta dos profissionais da Fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.

“[...] Sim, eles vêm toda semana, para mim foi tudo bem, assim, tudo tranquilo. O médico vem, ele tira bem as dúvidas, é que não tem muito que ser feito, né? Uma paciente paliativa, que não tem estímulo nenhum, não responde nada. Então, quando preciso de receita ele me dá, aí vem fisio também vem a nutri. [...] Até hoje não veio a fono, só veio uma fisio, veio um dia, veio a fisio, e veio a nutri um dia. O médico vem toda semana, vem médico, e aí equipe de enfermagem [...]”
(Cuidador 1).

“[...] É normal, eles chegam olham analisam vê as feridas dele e fala ó vamos trocar de pomada vamos fazer assim, vamos fazer assado, e por fim pergunta se eu preciso de receita de algum medicamento diferente e tal, é me falou que ia pedir fisioterapeuta para vir em casa, não veio nada até agora, fisioterapeuta, só veio a nutricionista tal, não veio

também o psicólogo e não veio a fono que cuida das sondas, agora veio a nutricionista que é que me deu alguns frasquinhos que ela tinha no carro, ela tinha uns frasquinhos no carro daí ela até me cedeu alguma coisinha que ela tinha para me ajudar que eu falei que estava em falta né, então é as únicas duas que vêm, é a equipe médica e a nutri, é aí faltou psicólogo faltou a fono, faltou a fisioterapeuta, até eu estou aguardando para ver se eu consigo com fisioterapeuta ver se eu consigo movimentar ele de alguma forma diferente, talvez tentar sentar ele, porque ele também perdeu muito equilíbrio por causa do alzheimer né que afetou muito, mas até agora nada, já tem mais de trinta dias que ele sofreu a amputação quando começou o tratamento em casa né [...]" (Cuidador 3).

"[...] Era pra ter fono, era pra ter fisio, era pra ter psicólogo, era pra ter tudo. Mas ele vem uma vez e diz que vai retornar, mas não tá tendo. A equipe do SAD não está conseguindo dar o atendimento para todos os pacientes. Falta profissional, na verdade [...] A gente questiona, mas falta o profissional. A gente sabe que está faltando mesmo. É muito paciente para pouco profissional. Então a gente sabe que está faltando. Fisioterapeuta mesmo, na verdade, ele tinha que ter fisioterapia todo dia. O SAD conseguiria dar uma vez por semana, e não tá conseguindo[...] na semana passada mesmo não conseguiu vir, então na outra semana, antes dele internar, ela conseguiu vir duas vezes por semana, falou que ia tentar manter duas vezes na semana, porque ele precisa, né? E daí ela já não conseguiu vir essa semana [...]" (Cuidador 11).

"[...] Ainda não tem visita do fisioterapeuta, nem do fonoaudiólogo, nem da do nutricionista, eles não vieram ainda[...] não me deram nenhuma data, só falaram que tem bastante pessoas para atender e nesse período eu tenho que aguardar [...]" (Cuidador 12).

Na fala a seguir, o cuidador relata que o usuário já era acompanhado pelo SAD anterior a última internação, e que após a alta mais recente ainda não recebeu a visita da equipe.

"[...] Isso, ele tem, eu não sei por que que eles não vieram ainda, mas não vieram ainda. E vai já faz uns 15 dias que ele está em casa ou mais né? E não vieram ainda. Ele recebia. Eu não sei que pé está agora, mas parece que essa semana agora eu acho que terça ou quarta eles vão vir aqui para dar uma observada nele, para ver como é que está, aí o médico vem, faz aqueles exames, receita os remédios de uso contínuo, faz a receita, sim [...]" (Cuidador 4).

Nas falas seguintes os cuidadores relatam como ocorreu a visita domiciliar, destacando a importância desses profissionais e da visita domiciliar.

“[...] Sim, um médico em casa é diferente, né? Ele chega e a gente pergunta alguma coisa, ele já deixa por escrito pra gente[...] muito atencioso. É importante a visita deles. Quando ele chega, eles tiram o sangue, eles medem diabetes, eles veem se tem febre, eles veem aquele oxigênio do sangue, e daí eles veem a ferida, eles tiram tudo e olha. Eles pegam, daí que ele tá com infecção na urina, né? Todo sábado eles tiram, coleta a urina, leva. E agora tirando sangue também, hoje eu já fiz um exame de sangue. Então, estamos sendo bem assistidos por eles, não tem que reclamar, não [...]” (Cuidador 6).

“[...] Eles vieram, analisaram a situação dela, olharam a medicação, deram algumas sugestões e cuidados [...]” (Cuidador 7).

“[...] Aí veio, acho que é o médico da SAD também, passou remédio, falou que ele precisava e passou espessante também, que ele se engasgava. Eles são muito bons, achei muito bom a visita Domiciliar. Eu acho que essa visita é muito importante porque às vezes a pessoa sai do hospital sem ter assim, às vezes eles mandam ir no médico da família no postinho, mas eles nunca vêm, e esses aí eles vêm, né? Eles vieram três, quatro dias aí fazer medicamento mesmo. Eu achei muito bom a visita deles [...]” (Cuidador 9).

“[...] É semanal, o médico vem uma vez por semana em casa, vem o médico, técnico de enfermagem, enfermeira, vem uma vez por semana fazer a visita [...] Ele vem e faz, é tipo uma consulta médica, ele vem e faz toda a avaliação do paciente, se precisa de receita, ele já prescreve, renovar a receita, tudo. Ele faz toda a avaliação. É como se o paciente fosse lá na clínica consultar e pra ver toda visita [...]” (Cuidador 11).

“[...] Então, eles me mandaram mensagem, ainda quando meu pai estava no hospital, daí falou se poderia vir fazer a visita, né? Daí eu falei que no momento ainda não tinha recebido alta, daí eles falaram que quando meu pai recebesse era para me mandar uma mensagem, daí eu mandei, daí eles vieram em casa. E o médico é bem atencioso [...] ele está me ajudando bastante, tudo que eu preciso, ele faz a receita, a questão do meu pai, ele olha bem, explica as coisas muito bem, dele eu não tenho que falar nada, nem das enfermeiras [...] uma semana e já tá quase assim pra duas semanas [...], mas nesses dias eu já recebi três visitas deles já. Um dia depois que ele saiu do hospital eles vieram, vieram no sábado e vieram hoje de novo [...]” (Cuidador 12).

Subcategoria: Falta de encaminhamento médico para o SAD.

A falta do encaminhamento médico para o SAD impactou na continuidade dos cuidados, pois como é demonstrado nas falas a UBS estava com falta de profissionais e não conseguiu realizar o atendimento domiciliar.

“[...] Não eles não vêm. Tanto é que eu estou com um problema muito sério. Ele já foi no posto, já conversei com a médica do setor, e não está tendo enfermeira chefe para fazer a troca da sonda da cistostomia. Não tem enfermagem, no posto de saúde no 2 e nem no 3, não tem[...] não foi pedido, está aí, os papéis aqui, eu estou Desesperada menina para ver o que eu vou fazer? Não foi encaminhado, viu? Foi pra o posto de saúde e o posto de saúde não tem condições [...] é isso que eu estou preocupada porque dia 7, antes do dia 7, eu tenho que fazer a troca da cistostomia, entendeu? E não tem enfermagem. Na UPA Eu levei ele pra fazer a troca o mês passado eles falaram que não, não faz parte do setor deles de fazer troca de sonda, de cistostomia, porque ali entre emergência, então tem que ser no posto. E eu já fui quando cheguei, o mesmo dia que eu cheguei. Eu fui lá no postinho na UBS do Morumbi 2. Conversei com a doutora, ela falou que não tem como fazer a é visita domiciliar porque é ela está cheia de pacientes, e o que que eu vou fazer? [...]” (Cuidador 2).

“[...] Só que o posto de saúde até agora não, né? Porque, tipo assim, eu não consegui ainda. No dia que ela saiu de alta, o médico está de férias. E a enfermeira também do posto está de férias. Daí, eles passaram para mim que tem que esperar a enfermeira chegar para eles agendarem as consultas domiciliares. A única que veio ver ela foi a nutricionista do posto. A nutricionista veio três vezes ver ela. Mas a única que eu consegui, né. O médico mesmo eu não consegui ainda [...]” (Cuidador 8).

“[...] Ele Não foi encaminhado para o SAD [...]” (Cuidador 10).

Um dos cuidadores relatou que conseguiu ser encaminhado para o SAD pela UBS.

“[...] Lá no posto de saúde eu pedi o SAD, quem fez o pedido foi a gente que fomos lá no posto de saúde. E o pessoal do SAD, eles fizeram três visitas, foram três quintas-feiras, aí ele começou a comer pastoso a gente começou a fazer, ele até hoje não se adaptou com a traqueia é extremamente difícil porque o caso dele é uma estenose [...]” (Cuidador 5)

Subcategoria: Dificuldades no cuidado. Nas falas a seguir os cuidadores detalham a complexidade do cuidado como por exemplo a realização do banho, alimentação, medicação, cuidados com “escaras” e assaduras, sendo possível observar nas falas a seguir.

“[...] Daí, no fim, eu vim para casa, eu estava preocupada daí, porque daí eu tinha que fazer alimentação dela, eu tinha que ir atrás de remédio, eu tinha que ir atrás de oxímetro, eu tinha que fazer tudo naquele momento ali [...]” (Cuidador 1).

“[...] Os cuidados são bem difíceis, porque eu tenho cuidado dele sozinho, né? Tem que trocar, tem que dar banho, tem que é alimentação, tudo, né, tudo controlado, né? Remédio, tem que dar remédios 2 vezes ao dia, então é bem difícil para mim. Está sendo meio cansativo, sabe? E eu vivo mais dentro do hospital do que em casa. Bastante dispositivo para ele, e não pode tirar nada, que nem agora ele não está fazendo xixi pela cisto, bem pouquinho, é 100ml, 200 ml, só e mais o restante pelo pipi, pela uretra, então ele faz pela cistostomia, pelos 2 é bem difícil para mim [...]” (Cuidador 2).

“[...] Ele saiu do hospital com uma escara nas costas e uma ferida nas costas né, é acho que foi, não lembro se foi da primeira internação ou foi dessa que ele veio com a escara, acho foi dessa última internação que ele veio com a escara, e aí vai cuidando de tudo porém como é muito deitado ele está com um pouquinho de assadura agora estou tentando tratar ele ali com pomadas que a equipe médica me passou ali, mas em função do estar ali acamado né não tem como, as fezes e tudo, estou conseguindo tirar a urina pelo uripen mas as fezes não tem como né e a hora que ele faz ele demora mais ou menos uma hora, do começo ao fim, então esse período fica judiando a pele ali né, então a assadura é uma questão bem complicada ali [...]” (Cuidador 3).

“[...] Daí ele teve assim, tá com dificuldade agora pra dar o remédio, por causa dele não engolir o comprimido, né? Tem que macerar todos os comprimidos que é dado. E lá eles davam na veia, né, [...] ou na sonda. Só que não era na veia, era na sonda. E aqui para mim eu tenho que macerar todos. Então de manhã até meio-dia eu estou ali na luta de um remédio ou outro [...]” (Cuidador 6).

“[...] É, e aí você não sabe o que fazia em qualquer situação. Com a sonda gástrica mesmo que ela veio, foi difícil, porque ela tentava tirar. Então a gente teve que fazer plantão [...]” (Cuidador 7);

Os cuidadores relatam uma adaptação das atividades na rotina da família e o desempenho dos cuidados:

“Agora eu já peguei o jeito já, né? Isso vai se adaptando [...]” (Cuidador 8);

“[...] nos primeiros dias eu tive dificuldade, mas é porque a gente estava se adaptando ainda aqui em casa, né? Como que a gente vai fazer as coisas tudo, então eu tive um pouco de dificuldade [...]” (Cuidador 12).

“[...] É difícil, né? Foi bem difícil, porque assim, como ela era uma pessoa bem ativa, que andava, fazia as coisas dela, tomava banho sozinho, e depender da gente, é difícil, né? Que nem eu tenho problema no braço também, né? Então, assim, é difícil a gente lidar com ela. Ela é pesada [...], mas, graças a Deus Tem sempre alguém em casa [...],

mas no começo eu achei difícil. Agora eu já peguei o jeito já, né? Isso vai se adaptando [...] então, mais dificuldade que eu tenho assim um pouquinho é na hora de levar ela para ir no banheiro, para fazer as necessidades dela [...] eu levo, eu coloco ela na cadeira, as vezes eu coloco ela na cadeira um pouquinho para tirar ela um pouquinho da cama para não dar ferida [...]” (Cuidador 8).

“[...] Nos primeiros dias eu tive dificuldade, mas é porque a gente estava se adaptando ainda aqui em casa, né? Como que a gente vai fazer as coisas tudo, então eu tive um pouco de dificuldade, mas agora já tá mais fácil, né? Mas o primeiro dia tava mais difícil [...] na hora de fazer a troca do cordão da traqueia, eu tive um pouco de dificuldade, porque lá no hospital eles que faziam mais, eu não tinha ainda feito. Quando eu fui fazer em casa, eu tive mais dificuldade até pegar o jeito, pra cuidar da ferida, essas coisas assim, tipo, na questão de fazer a dieta, eu também tive um pouco de dificuldade, até a gente pegar o jeito, né? Nessa questão da dieta, a gente acabou pegando informação da parte do meu pai, da família, que já tem a minha avó, que a mãe dele, acamada. Então a gente acabou pegando informação com ele [...]” (Cuidador 12).

“[...] Eu cuidei dele o máximo que eu pude, 5:30 da manhã para ir aspirar ele às 7 horas, deixar meu filho na escola, aspirar ele, vim trabalhar, depois ia uma pessoa meio-dia, depois eu saía daqui do hotel, ia lá, aspirava ele de novo, fazia o curativo dele de novo para mim buscar meu filho para mim voltar para casa. E às vezes eu chegava em casa, fazia comida e voltava lá de novo, deixava o almoço e a janta, para essa rotina todos os dias [...] a gente se reveza para poder ajudar ele, então, se eu tenho que ir lá às vezes, daí assim, a medicação dele eu cuido todas elas. Então eu coloco lá o horário que ele vai tomar [...] eu que organizo toda a parte de medicação dele então assim se por acaso eu preciso o final do mês por exemplo eu sei quando vai acabar as medicações[...] Então toda a medicação dele, eu vou lá, todo final de mês eu já vejo certinho que tem, porque tem alguns medicamentos que são duas caixas por mês, eu já vou lá, antes, tipo sete dias antes de acabar, eu vou, vejo tudo que tá faltando, providencio novamente e abasteco, é a parte da sonda dos que ele precisa para fazer a aspiração eu já vou lá pego a bolsa dele que o posto de saúde monta vou lá e coloco tudo certinho daí eu vejo quando tá acabando eu já vou lá no posto [...]” (Cuidador 5).

Outra questão que vai além da adaptação familiar, em casos de pacientes com cuidados mais complexos, como o relato do cuidador a seguir, onde o cuidador não consegue desempenhar os cuidados domiciliares sozinho, pois devido à complexidade do cuidado é necessário o apoio de mais de uma pessoa, e neste caso por ter uma rede de apoio familiar reduzida, a única opção do cuidador foi iniciar com um processo de judicialização.

“[...] O que a gente precisa também no cuidado dele é um técnico para acompanhar pessoas que precisam 24 horas. Eu não preciso 24 horas, eu preciso 12 horas. Tanto que eu estou com um processo na justiça para conseguir. Já saiu a liminar do home care. Já era para a prefeitura estar cumprindo, a prefeitura não está cumprindo ainda, e até o advogado está revendo para ver o que faz para cumprir, porque já tem a decisão para estar sendo cumprido isso, porque precisa de alguém para me ajudar a cuidar. Hoje a minha cunhada está aqui, mas ela mora lá no Rio Grande do Sul. Então ela não consegue vir aqui direto [...] preciso de apoio porque ele é grande, é pesado. Vai virar de um lado, vai virar para o outro, vai trocar ela daí teria que ter a fisioterapia principalmente, fisioterapia, fono [...]” (Cuidador 11).

O capítulo abaixo da presente dissertação trata da discussão, realizada a partir das falas dos participantes do estudo.

8. DISCUSSÃO

No perfil sociodemográfico dos participantes desta pesquisa, algumas características destacaram-se, sendo elas: o grau de instrução, onde a maioria (33,33%) apresentava o ensino médio completo, em relação à moradia a maioria (91,67%) relatou possuir casa própria, (50%) dos participantes relataram estar desempregados, (66,6%) relataram ter filhos dependentes e (58,33%) relataram uma renda familiar de 1 a 2 salários-mínimos, também foi evidenciado que os cuidadores do sexo feminino correspondem a (75%) dos participantes.

Bertagnoli et al. (2021) realizaram uma investigação sobre a experiência de cuidadores e profissionais na parceria assistencial dedicada a usuários do serviço, e apontam a questão de gênero, devido a característica encontrada durante as entrevistas de seu estudo, na qual nove dos dez cuidadores entrevistados eram mulheres, entre pessoas contratadas e familiares que assumiram a função de cuidador.

Oliveira, Hora e Chaves (2023) destacam em sua pesquisa a prevalência de familiar do sexo feminino como cuidadora principal em casos de enfermidade, e apontam que isso ocorre devido a mulher ser interpretada socioculturalmente como precursora do cuidado, e por relações desiguais de sexo, admitindo a divisão sexual do trabalho atribuindo às mulheres o trabalho não remunerado. Minayo (2021) critica a atuação do Estado frente aos serviços básicos da atenção em relação aos cuidadores informais, ela aponta a sobrecarga da mulher ou empregada doméstica que agrega a função de cuidadora junto a todas as outras funções desempenhadas no cuidado da família.

A análise dos dados desta pesquisa demonstrou que o repasse das informações sobre o tratamento e planejamento de alta pelos profissionais médicos ocorreram de maneira empática e acolhedora. Porém verificou-se em algumas falas que a abordagem foi limitada e pouco segura, quando realizada por estudantes.

Souza *et al.* (2025) realizou uma pesquisa qualitativa onde entrevistou 13 estudantes de residência médica, seu estudo destacou que a rotina exaustiva e a alta rotatividade desses profissionais da residência afetam o processo de aprendizagem contínuo, o que pode impossibilitar o aprofundamento do conhecimento e a supervisão/tutoria acaba não sendo realizada de forma adequada, assim como o cuidado em saúde.

O ambiente hospitalar pode ser caracterizado como um espaço que não favorece a comunicação efetiva entre os profissionais, sendo assim, é imprescindível que o profissional de

saúde desenvolva a habilidade para a comunicação entre a equipe multiprofissional, como também para com os usuários em relação ao seu processo de cuidado (Souza *et al*, 2025).

Em alguns casos, foi evidenciado a ausência e a descontinuidade do planejamento no preparo da alta. Klein *et al.* (2021) e Oliveira, Hora e Chaves (2023), em seus estudos, ambos também apontaram a falha no planejamento para as altas hospitalares como uma das barreiras para efetivação da desospitalização, envolver o cuidador no processo da desospitalização desde o início da internação, gera confiança para ele desenvolver os cuidados no domicílio, proporcionando maior segurança no momento da alta hospitalar.

Valente *et al.* (2024) evidenciou em seu estudo a fragilidades na organização da equipe quanto à preparação de alta de usuários idosos e de suas famílias. Tais fragilidades foram identificadas pela ausência de um plano terapêutico registrado no prontuário eletrônico, bem como pela falta de um protocolo que norteie a prática assistencial.

O planejamento da alta, não é apenas a construção de ações interprofissionais, esse processo precisa envolver ações de humanização e acolhimento, tendo como objetivo a educação e o cuidado em saúde, ao mesmo tempo em que é capaz de criar um elo do hospital para o domicílio (Souza *et al.*, 2023).

Valente *et al.* (2022) em seu estudo, o planejamento de alta foi o tema mais discutido e considerado recurso importante para a transição de cuidados seguros, e os participantes apontam falhas na execução do plano de cuidados, evidenciada por dificuldades na comunicação entre a equipe assistencial e com a família, a ausência de programação de alta e lacunas na preparação do idoso para os cuidados domiciliares.

Durante esta pesquisa não foi possível identificar a participação do cuidador no planejamento da alta. Tomazela *et al.* (2023) destaca a importância de proporcionar o envolvimento dos cuidadores no planejamento dos cuidados, possibilitando que eles participem nas decisões relacionadas ao desenvolvimento e execução do plano de cuidados, no Brasil é comum que não se inclua os usuários nas tomadas de decisão nos processos de trabalho nas organizações de saúde.

Em seu estudo Souza *et al.* (2023) demonstrou que a participação do usuário e seus familiares na elaboração do planejamento de alta possibilitou a produção do cuidado compartilhado e a colaboração na sua autonomia, estabelecendo uma corresponsabilização no cuidado em saúde do usuário; evidenciando que desospitalização deve ser realizada com segurança e responsabilidade, sendo imprescindível a participação efetiva do paciente e de sua

família no processo, pois impacta diretamente no tempo médio de permanência e diminui as reinternações desnecessárias.

Quando foi questionado sobre como foi a comunicação da equipe de saúde com os cuidadores, as falas refletem que os cuidadores relacionam o bom atendimento com a comunicação. Porém em alguns relatos evidenciou-se uma comunicação fragilizada e desarticulada entre a equipe e entre a equipe e o cuidador durante a internação, o que também se constitui em barreiras para a desospitalização.

É preciso que os profissionais envolvidos na transição do cuidado intra-hospitalar para o domicílio, se apropriem de ferramentas que fortaleçam a comunicação, investindo na educação em saúde para as orientações com o familiar, é de suma importância que todas as informações pertinentes sobre a patologia, procedimentos, exames e terapias sejam claramente transmitidas (Klein *et al.*, 2021).

Na categoria Autonomia e segurança terapêutica a maioria dos cuidadores relatam compreensão das orientações da terapia medicamentosa, porém também foi observado a presença de lacuna na orientação sobre uso do medicamento.

O enfermeiro, durante o planejamento da alta, tem papel fundamental para minimizar os riscos de Eventos Adversos a Medicamentos, realizando orientações ao usuário e cuidadores, utilizando uma linguagem leiga a fim de que melhorar a compreensão e diminuir o risco de reinternação hospitalar (Tomazela *et al.*, 2023).

O Enfermeiro tem um papel fundamental em conjunto com a equipe de saúde para desenvolver ações educativas junto à família e à comunidade, o desenvolvimento dessas atividades, constroem possibilidades para os usuários, fazendo com que a educação em saúde promova a cidadania. Para alcançar este objetivo os profissionais necessitam conhecerem as melhores estratégias de abordagem educativa, bem como valorizar o conhecimento prévio do usuário fortalecendo seus saberes e promover a sua autonomia (Souza *et al.*, 2023).

No presente estudo, observou-se que o preparo para os cuidados domiciliares ocorreu, porém de maneira fragmentada. Alguns cuidadores relataram ter recebido orientações, enquanto outros afirmaram não ter recebido nenhum tipo de informação. Entre aqueles que não receberam treinamento, foi possível identificar, em seus relatos, a presença de um familiar com formação na área da saúde. Isso sugere que esse familiar estaria auxiliando nos cuidados após a alta, o que pode ter contribuído para que a equipe de saúde deixasse de realizar as orientações formais, presumindo que o cuidador já possuía o conhecimento necessário.

Outro ponto destacado por alguns participantes foi a habilidade para desempenhar os cuidados domiciliares relacionada a experiência prévia com internações anteriores, o que levou à ausência de novas orientações durante a internação atual. Ainda assim, relataram ter conseguido realizar os cuidados adequadamente devido ao aprendizado adquirido anteriormente.

Apenas um participante mencionou que as informações recebidas sobre a realização de curativos foram insuficientes. Contudo, relatou ter recebido posteriormente, em seu domicílio, a orientação adequada fornecida pela equipe do SAD.

Valente *et al.* (2024) em sua pesquisa evidenciou que a maioria das pessoas idosas entrevistadas apresentaram dificuldades de compreensão sobre os cuidados domiciliares, tanto de maior, como de menor complexidade, apontando para falhas na educação em saúde e déficit de comunicação entre profissionais de saúde, pacientes e suas famílias

Para que a desospitalização ocorra de forma segura, é imprescindível que os profissionais realizem o treinamento dos cuidados domiciliares aos usuários e cuidadores, a fim de garantir a integralidade e continuidade do cuidado. Estabelecer um vínculo de suporte entre o hospital e a família pode ser uma estratégia eficaz, pois promove confiança e conforto para todos os envolvidos (Silva; Queiroz; Maia, 2021).

A não realização do treinamento para o cuidador pela equipe de saúde também pode estar relacionado a ausência do planejamento da alta. Quando ocorre falhas no planejamento da alta, isso dificulta o processo da desospitalização, pois a equipe de saúde não consegue realizar as orientações por completo por não haver tempo hábil, impossibilitando a construção de um vínculo entre a família e uma rede de apoio, gerando assim insegurança para os familiares, as altas hospitalares ocorrem precocemente devido à grande demanda dos serviços hospitalares e a necessidade de rotatividade dos leitos (Klein *et al.*, 2021).

No momento da alta, os participantes relataram que receberam as orientações por escrito em formato de relatório, receitas e encaminhamentos ambulatorial, porém houve relatos de falha no encaminhamento ambulatorial, evidenciado por relatório médico incompleto e falta de encaminhamento para especialidades que eram de extrema necessidade para a continuidade do cuidado.

Após a alta hospitalar é crucial a continuidade do cuidado ao usuário, a fim evitar que ele fique sem orientação ou acompanhamento na rede de serviços, pois as fragilidades dos mecanismos de contrarreferência geram desamparo e insegurança para pacientes e familiares, o que frequentemente resulta na procura por serviços inadequados, como as Unidades de Pronto

Atendimento (UPA), destinadas exclusivamente a situações de urgência e emergência (Freire; Correia; Oliveira, 2025).

As Barreiras no acesso aos medicamentos e materiais médico-hospitalares para os cuidados domiciliares; também se constituem em empecilhos para a continuidade do cuidado

Nas falas dos cuidadores foi possível identificar que o cuidador não conseguiu ter acesso aos medicamentos por falta de orientações que deveriam ser realizadas sobre cadastro nos programas do governo antes da efetivação da alta hospitalar, e os materiais que deveriam ser disponibilizados pela UBS, conforme o relatado por eles, não estavam disponíveis.

Em um estudo realizado em Genebra na Suíça por Dost *et al.* (2024) foi demonstrado que a falta de informação individualizada e a perda da autonomia na internação hospitalar, ocasionam no momento da alta empecilhos para adquirir os medicamentos e dificuldades para a compreensão das modificações e reconciliações medicamentosas.

No processo de alta deve ser implementado a padronização da prescrição e a dispensação de medicamentos, para a preparação da alta, devendo a alta ser minuciosamente planejada, podendo obter auxílio com farmácias comunitárias a fim de garantir que os medicamentos estejam disponíveis, e se necessário, doses do medicamento devem ser disponibilizado pelo hospital para que o paciente não tenha seu tratamento interrompido (Dost *et al.*, 2024).

No entanto, na maioria das falas os cuidadores relatam que tiveram que comprar os materiais e medicamentos, alguns conseguiram ter acesso posteriormente e outros até o momento da entrevista ainda não haviam conseguido obter. Minayo (2021) em seu estudo aponta a falta da participação do Estado com ações específicas, além das práticas rotineiras dos serviços sociais e de saúde, de medicamentos, insumos e outras despesas deixadas às famílias.

Quando foi questionado acerca da visita domiciliar realizada pela equipe do SAD, os cuidadores descreveram como ocorriam as visitas, destacando as ações e procedimentos do médico e da equipe de enfermagem, sendo possível identificar que eles enxergam a visita domiciliar como algo positivo.

Os cuidadores enfatizam a presença do médico e da equipe como algo diferenciador: “*um médico em casa é diferente*”, “*é como se o paciente fosse na clínica*”, isso revela que o atendimento domiciliar oferece algo que o cuidado ambulatorial tradicional não consegue suprir: continuidade, tempo, atenção e personalização. O elogio à atenção do médico “*muito atencioso*” e “*explica as coisas muito bem*” indica que o vínculo estabelecido durante a visita se torna parte significativa da experiência de cuidado.

A satisfação com o cuidado oferecido no domicílio revela uma dimensão das necessidades humanas relacionadas à realização do indivíduo, que envolve afeto, abrigo, carinho e proteção. Nesse contexto, pode-se afirmar que o SAD contribui para atender às necessidades naturais do usuário, que vão além da recuperação da saúde, alcançando aspectos ligados ao ser enquanto sujeito. Assim, compreende-se que o trabalho realizado pelo SAD integra a complexidade do trabalho humano na busca pela satisfação dessas necessidades (Silva *et al.*, 2017).

É possível identificar também expectativas, necessidades, além de lacunas estruturais do sistema de saúde que fazem com que esse serviço seja percebido como essencial. Alguns relatos trazem uma crítica implícita ao sistema de saúde: *“às vezes mandam ir no médico da família no postinho, mas eles nunca vêm, e esses aí eles vêm, né? Eles vieram três, quatro dias aí fazer medicamento”*.

Aqui se evidencia que o SAD, embora complementar, acaba assumindo papel de substituição da atenção básica onde esta falha. A experiência positiva com o SAD deixa evidente a ausência de acompanhamento adequado em outros níveis, o que pode gerar dependência do programa e sobrecarga da equipe.

Isso pode estar relacionado com a falta da visita de profissionais da equipe EMAD (fonoaudiólogo, psicólogos e fisioterapeutas) que foram relatados pela maioria dos cuidadores, eles mencionam que receberam a visita apenas do médico, enfermagem e nutricionista, e que foi relatado a eles pelos próprios profissionais do SAD que não havia previsão para a visita dos outros profissionais devido à alta demanda de atendimentos.

Outro fato mencionado pelos cuidadores foi a falta de encaminhamento para o SAD, sendo o usuário encaminhado para a UBS, porém evidenciou-se a falta de profissionais nas UBS, o que inviabiliza visitas, procedimentos e acompanhamento domiciliar.

O cuidador relata impossibilidade de realizar um procedimento básico (troca de sonda de cistostomia) porque “não tem enfermagem no posto”. A UPA não realiza o procedimento por não ser sua atribuição, o que reforça que sem UBS e sem SAD, não há alternativa para o usuário, mas o sistema não oferece resposta, gerando riscos ao usuário e sofrimento no cuidador que pode experimentar sentimentos de angústia, sensação de abandono e responsabilização do cuidador, que precisa buscar soluções sozinho.

Bernardi *et al.* (2022) realizou uma pesquisa com 10 cuidadores na região sul do país, seu estudo evidenciou dificuldades no cotidiano de cuidados com a pessoa dependente e a (Des)Continuidade do cuidado após a alta hospitalar. Observou-se que as participantes se

sentiram desassistidas pelos profissionais da APS após o regresso para casa, justamente em um período de complexidade e vulnerabilidade tanto para o cuidador quanto para o usuário.

Na categoria Dificuldades no cuidado, os cuidadores detalham a complexidade do cuidado como por exemplo a realização do banho, alimentação, medicação, cuidados com “escaras” e assaduras. Eles também relataram a necessidade de uma adaptação das atividades na rotina da família e o desempenho dos cuidados.

Sugiura *et al.* (2018) em seu estudo, explicam que o familiar cuidador durante a vivência do contexto domiciliar, enfrentam uma transição para este novo papel, acrescentando essa nova responsabilidade aos afazeres diários com a casa, além daqueles consigo mesmo, tornando as transformações inevitáveis na vida pessoal do familiar cuidador, causando impacto no seu autocuidado, lazer e vida profissional.

Bernardi *et al.* (2022) em seu estudo demonstraram que as vivências de cuidadores de pessoas dependentes após a alta hospitalar são consideradas complexas, pois a conciliação das tarefas domésticas com os cuidados de saúde do familiar pode resultar em medo e apreensão, devido ao acúmulo de responsabilidades, que pode desencadear a sobrecarga dos cuidadores, principalmente sobre a carga física e financeira, que é proporcional ao nível de dependência da pessoa assistida.

Outra questão que vai além da adaptação familiar, e que foi relatado por um dos participantes desta pesquisa, que era cuidador de um dos usuários com cuidados mais complexos, foi a necessidade de apoio ao cuidador para desempenhar os cuidados, devido a rede de apoio familiar reduzida e a impossibilidade de desempenhar os cuidados sem o auxílio de uma segunda pessoa, por este motivo, o cuidador iniciou com um processo judicial para solicitar apoio do município.

A judicialização dos direitos sociais ocorre quando é negado ao cidadão o acesso à direitos previstos na constituição federal, ao acionar o judiciário em busca da efetivação de direitos sociais, às necessidades coletivas de enfrentamento às desigualdades sociais se transformam em uma busca individual por garantia de direitos legalmente previstos, e isso fortalece uma sobreposição do Poder Judiciário ao Poder Executivo, corroborando para a desresponsabilização do Estado e despolitização da esfera pública (Oliveira; Hora; Chaves, 2023).

Bertagnoli et al. (2021) trazem uma reflexão sobre as dificuldades encontradas pelos cuidadores, nas atividades que podem ser complexas e de difícil execução, e sugerem que os profissionais de saúde amparem eles tecnicamente e emocionalmente, compartilhando

conhecimentos, orientando e oferecendo segurança para os desenvolvimentos do cuidado domiciliar.

Deste modo reforça-se a importância da articulação em rede com possibilidade de garantir os direitos em tempo oportuno ao familiar e ao paciente em processo de desospitalização, pois é responsabilidade da Rede de Atenção à Saúde, através da referência e contrarreferência reforçar a integralidade e a continuidade do cuidado, caso não haja essa perspectiva do direito e da organização em rede com acesso aos serviços no processo da desospitalização, poderá ocorrer uma responsabilização das famílias, ocasionando uma sobrecarga ao cuidador que ficará exclusivamente responsável pelo planejamento e gestão do cuidado (Oliveira; Hora; Chaves, 2023).

Um estudo realizado na Irlanda e outro realizado na China, encontraram resultados muito semelhantes aos desta pesquisa.

O'Callaghan *et al.* (2024), analisaram a experiência de pessoas com AVC e cuidadores, em torno dos apoios oferecidos na transição do hospital para o domicílio na Irlanda, tanto o paciente, quanto os cuidadores relataram sentimentos de nervosismo, preocupação e incerteza, até felicidade e alívio. Enfrentavam coordenação fragmentada do cuidado, enfrentavam expectativas não atendidas quanto à continuidade do cuidado e suportavam longas esperas por serviços e apoios. As experiências dos participantes revelam falta de coordenação de cuidados durante toda a trajetória da transição para o domicílio. O planejamento desconexo levou a decisões fragmentadas.

Os pacientes e cuidadores foram excluídos das decisões sobre alta e cuidados contínuos, e muitos tiveram altas súbitas, levando a sentimentos de confusão e sensação de despreparo. Mesmo aqueles que se sentiram envolvidos no processo de planejamento da alta, eles passaram por falta de preparação prática. A falta de parcerias nos processos de definição de metas deixou os pacientes e cuidadores frustrados e com uma compreensão desconexa de sua trajetória após a alta (O'Callaghan *et al.*, 2024).

Destacaram os desafios na transição para o lar quando houve uma falha na comunicação entre profissionais de saúde e ambientes. O impacto da falta de coordenação do cuidado foi além da alta, pois nem os médicos de família nem a equipe de apoio receberam informações relevantes, por exemplo, sobre prescrições e cuidados de acompanhamento necessários, dificultando sua capacidade de apoiar a reabilitação e a recuperação. As expectativas de "continuidade" após a alta não foram atendidas, pois não foram feitos encaminhamentos para os serviços (O'Callaghan *et al.*, 2024);

Os pacientes expressaram insatisfação com os serviços comunitários genéricos após a alta, considerando-os inadequados para suas necessidades. Da mesma forma, os cuidadores sentiram que a falta de especialização em serviços comunitários impactava negativamente os pacientes para otimizar sua recuperação. em ambientes mais especializados (O’Callaghan *et al.*, 2024).

Sun *et al.* (2023) analisou as barreiras e facilitadores na transição do cuidado do hospital para o domicílio sob a perspectiva de pacientes idosos com doenças crônicas e profissionais de saúde na China.

À medida que os idosos enfrentavam a transição de uma unidade médica para um ambiente domiciliar não estruturado, alguns participantes expressaram um sentimento de incerteza e preocupação com o cuidado domiciliar. A comunicação entre o profissional de saúde e o paciente era vista como uma barreira quando diagnósticos médicos ou discussões sobre condições não eram apresentados de forma que o paciente pudesse compreender, ou quando havia muito termo técnico, também evidenciou a necessidade de melhorar a coordenação de cuidados entre diferentes unidades de saúde ou dentro de uma unidade de saúde, pois a má coordenação entre os profissionais de saúde leva a dificuldades na comunicação eficaz e na transferência de informações, e, conseqüentemente, na prestação de cuidados inconsistente e desatendida (Sun *et al.*, 2023).

Embora estudos internacionais demonstrem resultados semelhantes ao desta pesquisa, é importante destacar que o presente estudo foi realizado em município fronteiriço; o processo saúde-doença, na tríplice fronteira, apresenta características próprias relacionadas ao deslocamento de pessoas entre países, esse cenário está associado à contínua busca por recursos financeiros necessários à subsistência familiar, especialmente no que se refere à garantia das condições de vida por meio da utilização dos serviços de saúde (Feitosa; Martins; Jaqueira, 2020).

Embora os participantes desta pesquisa relataram moradia no Brasil, isso não muda os desafios dos serviços de saúde causados pelo contexto espacial em que estão inseridos, pois estudos indicam que as regiões de fronteira apresentam gargalos que impactam diretamente na oferta e no acesso dos serviços de saúde para a população fronteiriça.

Os serviços de saúde nas regiões de fronteiras no Brasil são comumente utilizados pelos moradores dos países vizinhos, isso pode gerar um aumento da demanda pelos serviços e uma sobrecarga dos serviços públicos de saúde, além de ser uma demanda não dimensionada,

geralmente, por se tratar de atendimentos de urgência não têm continuidade, o que dificulta inclusive a vigilância e o controle epidemiológico de doenças (Aikes; Rizzoto, 2020).

Melo *et al.* (2024) realizou uma pesquisa em região de tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru) que evidenciou desafios relacionados à gestão financeira e organizacional, pois o financiamento dos serviços de saúde é sobretudo proveniente dos repasses do Piso da Atenção Básica Fixo. O planejamento anual das ações de saúde é realizado com base no número da população residente no território de atuação, desta mesma maneira ocorre o financiamento para à infraestrutura das instituições de saúde do município, que não conseguem absorver a demanda excessiva proveniente da população local, somada ao fluxo de população estrangeira, resultando em situações como a escassez de recursos materiais, de profissionais, de serviços e de leitos para internação.

Deste modo alguns dos desafios e fragilidades descritos pelos cuidadores que participaram deste estudo podem estar relacionados com o contexto da fronteira, pois além dos gargalos no planejamento para a alta, comunicação, educação em saúde e encaminhamento ambulatorial, foi evidenciado problemas relacionados a falta de profissionais tanto nas equipes do SAD como na equipe da UBS, bem como dificuldades no acesso a materiais e medicamentos, podendo isto estar relacionado ao subfinanciamento da saúde no município onde a pesquisa ocorreu.

Este estudo apresenta limitações por ter sido realizado em um município de tríplice fronteira, um território com características singulares e podem não representar a realidade de outras regiões do país, também por não ter abrangido moradores dos países vizinhos, sendo indicado novos estudos na região de fronteira e em diferentes localidades do Brasil. Além disso, o estudo pode estar limitado pelo fato de ter incluído apenas cuidadores como participantes

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou que embora os profissionais atuem de forma empática, ocorrem falhas na transmissão de informações, especialmente quando o contato é realizado por estudantes, a ausência de planejamento estruturado para a alta hospitalar e a não inclusão efetiva do cuidador e do usuário nas decisões são barreiras recorrentes para a continuidade do cuidado seguro e humanizado.

Outro ponto crítico é a fragmentação das orientações para o cuidado domiciliar, muitas vezes baseadas em pressupostos sobre o conhecimento prévio do cuidador ou na experiência de internações anteriores. Isso resulta em lacunas na preparação para o cuidado, gerando insegurança no cuidador.

A dificuldade de acesso a medicamentos e materiais médico-hospitalares, aliada à insuficiência de encaminhamentos e à descontinuidade do acompanhamento após a alta, reforça a vulnerabilidade dos usuários e de seus cuidadores.

O SAD apresenta potencialidade em oferecer um cuidado humanizado, centrado na continuidade, no vínculo e na personalização da atenção à saúde, além disso, o cuidado domiciliar atende não apenas às necessidades clínicas, mas também a dimensões humanas fundamentais, como afeto, acolhimento, segurança e proteção, contribuindo para o fortalecimento da relação profissional-usuário. O estudo também aponta o SAD é percebido como essencial, suprimindo lacunas deixadas pela atenção básica, porém sobrecarregado e limitado pela falta de profissionais que deveriam integrar a equipe EMAD.

A sobrecarga do cuidador, a judicialização do acesso a direitos e a responsabilização das famílias pelo cuidado são consequências diretas das fragilidades do sistema de saúde, especialmente em regiões de fronteira, onde a demanda é ampliada pelo fluxo populacional e pelo subfinanciamento dos serviços.

Diante do exposto, evidencia-se que a desospitalização e a continuidade do cuidado são processos extremamente complexos, que evocam a urgência de medidas de integração entre as equipes assistenciais hospitalares, o usuário, o cuidador/ familiar e as redes de atenção básica. Para alcançar êxito nesses processos sugere-se medidas como: fortalecer o planejamento da alta hospitalar, com protocolos claros e participação ativa do paciente e do cuidador; investir em comunicação efetiva e educação em saúde, promovendo autonomia e segurança terapêutica; garantir acesso a recursos materiais e humanos suficientes para o cuidado domiciliar; valorizar e apoiar o cuidador, reconhecendo sua centralidade no processo de desospitalização; promover

articulação em rede e políticas públicas que assegurem a integralidade e continuidade do cuidado, especialmente nos contextos de fronteira que apresenta maior vulnerabilidade social e territorial.

Essas ações são fundamentais para que a transição do hospital para o domicílio ocorra de forma segura, humanizada e sustentável, minimizando riscos e promovendo a qualidade de vida dos usuários e de suas famílias.

Para ampliar a compreensão do tema deste estudo, sugere-se a realização de pesquisas futuras que envolvam os próprios usuários, os profissionais de saúde e os gestores responsáveis pelos serviços, tanto da esfera primária, quanto da secundária e terciária, com o objetivo de uma compreensão mais ampla que poderá auxiliar os gestores na definição de políticas que aprimorem a continuidade do cuidado integralmente em todas as esferas da atenção em saúde.

REFERÊNCIAS

AIKES, Solange; RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. A saúde em região de fronteira: o que dizem os documentos do Mercosul e Unasul. **Saúde e Sociedade**, v. 29, p. e180196, 2020.

AVELAR, João Marcos Borges; SCHNEIDER, Mirian Beatriz. A região transfronteiriça da tríplice fronteira e a construção de um projeto integrado de desenvolvimento. **DRd-Desenvolvimento Regional em debate**, 2019.

BERNARDI, Marianna Brisola; GONÇALVES, Amanda de Souza; BARBOSA, Samira Goldberg Rego; BERNAL, Suelen Cristina Zandonadi; PLANTIER, Gabriel Mendes; RODRIGUES, Thamires Fernandes Cardoso da Silva; RADOVANOVIC, Cremilde Aparecida Trindade. Vivência de cuidadores informais na transição de papéis após o processo de desospitalização. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 21, p. e61823, 2022.

BERTAGNOLI, Marina Simões Flório Ferreira; MELCHIOR, Matheus Issa; MONTI, Rafael Giffoni; KIMURA, Ricardo Akio. Desafios para a gestão compartilhada do cuidado na relação entre cuidadores e profissionais de uma equipe do Serviço de Atenção Domiciliar. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, p. e310113, 2021.

BOGLER, Paulo. **Com bolsa de R\$ 4,1 mil, Unioeste/Foz abre vagas para residência no Hospital Municipal**. H2Foz, 2024. Disponível em: <https://www.h2foz.com.br/saude/bolsa-4-mil-unioeste-residencia-hospital-municipal/>. Acesso em: 20 jul. 2024.

BORGES, Luciana Aparecida da Cunha; ALMEIDA, Rodrigo Guimarães dos Santos; BARBOZA, Elton Santo; ARRUDA, Guilherme Oliveira de. Treinamento por simulação de cuidadores na alta hospitalar do paciente com doenças crônicas: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e20230043, 2023.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jun. 2013. Seção 1, p. 5. Disponível em: <<https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>>. Acesso em: 26 set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm> Acesso em: 20 nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm> Acesso em: 26 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Desospitalização: reflexões para o cuidado em saúde e atuação multiprofissional**. Brasília, 2020. Disponível em: <<https://saude.gov.br>> Acesso em: 28 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 3.005, de 2 de janeiro de 2024**. Altera as Portarias de Consolidação nºs 5 e 6, de 28 de setembro de 2017. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.208, de 18 de junho de 2013. Dispõe sobre a integração do Programa Melhor em Casa com o Programa SOS Emergências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jun. 2013. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/dahu/atencao-domiciliar/legislacao/anos-anteriores/2013>. Acesso em: 30 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.533, de 16 de julho de 2012. Altera e acresce dispositivos à Portaria nº 2.527/GM/MS, de 27 de outubro de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jul. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/dahu/atencao-domiciliar/legislacao/anos-anteriores/2012>. Acesso em: 30 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016**. Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 abr. 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 30 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar. **Manual de monitoramento e avaliação da atenção domiciliar: Melhor em Casa**. Brasília, 2012. Disponível em: [manual_instrutivo_monitora_avaliacao_MELHOR EM CASA.pdf](#). Acesso em: 30 jun. 2024.

BURKE, Robert E.; KRIPALANI, Sunil; VASILEVSKIS, Eduard E.; SCHNIPPER, Jeffrey L. Moving Beyond Readmission Penalties: Creating an Ideal Process to Improve Transitional Care. An Official Publication of the Society of Hospital Medicine **Journal of Hospital Medicine** Vol 8 | No 2 | February 2013.

CARNIEL, Alexandra; MATOS, Silvana Pires de. Tríplice Fronteira Brasil, Argentina e Paraguai: integração comercial, social, econômica e cultural que expressam relações na escala local-global. In: KOZENIESKI, É. M., ed. **Trabalho de campo: contribuições do curso de Geografia Licenciatura da UFFS ao ensino e à pesquisa** [online]. Chapecó: Editora UFFS, 2022, pp. 293-311.

CARVALHO, Manoela de. A saúde coletiva e os territórios de fronteira. In: ZILLY, Adriana; SILVA, Rosane Meire Munhak da (orgs.). **Saúde pública na região da fronteira Brasil-Paraguai-Argentina**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. p. 13.

COLEMAN, Eric A.; PARRY, Carla; CHALMERS, Sandra; MIN, Sung-joon. The care transitions intervention: results of a randomized controlled trial. **Archives of internal medicine**, v. 166, n. 17, p. 1822-1828, 2006.

DANTAS, Eder Samuel Oliveira; AMORIM, Karla Patrícia Cardoso. Aspectos teórico-metodológicos em pesquisa qualitativa em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 5, p. 1589-1590, 2022.

DE SOUZA MINAYO, Maria Cecília. Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias. **Revista pesquisa qualitativa**, v. 5, n. 7, p. 1-12, 2017.

DOST, Léa Solh., GASTALDI, Giacomo., SCHNEIDER, Marie P. Patient medication management, understanding and adherence during the transition from hospital to outpatient care-a qualitative longitudinal study in polymorbid patients with type 2 diabetes. **BMC Health Services Research**, v. 24, n. 1, p. 620, 2024.

FEITOSA, Thiago Vinicius Neres; MARTINS, Wesley; JAQUEIRA, Manoela. O acesso à saúde em região fronteira: a tríplice fronteira Argentina, Brasil e Paraguai em meio à pandemia do coronavírus. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 4, n. 11, p. 28-41, 2020.

FOZ DO IGUAÇU. **Plano Municipal de Saúde 2022-2025**. Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2021. Disponível em: <<https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-3942&publicacao>>. Acesso em: 26 set. 2024.

FOZ DO IGUAÇU. Secretaria Municipal da Saúde. **Plano Municipal de Saúde 2010-2013**. Disponível em: <<https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-3942&publicacao>>. Acesso em: 26 set. 2024.

FOZ DO IGUAÇU. Secretaria Municipal da Saúde. **Relatório Anual de Gestão 2023/2024**. Disponível em: <<file:///C:/Users/ACER/OneDrive/Documentos/plano%20anual%202023%20foz.pdf>>. Acesso em: 25 jan. 2025.

FREIRE, Vanessa de Araujo Lima; CORREIA, Débora Lira; OLIVEIRA, Sherida Karanini Paz de. Transição do cuidado para domicílio da pessoa com Diabetes Mellitus: análise de conceito ancorada em Rodgers. **Cogitare Enfermagem**, v. 30, p. e97890pt, 2025.

GEOBLOGGER. **Limites e Fronteiras do Brasil**. 2015. Disponível em: <<https://professorridaltovaz.blogspot.com/2015/02/bacias-hidrograficas-do-brasil.html>>. Acesso em: 20 nov. 2024.

HAUM, Natália Dias Alves Públio; CARVALHO, Manoela de. Controle social do SUS: a saúde em região de fronteira em pauta. **Saúde e Sociedade**, v. 30, p. e200350, 2021.

HORTELAN, Michele dos Santos; ALMEIDA, Maria de Lourdes de; FUMINCELLI, Lais; ZILLY, Adriana; NIHEI, Oscar Kenji; PERES, Aínda Maris; SOBRINHO, Reinaldo Antônio; PEREIRA, Pedro Eduardo. Papel do gestor de saúde pública em região de fronteira: scoping review. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, p. 229-236, 2019.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foz do Iguaçu, Código: 4108304, 2023. **Site Oficial**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/foz-do-iguacu.html>>. Acesso em: 25 nov. 2024.

KLEIN, Kassielly; ISSI, Helena Becker; SOUZA, Neila Santini de; RIBEIRO, Aline Cammarano; SANTO, Érika Eberlline Pacheco dos; SENHEM, Graciela Dutra. Desospitalização de crianças dependentes de tecnologias: perspectiva da equipe multiprofissional de saúde. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 42, p. e20200305, 2021.

LEVAC, Danielle; COLQUHOUN, Heather; O'BRIEN, Kelly K. Scoping studies: advancing the methodology. **Implementation science**, v. 5, n. 1, p. 69, 2010.

MELO, Giane Zupellari Santos; ANDRADE, Selma Regina; COELHO, José Ilcleson Mendes; FUZA, Raquel Lins; SILVA, Antonia Mirely Inocencio da; NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro et al. Atendimento de saúde a residentes fronteiriços: construção de uma realidade a partir de valores éticos. **Saúde em Debate**, v. 48, p. e9301, 2024.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 01, p. 7-15, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. (Saúde em Debate, 46). ISBN 978-85-271-0181-3.

MIRANDA, Mateus de Souza; ALVES, José Carvalho; VILANOVA, Victor José Campelo; SOUSA, Gabriel Antônio Resende de; SILVA, Jones Roger Prestes da; ANDRADE, Tiago Campos et al. Desospitalização como perspectiva da assistência hospitalar no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 43, p. e11715-e11715, 2023.

MONDARDO, Marcos; STALIANO, Pamela. Saúde na Fronteira Brasileira: Políticas Públicas e Acesso a Serviços. **Espaço Aberto**, v. 10, n. 1, p. 99-116, 2020.

MUENTES, Carlos Alberto Soto. **Desafios e enfrentamentos do assistente social na desospitalização: um estudo de caso no Hospital Municipal Padre Germano Lauck em Foz do Iguaçu**. 2024. 73f. Trabalho de Conclusão de Curso (Serviço Social). Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Foz do Iguaçu – 2024.

O'CALLAGHAN, Geraldine; FAHY, Martin; O'MEARA, Sigrid; LINDBLOM, Sebastian et al. Experiences and preferences of people with stroke and caregivers, around supports provided at the transition from hospital to home: a qualitative descriptive study. **BMC neurology**, v. 24, n. 1, p. 251, 2024.

OLIVEIRA, Nayara Gomes de; HORA, Senir Santos da; CHAVES, Ana Raquel de Mello. A Desospitalização na Assistência Oncológica: um Debate acerca da Continuidade do Cuidado Familiar em Domicílio. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 69, n. 3, 2023.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. **Plano Estadual de Saúde: 2024-2027**. Curitiba: SESA, 2024. Disponível em: <<https://www.saude.pr.gov.br/planoestadual>>. Acesso em: 19 nov. 2024.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. **Plano Estadual de Saúde Paraná 2020-2023**. Curitiba: SESA, 2020. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/planoestadual>. Acesso em: 26 set. 2024.

PEREIRA, Ederson; CARVALHO, Manoela. Migração pendular e saúde: perfil de paraguaio em tratamento dialítico em município de fronteira internacional. **Revista Enfermagem Contemporânea**, v. 11, p. e3942-e3942, 2022.

PRIM, Camila Rodrigues *et al.* Campanha: 16 passos para a desospitalização segura. **BRASPEN Journal**, v. 38, n. 3, p. 0-0, 2023.

RAJÃO, Fabiana Lima; MARTINS, Mônica. Atenção Domiciliar no Brasil: estudo exploratório sobre a consolidação e uso de serviços no Sistema Único de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 5, p. 1863-1877, 2020.

ROSSETTO, Vanessa; TOSO, Beatriz Rosana Gonçalves Oliveira; RODRIGUES, Rosa Maria; MARCHETI, Maria Angélica. Organização de fluxo de desospitalização para a criança com necessidades especiais: estudo de validação. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. ISSN 2178-2091, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAS.e13475.2023>. Acesso em: 19 nov. 2024.

SANTOS, Jéssica Lane Pereira; PEDREIRA, Larissa Chaves; COIFMAN, Alyne Henri Motta; SANTOS, Jeferson Moreira dos; PESSOA, Larissa Simões da Cruz; SOUZA, Maria Antônia Alves de. Estratégias da equipe de enfermagem para o cuidado de idosos na transição hospital-domicílio: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 37, p. eAPE01904, 2024.

SCHAEFER, Eliane Luiza. Hospital Municipal Padre Germano Lauck firma-se como referência no Estado. **Almanaque Futuro**, 2024. Disponível em: <https://almanaquefuturo.com.br/foz-110-anos/hospital-municipal-padre-germano-lauck-firma-se-como-referencia-no-estado/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

SILVA, Kênia Lara; SILVA, Yara Cardoso; LAGE, Érika Guimarães; PAIVA, Patrícia Alves; DIAS, Orlene Veloso. Por que é melhor em casa? A percepção de usuários e cuidadores da atenção domiciliar. **Cogitare Enfermagem**, v. 22, n. 4, 2017.

SILVA, Rennan César; QUEIROZ, Maria Goretti; MAIA, Ludmila Grego. As perspectivas da desospitalização no Brasil e a assistência humanizada como coadjuvante neste processo: uma revisão de literatura. **Boletim Técnico Do Senac**, v. 47, n. 2, p. 114-126, 2021.

SOUSA, José Raul de; SANTOS, Simone Cabral Marinho dos. Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer. **Pesquisa e Debate em Educação**, Juiz de Fora: UFJF, v. 10, n. 2, p. 1396-1416, 2020.

SOUZA, Alessandra Cristina Conceição de; CC. ABRAHÃO, Ana Lucia da Silva; LEITE, Isabel Cristina de Moura; LOUREIRO, Rildo Santos. Planejamento de alta hospitalar na visão da enfermeira: relato da experiência. **Revista Pró-UniverSUS**, v. 14, n. 3, p. 122-127, 2023.

SOUZA, Marcio Costa de; PASSOS, Victória de Almeida; BORGES, Giovanna Santana Silva; CORREIA, Yasmin Victória Conceição; PIMENTEL, Magno Mercês Weyll; LEAL, Juliana Alves Leite et al. Barreiras enfrentadas no processo formativo de uma residência multiprofissional em saúde: um estudo na perspectiva da interprofissionalidade. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e19170-e19170, 2025.

SUGIURA, Silvia Yuri; CACERES, Nayla Tamara de Godoi; LACERDA, Maria Ribeiro; TONIN, Luana; RODRIGUES, Jessica Alline; PEREIRA, Nascimento, Jaqueline Dias. A vivência do contexto domiciliar por familiares e profissionais de saúde. **Rev. enferm. UFSM**, p. 304-319, 2018.

SUN, Mengje; QIAN, Yumeng; LIU, Lamei; WANG, Jianan et al. Transition of care from hospital to home for older people with chronic diseases: a qualitative study of older patients' and health care providers' perspectives. **Frontiers in Public Health**, v. 11, p. 1128885, 2023.

TOMAZELA, Marina; VALENTE, Silvia Helena; LIMA, Maria Alice Dias da Silva; FABRIZ, Luciana Aparecida; ZACHARIAS, Fabiana Costa Machado; BULGARELLI, Alexandre Fávero; PINTO, Ione Carvalho. Transição do cuidado de pessoas idosas do hospital para casa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, p. eAPE00291, 2023.

VALENTE, Silvia Helena; MACHADO, Fabiana Costa; FABRIZ, Luciana Aparecida; SCHÖNHOLZER, Tatiele Estefâni; FERRO, Denise; PINTO, Ione Carvalho. Percepções de pessoas idosas internadas acerca da transição do cuidado do hospital para casa. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e230194, 2024.

VALENTE, Silvia Helena; ZACHARIAS, Fabiana Costa Machado; FABRIZ, Luciana Aparecida; SCHÖNHOLZER, Tatiele Estefâni; FERRO, Denise; TOMAZELA, Marina; BARBOSA, Sara Maria; PINTO, Ione Carvalho. Transição do cuidado de idosos do hospital para casa: vivência da enfermagem. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p. eAPE02687, 2022.

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PORTUGUÊS

Número do Participante:	Data da Coleta:
I - Dados Sociodemográficos	
1. Iniciais do nome do participante: _____ 2. Gênero: ☐ Feminino ☐ Masculino 3. Nacionalidade: ☐ Brasileira ☐ Paraguaia ☐ Argentina ☐ Outra, especifique: _____ 4. Etnia: ☐ Branco ☐ Preto ☐ Pardo ☐ Amarelo ☐ outra, especifique: _____ 5. Idade: ☐ 18 – 29 anos ☐ 30 – 45 anos ☐ 46- 60 anos ☐ Mais de 60 anos 6. Grau de Escolaridade: ☐ Não alfabetizado ☐ Ensino Fundamental Incompleto ☐ Ensino Fundamental Completo ☐ Ensino Médio Incompleto ☐ Ensino Médio Completo ☐ Ensino Superior Incompleto ☐ Ensino Superior Completo 7. Estado civil: ☐ Solteiro ☐ Casado ☐ União estável ☐ Outro, especifique: _____ 8. Moradia: ☐ Aluguel ☐ Casa própria ☐ Casa cedida por familiares ou terceiros 9. País de residência: ☐ Brasil ☐ Paraguai ☐ Argentina ☐ Outro, especifique: _____ 10. Fonte de Renda: ☐ Desempregado ☐ Aposentado/ pensionista ☐ Emprego formal ☐ Emprego informal 11. Renda Familiar mensal (valor do salário-mínimo em 2024 - R\$ 1.412): ☐ Menos de 01 salário ☐ de 01 a 02 salários ☐ mais de 02 a 03 salários ☐ mais de 03 salários 12. Possui filhos ou dependentes: ☐ Sim, Se sim, quantos: ☐ Não	
II - Dados relativos à internação do usuário	
13. Data da admissão hospitalar: ____/____/____ 14. Data da alta: ____/____/____ 15. Fale sobre o histórico de saúde do usuário/ familiar, o que causou a internação e quais cuidados estão sendo desempenhados no domicílio. 16. Houve reinternação nos últimos 30 dias? Se sim, o que causou a reinternação?	

III - Questões Norteadoras**EIXO 1 - Planejamento de Alta e Comunicação.**

17. Em quais momentos da internação você esteve presente? Participou da admissão, período de internação e alta?
18. Comente como foi a abordagem do médico sobre a doença e tratamento. Você participou do planejamento dos cuidados e do tratamento que seria instituído?
19. Como foi o preparo para a alta? você foi informado sobre uma previsão de alta?
20. Comente como foi a sua comunicação com a equipe de saúde durante o período de internação? exemplifique?
21. Você conseguiu compreender as informações transmitidas pelo médico e a equipe de saúde sobre o tratamento e cuidados do seu familiar? Descreva como as informações foram repassadas?

EIXO 2 - Reconciliação e autogestão de medicamentos e Educação em saúde para o usuário e o cuidador/familiar.

22. Durante a internação você recebeu instruções sobre o uso dos medicamentos, como dose, via e intervalo de administração, tempo de tratamento e possíveis efeitos colaterais? Comente sobre isso.
23. Houve mudanças nos medicamentos de uso contínuo no período da internação? Se sim, você foi informado sobre as alterações no momento que ocorreram?
24. Durante o período da internação você recebeu algum tipo de treinamento específico para realizar os cuidados no domicílio? Explique como as informações foram repassadas.
25. Você considera que recebeu todas as orientações pertinentes para dar continuidade do cuidado no domicílio? Se não, na sua opinião, o que faltou?

EIXO 3- Continuidade do cuidado e Acompanhamento do paciente no pós-alta

26. No momento da alta do Usuário e/ou seu familiar você estava presente? Quais documentos foram fornecidos no momento da alta? por exemplo, relatório médico, receita e encaminhamento para retorno ambulatorial.
27. Na alta hospitalar do usuário e/ou seu familiar você teve acesso a todos os materiais necessários para a continuidade do tratamento no domicílio, como medicamentos, materiais para curativos, fralda, dieta enteral, sondagens etc.? explique.
28. Após a alta hospitalar ocorreu a visita domiciliar da equipe de saúde? Se ocorreu a visita, descreva como foi e deixe sua opinião, a visita trouxe benefícios?
29. Você conseguiu desempenhar os cuidados no domicílio ou teve dificuldades? Descreva como foi sua experiência nos cuidados no domicílio, se quiser pode relatar os pontos positivos e negativos.
30. Após a alta hospitalar, o usuário e/ou seu familiar teve acesso a acompanhamento/ consulta ambulatorial?

APÉNDICE B – GUÍA DE ENTREVISTA EN ESPAÑOL

Número de participante:	Fecha de recogida:
I - Datos Sociodemográficos	
1. Iniciales del participante: _____ 2. Género: ☐ Femenino ☐ Masculino 3. Nacionalidad: ☐ Brasileña ☐ Paraguaya ☐ Argentina ☐ Otro, especifique: _____ 4. Etnia: ☐ Blanco ☐ Negro ☐ Marrón ☐ Amarillo ☐ otro, especifique: _____ 5. Edad: ☐ 18 – 29 años ☐ 30 – 45 años ☐ 46 – 60 años ☐ Más de 60 años 6. Nivel de Educación: ☐ Analfabetos ☐ Educación primaria incompleta ☐ Educación primaria completa ☐ Educación secundaria incompleta ☐ Educación secundaria completa ☐ Educación superior incompleta ☐ Educación superior completa 7. Estado civil: ☐ Soltero ☐ Casado ☐ Conviviente ☐ Otro, especifique: _____ 8. Vivienda: ☐ Alquiler ☐ Casa propia ☐ Casa proporcionada por familiares o terceros 9. País de residencia: ☐ Brasil ☐ Paraguay ☐ Argentina ☐ Otro, especifique: _____ Fuente de ingresos: ☐ Desempleado ☐ Jubilado/pensionado ☐ Empleo formal ☐ Empleo informal Ingreso Familiar Mensual (valor del salario mínimo en 2024 - R\$ 1.412): ☐ Menos de 01 salario ☐ 01 a 02 salarios ☐ más de 02 a 03 salarios ☐ más de 03 salarios Tiene hijos o dependientes: ☐ Sí, en caso afirmativo, cuántos: ☐ No	
II - Datos relativos a la hospitalización del usuario	
13. Fecha de ingreso hospitalario: ____/____/____ 14. Fecha de alta: ____/____/____ 15. Hable sobre el historial de salud del usuario/familiar, qué causó la hospitalización y qué cuidados se están realizando en el hogar. 16. ¿Ha habido alguna readmisión en los últimos 30 días? Si es así, ¿qué causó la readmisión?	

III - Preguntas orientadoras
EJE 1 - Planificación y Comunicación del Alta.
17. ¿En qué momentos de la hospitalización estuvo usted presente? ¿Participó en el ingreso, hospitalización y alta? 18. Comentar el abordaje del médico ante la enfermedad y el tratamiento. ¿Participó usted en la planificación de la atención y el tratamiento que se instituirían? 19. ¿Cómo fue la preparación para el alta? ¿Le han informado de un pronóstico alcista? 20. ¿Comentario sobre su comunicación con el equipo de salud durante su período de hospitalización? dar un ejemplo? 21. ¿Pudo comprender la información transmitida por el médico y el equipo de salud sobre el tratamiento y cuidados de su familiar? Describe cómo se transmitió la información.
EJE 2 - Conciliación y autogestión de medicamentos y educación en salud para el usuario y el cuidador/familiar.
22. Durante su hospitalización, ¿recibió instrucciones sobre el uso de medicamentos, como dosis, vía e intervalo de administración, tiempo de tratamiento y posibles efectos secundarios? Comenta sobre esto. 23. ¿Hubo cambios en los medicamentos utilizados continuamente durante el período de hospitalización? Si es así, ¿fue usted informado sobre los cambios cuando ocurrieron? 24. Durante su periodo de hospitalización, ¿recibió algún tipo de formación específica para prestar cuidados domiciliarios? Explique cómo se transmitió la información. 25. ¿Considera que ha recibido todas las orientaciones pertinentes para continuar con los cuidados en casa? Si no, en su opinión, ¿qué faltaba?
EJE 3- Continuidad de la atención y seguimiento del paciente post-alto
26. Cuando el Usuario y/o su familiar, fue dado de alta, ¿estuvo usted presente? ¿Qué documentos se proporcionaron en el momento del alta? por ejemplo, informe médico, prescripción y derivación para retorno ambulatorio. 27. Al alta hospitalaria, el Usuario y/o su familiar tuvo acceso a todos los materiales necesarios para continuar el tratamiento en su domicilio, como medicamentos, material para vendajes, pañales, nutrición enteral, catéteres, etc ? explicar. 28. ¿Hubo visita domiciliaria del equipo sanitario tras el alta hospitalaria? Si la visita se realizó, describe cómo fue y deja tu opinión, ¿la visita trajo beneficios? 29. ¿Pudo realizar los cuidados domiciliarios o tuvo dificultades? Describe tu experiencia con la atención domiciliaria, si lo deseas puedes reportar los puntos positivos y negativos. 30. Después del alta hospitalaria, ¿el Usuario y/o su familiar tuvo acceso a seguimiento/consulta ambulatoria?

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Termo de consentimento Livre e Esclarecido – em português

Prezado (a) participante

Convidamos você a participar da pesquisa **“Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital público em região de tríplice fronteira, sobre a continuidade do cuidado e a atenção domiciliar”**, sendo responsável pela execução da coleta de dados a mestrande: Queila da Fonseca Pereira, orientada pela Professora Dra. Luciana Aparecida Fabriz. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa que tem a função de proteger eticamente os participantes da pesquisa.

O estudo tem por objetivo: *Analisar a transição do cuidado do hospital para a atenção domiciliar, na perspectiva de cuidadores de usuários que estiveram internados em unidade de clínica médica em um hospital público em região de tríplice fronteira.*

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa, por estar como cuidador de referência do seu familiar durante a internação em um hospital público em região de fronteira

A sua participação ocorrerá da seguinte maneira: Após a concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será realizado uma entrevista contendo 12 perguntas de caracterização sociodemográfica, 3 questões referentes ao período de internação e 15 perguntas sobre a sua experiência durante o processo de internação, alta e o cuidado no domicílio. As entrevistas poderão ocorrer de forma presencial ou online, pela plataforma Teams, ou aplicativo de whats App, conforme a disponibilidade do participante e do entrevistador, as entrevistas serão gravadas e transcritas na íntegra para posterior análise.

Você não terá nenhum gasto com a pesquisa e não será remunerada por sua participação na mesma. Sua participação é voluntária, sendo assim, não é obrigatória e você está livre para decidir se quer ou não participar em qualquer uma ou duas etapas, bem como, para retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizada de nenhuma forma caso não queira participar, mesmo que já tenha começado a responder as perguntas, você poderá parar a qualquer momento, tanto na primeira como na segunda fase. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você apresentada. Qualquer dado que possa identificá-la será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material armazenado em local seguro.

Caso você se sinta desconfortável, cansada ou constrangida, há a opção de interromper a entrevista a qualquer momento. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente,

você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito por meios de contato descritos neste termo. Ao final da pesquisa, todo o material será mantido em arquivo, por pelo menos cinco anos, conforme a resolução 466/2012 e orientações do Comitê de Ética em Pesquisa.

Informamos ainda que os resultados desta pesquisa têm objetivos acadêmicos/científicos e serão divulgados em trabalhos acadêmicos e em artigos científicos. Caso você queira se comunicar com a pesquisadora e assistentes, os endereços são: Foz do Iguaçu: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu, Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Jardim Universitário, 85851-100, Contato: Queila da Fonseca Pereira, Telefone/whatsapp: (45) 99846-2435.

Caso você precise informar algum fato, ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 15h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619, Bairro Universitário, Cascavel - PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Eu, _____ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. A pesquisadora certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Este documento que você vai assinar contém 2 páginas.

Você deve assinar este documento que está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua e a outra do pesquisador. Sugerimos que guarde a sua via.seguro.

Declaro que concordo em participar deste estudo, de uma ou das duas etapas previstas, mas estou ciente que posso desistir a qualquer momento. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido com a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas.

Foz do Iguaçu, __/__/2025.

APÉNDICE D – FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO

Formulario de Consentimiento Libre e Informado - en español

Estimado participante

Lo invitamos a participar de la investigación **“Percepción de los cuidadores de usuarios adultos atendidos en un hospital público de una región de triple frontera, sobre la continuidad del cuidado y el cuidado domiciliario”**, con la estudiante de maestría: Queila da Fonseca Pereira responsable de la realización del recolección de datos , guiada por la Profesora Dra. Luciana Aparecida Fabriz . Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación, que es responsable de proteger éticamente a los participantes de la investigación.

El estudio tiene como objetivos: *Analizar la transición de la atención hospitalaria a la atención domiciliaria, desde la perspectiva de cuidadores de usuarios que estuvieron internados en una unidad de clínica médica de un hospital público de una región de la triple frontera.*

Usted está siendo invitado a participar en la investigación, ya que es cuidador de referencia de su familiar durante la internación en un hospital público de una región fronteriza.

Su participación se producirá de la siguiente manera: Luego de aceptar y firmar el Formulario de Consentimiento Libre e Informado, se realizará una entrevista que contiene 12 preguntas sobre caracterización sociodemográfica, 3 preguntas referentes al período de hospitalización y 15 preguntas sobre su experiencia durante el proceso de hospitalización. , alta y atención domiciliaria.

No incurrirá en ningún costo por la investigación y no será remunerado por su participación en la misma. Su participación es voluntaria, por lo tanto, no es obligatoria y usted es libre de decidir si desea o no participar en una o dos etapas, así como de retirar su participación en cualquier momento. No serás penalizado de ninguna manera si no quieres participar, aunque ya hayas empezado a responder las preguntas, podrás parar en cualquier momento, tanto en la primera como en la segunda fase. Se garantizará la confidencialidad y privacidad de la información que envíe. Cualquier dato que pueda identificarlo se omitirá al publicar los resultados de la investigación y el material se almacenará en un lugar seguro.

Si se siente incómodo, cansado o avergonzado, tiene la opción de detener la entrevista en cualquier momento. En cualquier momento, durante la investigación, o posteriormente, usted

podrá solicitar información al investigador sobre su participación y/o la investigación, lo cual podrá realizar mediante los métodos de contacto descritos en este término. Al finalizar la investigación, todo el material se mantendrá en archivo por al menos cinco años, de acuerdo con la resolución 466/2012 y lineamientos del Comité de Ética en Investigación.

También le informamos que los resultados de esta investigación tienen objetivos académicos/científicos y serán publicados en trabajos académicos y artículos científicos. Si desea comunicarse con el investigador y los asistentes, las direcciones son: Foz do Iguaçu: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu, Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Jardim Universitário, 85851-100, Contacto.: Queila da Fonseca Pereira, Teléfono/Whatsapp: (45) 99846-2435.

Si necesita informar algún hecho, o derivado de su participación en la investigación y se siente incómodo en buscar al investigador, puede comunicarse con el Comité Permanente de Ética en Investigaciones con Seres Humanos de UNIOESTE (CEP), de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 3:30 pm, en la Rectoría de la UNIOESTE, sala del Comité de Ética, PRPPG, ubicada en Rua Universitária, 1619, Bairro Universitário, Cascavel - PR. Si lo prefiere, puede contactarnos vía Internet a través del correo electrónico: cep.prppg@unioeste.br o a través del teléfono del CEP (45) 3220-3092.

Yo, _____ fui informado de los objetivos de la investigación antes mencionados de manera clara y detallada y aclaré mis dudas. Sé que en cualquier momento puedo solicitar nueva información y motivar mi decisión si así lo deseo. El investigador me aseguró que todos los datos de esta investigación serán confidenciales. Este documento que firmará contiene 2 páginas.

Debe firmar este documento que se le presenta en dos copias, siendo una copia suya y otra del investigador. Le sugerimos que mantenga su seguro vía.

Declaro que estoy de acuerdo en participar en este estudio, en una o dos etapas previstas, pero soy consciente de que puedo retirarme en cualquier momento. Recibí una copia de este formulario de consentimiento informado con la oportunidad de leerlo y aclarar mis dudas.

Foz de Iguazú, __/__/2025.

ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

	TERMO NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA & EXTENSÃO			 FUNDAÇÃO MUNICIPAL
	AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA			
	Código: TERM.NEPE.002	Versão: 001 / Revisão: 001	Página 1 de 3	

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

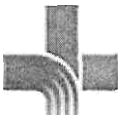
A Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, Iélita Santos, AUTORIZA o (a) pesquisador (a) Queila da Fonseca Pereira, mestranda em saúde pública em região de fronteira, da instituição Universidade Estadual do Oeste do Paraná a realizar a pesquisa, sob orientação do (a) professor (a) Dra. Luciana Aparecida Fabriz com o título “Percepção dos cuidadores de usuários adultos atendidos em um hospital público em região de tríplice fronteira, sobre a transição do cuidado e a atenção domiciliar”, no âmbito das dependências da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.

A pesquisa tem o objetivo analisar a transição do cuidado do hospital para a atenção domiciliar, na perspectiva de cuidadores de usuários que estiveram internados em unidade de clínica médica em um hospital público em região de tríplice fronteira, com a utilização do método: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. Os participantes serão identificados semanalmente por meio de uma lista fornecida pelo serviço de desospitalização do hospital contendo os dados de todos os usuários que receberam alta para o domicílio, sendo realizada uma busca em prontuário eletrônico para a seleção prévia dos participantes para o estudo. Após a seleção prévia, os cuidadores serão contactados por meio de ligação telefônica para solicitar se há interesse na participação da pesquisa. O período para contactar os cuidadores será de uma até quatro semanas após a alta do usuário, com o propósito de assegurar que o cuidador consiga recordar com precisão do momento da transição do cuidado do hospital para o domicílio. A entrevista será realizada por meio de um roteiro semiestruturado, as entrevistas serão gravadas se houver autorização dos participantes, após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Com os resultados esperados de identificar possíveis lacunas no processo da transição do cuidado e a atenção domiciliar através das experiências vividas pelos usuários do serviço e assim contribuir com o aprimoramento desta política buscando novas medidas assertivas para o cuidado humanizado e de qualidade.

Fica esta autorização condicionada à ciência e observação de cumprimento, pelo pesquisador e pela Instituição de Ensino, a coleta de dados não ter sido iniciada e que somente poderá ocorrer após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEP) pela instituição que frequenta via Plataforma Brasil. O pesquisador está ciente que, ao receber a autorização da pesquisa pelo CEP, deve entrar em contato com o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão para comunicar o início da coleta de dados.

Reforça-se a necessidade de o projeto estar adequado aos preceitos éticos estabelecidos pelas normativas CNS 466/2012 e CNS 580/2018, respeitando-se o sigilo das informações prestadas e o compromisso de não divulgação

Elaborado por: Núcleo de Ensino, Pesquisa & Extensão	Verificado por: Gestão de Qualidade	Aprovado por: Diretor Presidentes
Data da Elaboração: 17/10/2022	Próxima Revisão: 17/10/2024	Diretor Técnico Diretor Assistencial

	TERMO NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA & EXTENSÃO			 FUNDÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
	AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA			
	Código: TERM.NEPE,002	Versão: 001 / Revisão: 001	Página 2 de 3	

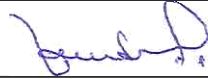
de dados para fins alheios à pesquisa acadêmica, assegurando a privacidade dos participantes da pesquisa e dos documentos contatados, garantindo-lhes o máximo de benefícios e o mínimo de riscos. O pesquisador também garante realizar a pesquisa com base na Lei n-º 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Também deverá haver devolutiva do resultado da pesquisa ao serviço de saúde onde foi desenvolvido o projeto.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente instrumento para que surta seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2025.



Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

Elaborado por: Núcleo de Ensino, Pesquisa & Extensão	Verificado por: Gestão de Qualidade	Aprovado por: Diretor Presidente 
Data da Elaboração: 17/10/2022	Próxima Revisão- 17/10/2024	Diretor Técnico Diretor Assistencial